

Bunga Rampai KEPERAWATAN KLINIK MODERN

Pendekatan Holistik dan Berbasis Bukti dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Najihah • Fransiska Tatto Dua Lembang • Ety Nurhayati
Jumilia • Muhammad Anwar Hafid

Editor: Dwi Suryani



BUNGA RAMPAI KEPERAWATAN KLINIK MODERN: PENDEKATAN HOLISTIK DAN BERBASIS BUKTI DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

Penulis:

Najihah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Fransiska Tatto Dua Lembang, S.Kep., Ns., M.Kes.
Ety Nurhayati, S.Kp., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat.
Ns. Jumilia, S.Kep, M.Kep., Ph.D.
Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes.

Editor:

Ns. Dwi Suryani, S.Kep., M.Kep.



Bunga Rampai Keperawatan Klinik Modern: Pendekatan Holistik dan Berbasis Bukti dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Penulis:

Najihah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Fransiska Tatto Dua Lembang, S.Kep., Ns., M.Kes.
Ety Nurhayati, S.Kp., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat.
Ns. Jumilia, S.Kep, M.Kep., Ph.D.
Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes.

Editor:

Ns. Dwi Suryani, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-51-6

Cetakan Pertama: Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Buku bunga rampai *Keperawatan Klinik Modern: Pendekatan Holistik dan Berbasis Bukti dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia* disusun sebagai kontribusi akademik dan praktis untuk memperkuat kapasitas perawat dalam menghadapi dinamika pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Perubahan pola penyakit, kemajuan teknologi, tuntutan mutu dan keselamatan pasien, serta kebutuhan masyarakat yang beragam menuntut praktik keperawatan yang tidak hanya terampil secara klinis, tetapi juga berlandaskan bukti ilmiah dan memandang pasien secara utuh—biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural. Melalui buku ini, para penulis berupaya menghadirkan pembahasan yang relevan dengan konteks Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, klinisi, pendidik, dan pengelola layanan dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.

Isi buku disajikan secara sistematis berdasarkan area praktik klinik utama. Chapter 1 mengulas **keperawatan medikal bedah** dengan fokus pada inovasi **manajemen nyeri** serta **perawatan luka**, yang menekankan pengambilan keputusan klinik berbasis asesmen dan evidence terkini. Chapter 2 membahas **keperawatan gawat darurat dan kritis**, meliputi konsep dasar, penerapan pendekatan holistik dan evidence-based practice, **PPGD**, **triage**, hingga pentingnya **kolaborasi tim resusitasi**, disertai penekanan pada keselamatan pasien dan etika dalam situasi emergensi. Chapter 3 menyoroti **keperawatan maternitas** melalui pelayanan holistik pada ibu hamil, masa nifas, dan bayi baru lahir, termasuk integrasi pendekatan holistik, kolaborasi interprofesional, serta strategi implementasi berbasis bukti yang aplikatif di layanan.

Selanjutnya, Chapter 4 menguatkan dimensi kesehatan mental melalui bahasan **keperawatan jiwa**, mencakup **manajemen stres**, **ansietas**, dan ragam pendekatan terapi keperawatan yang dapat membantu pemulihan dan kualitas hidup pasien. Chapter 5 menghadirkan paradigma baru intervensi keperawatan pada **penyakit kronis dan degeneratif**, dengan landasan **Chronic Care Model**, peran strategis perawat pada penyakit spesifik seperti **hipertensi**, integrasi intervensi non-farmakologis seperti konseling nutrisi, penguatan manajemen dalam struktur layanan, hingga pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam asuhan. Besar harapan kami, bunga rampai ini dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik—mendorong perawat Indonesia untuk terus adaptif, reflektif, dan profesional dalam memberikan pelayanan yang holistik, aman, serta berbasis bukti demi hasil kesehatan yang lebih baik.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

CHAPTER 1 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH: INOVASI MANAJEMEN

NYERI, LUKA DAN PERAWATAN LUKA 1

Najihah, S.Kep., Ns., M.Kep.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Manajemen Nyeri.....	1
C. Perawatan Luka.....	7
D. Simpulan.....	12
E. Referensi.....	13
F. Glosarium.....	15

CHAPTER 2 KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN KRITIS: PPGD,

TRIAGE, DAN KOLABORASI TIM RESUSITASI..... 17

Fransiska Tatto Dua Lembang, S.Kep., Ns., M.Kes.	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Konsep keperawatan gawat darurat dan kritis.....	18
C. Pendekatan Holistik dan Evidence-Based Practice	21
D. Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD).....	23
E. Triage dalam Pelayanan Gawat Darurat.....	24
F. Kolaborasi Tim Resusitasi.....	24
G. Keselamatan Pasien dan Etika Keperawatan Gawat Darurat.....	24
H. Simpulan.....	25
I. Referensi.....	26
J. Glosarium.....	28

CHAPTER 3 KEPERAWATAN MATERNITAS: PELAYANAN HOLISTIK PADA

IBU HAMIL, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR..... 31

Ety Nurhayati, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat.	31
A. Urgensi Pelayanan Holistik dalam Keperawatan Maternitas di Indonesia	31
B. Integrasi Pendekatan Holistik pada Masa Kehamilan, Nifas, dan Neonatal	31
C. Kolaborasi Interprofesional	40

D. Strategi Implementasi Pelayanan Holistik Berbasis Bukti.....	43
E. Penutup	44
F. Referensi.....	47

CHAPTER 4 KEPERAWATAN JIWA: MANAJEMEN STRES, ANSIETAS DAN PENDEKATAN TERAPI KEPERAWATAN.....51

Ns. Jumilia, S.Kep., M.Kep., Ph.D.....	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Manajemen Stres.....	53
C. Ansietas.....	59
D. Pendekatan Terapi Keperawatan Jiwa	62
E. Referensi.....	65
F. Glosarium.....	66

CHAPTER 5 PARADIGMA BARU INTERVENSI KEPERAWATAN DALAM MANAJEMEN PENYAKIT KRONIS DAN DEGENERATIF67

Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes.	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Landasan Teoretis: Model Perawatan Kronis (<i>Chronic Care Model</i>)	69
C. Peran Strategis Perawat dalam Penyakit Spesifik)	71
D. Hipertensi: Manajemen Gaya Hidup dan Farmakoterapi	73
E. Konsep Dasar: Konseling Nutrisi sebagai Intervensi Terapeutik Non-Farmakologis.....	74
F. Integrasi Manajemen dalam Struktur Organisasi Layanan (FGI).....	79
G. Teknologi dan Inovasi dalam Asuhan Keperawatan.....	81
H. Kesimpulan	84
I. Referensi.....	86

PROFIL PENULIS93

CHAPTER 1

KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH: INOVASI MANAJEMEN NYERI, LUKA DAN PERAWATAN LUKA

Najihah, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Nyeri lebih dari sekadar gejala suatu masalah, tetapi nyeri dapat menjadi masalah prioritas tinggi. Nyeri menghadirkan bahaya fisiologis dan psikologis bagi kesehatan dan pemulihan. Manajemen nyeri adalah pengurangan rasa sakit atau pengurangan nyeri hingga tingkat kenyamanan yang dapat diterima oleh klien. Manajemen nyeri yang efektif merupakan aspek penting dari perawatan keperawatan untuk meningkatkan penyembuhan, mencegah komplikasi, mengurangi penderitaan, dan mencegah perkembangan kondisi nyeri yang tidak dapat disembuhkan. Selain itu, manajemen nyeri yang efektif meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketidaknyamanan fisik, mendorong mobilisasi lebih dini dan kembali ke tingkat aktivitas fungsional dasar sebelumnya, menghasilkan kunjungan rumah sakit dan klinik yang lebih sedikit, dan mengurangi lama rawat inap di rumah sakit, sehingga dapat menurunkan biaya perawatan kesehatan.

Selain nyeri, masalah yang sering ditemui dalam proses perawatan yaitu Luka. Pada dasarnya, luka terjadi ketika integritas permukaan tubuh terganggu, mengakibatkan terbukanya jaringan terhadap lingkungan luar dan berpotensi terpapar infeksi, perdarahan, dan gangguan penyembuhan. Gangguan integritas kulit bukanlah masalah yang sering terjadi pada sebagian besar individu sehat, tetapi merupakan ancaman bagi lansia; bagi klien dengan mobilitas terbatas, penyakit kronis, atau trauma; dan bagi mereka yang menjalani prosedur perawatan kesehatan invasif. Perawatan luka modern merupakan pendekatan yang berfokus pada penyembuhan optimal dengan mempertimbangkan aspek fisiologis, psikologis, sosial, dan ekonomi pasien. Dibandingkan pendekatan tradisional yang hanya menekankan pada menutup luka atau mencegah infeksi, perawatan luka modern memiliki tujuan yang lebih luas, holistik, dan berbasis bukti ilmiah.

B. Manajemen Nyeri

Inovasi manajemen nyeri terkini berfokus pada pendekatan minimal invasif, teknologi digital, dan metode non-farmakologis untuk mengurangi ketergantungan

obat serta mempercepat pemulihan. Inovasi ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan meminimalkan efek samping farmakologis dan mempercepat proses pemulihan. Salah satu inovasi manajemen nyeri yang telah berkembang yaitu *Virtual Reality* (VR)

1. Defenisi

VR adalah teknologi yang memberikan kesan pada penggunanya dapat berinteraksi terhadap suatu objek grafis dengan visualisasi 3D atau gambar berhologram yang di simulasikan oleh komputer. Sesuai dengan penamaannya, VR adalah realitas maya dengan penggambaran yang mendekati keadaan real/nyata. Dalam VR, pengguna bisa berinteraksi dengan lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Lingkungan dalam VR bisa jadi meniru lingkungan asli atau hanya ada dalam imajinasi.

VR adalah teknologi yang menciptakan lingkungan tiga dimensi interaktif dengan bantuan kacamata khusus dan perangkat audio. Pasien dibawa masuk ke dunia maya yang penuh pemandangan menarik, suara alami, dan elemen interaktif, sehingga perhatian mereka teralihkan dari rasa nyeri yang dirasakan.

VR suatu teknologi baru dimana untuk merelaksasikan diri dengan menggunakan proyeksi dari suatu gambar kemudian menghasilkan bentuk tiga dimensi (3D) dimata pasien serta menghalangi rangsangan dari visual ataupun rangsangan dari pendengaran didunia nyata sehingga nyeri yang ditimbulkan pasien akan berkurang karena teralihkan oleh teknologi VR ini. Tujuan teknologi dari VT ini mengurangi persepsi nyeri, mengurangi tingkat kecemasan, dan memberikan kesan sedang berada di dunia tiga dimensi dengan suasana yang berbeda dari suasana sebenarnya. VR dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer, headset binokular, dan pelacakan gerakan dimana tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman yang baik.

2. Tampilan VR

Tampilan VR yang digunakan yaitu Imersif Penuh (*Head-Mounted Display-HMD*), dengan menggunakan headset khusus yang menutupi pandangan mata dan memberikan pengalaman 360 derajat sepenuhnya yang seringkali didukung dengan musik volume sedang melalui headphone untuk efek relaksasi maksimal.

Tampilan VR untuk manajemen nyeri umumnya menggunakan lingkungan virtual 3D yang imersif dan interaktif, seperti pemandangan alam (salju, hutan, bawah laut) atau game ringan, untuk mengalihkan perhatian otak dari sinyal nyeri. Contoh Tampilan VR untuk Nyeri:

a. Lingkungan Alam Interaktif

Pemandangan 360 derajat seperti gua es, bukit, atau pemandangan salju di mana pasien dapat melihat ke atas, bawah, kiri, dan kanan.

b. Permainan Sederhana

Game interaktif di dalam VR, seperti melempar ikan ke berang-berang atau memukul objek, yang memberikan distraksi tanpa kekerasan.

c. Visualisasi Menenangkan

Lingkungan virtual bawah laut atau pemandangan hutan yang lambat dan konstan untuk menurunkan detak jantung dan relaksasi.

d. Simulasi Medis Virtual

Penggunaan VR untuk fisioterapi atau latihan fisik yang dikemas dalam bentuk permainan, menjadikan proses pemulihan lebih menyenangkan.



Gambar 1.1: *The Genesis of VR in Pain Management: SnowWorld*

Sumber: (SyncVR Medical, 2026)



Gambar 1.2: *Forest of serenity VR application*

Sumber: (Groninger, Stewart, Fisher, & Tefera, 2021)

3. Mekanisme Kerja

Cara kerja VR adalah menciptakan simulasi dunia digital 3D yang imersif, menggantikan pandangan dunia nyata menggunakan headset khusus. Headset ini menggunakan layar beresolusi tinggi dan lensa untuk memproyeksikan gambar, sementara sensor gerak (ineresia/kamera) melacak pergerakan kepala pengguna secara real-time untuk menyesuaikan tampilan, menciptakan pengalaman seolah-olah berada di dalam dunia maya tersebut. Berikut adalah mekanisme detail cara kerja VR:

a. Pemrosesan Visual & Audio (Layar & Lensa)

TeamViewer menjelaskan bahwa VR menggantikan lingkungan fisik dengan simulasi digital yang disesuaikan dengan pandangan mata. Lensa dalam headset memproyeksikan gambar stereoskopik (3D) ke mata pengguna, menciptakan kedalaman yang realistis, didukung oleh audio 3D untuk meningkatkan imersi.

b. Pelacakan Gerakan (*Motion Tracking*)

Sensor canggih pada headset melacak gerakan kepala (menoleh, menunduk, mendongak) secara instan. Jika pengguna bergerak, sensor mengirim data ke komputer atau prosesor internal untuk memperbarui visual gambar seketika, sehingga pandangan di VR mengikuti gerakan kepala pengguna.

c. Interaksi (*Controller & Haptic*)

Pengguna berinteraksi dengan lingkungan virtual menggunakan kontroler genggam atau pelacakan tangan (*hand tracking*) yang mendeteksi tindakan seperti mengambil atau melempar benda. Beberapa sistem VR menyertakan umpan balik haptic (getaran) untuk memberikan sensasi taktil, membuat pengalaman lebih nyata.

d. Latensi Rendah

Agar tidak menimbulkan rasa pusing, sistem VR harus memiliki latensi (jeda) yang sangat rendah antara gerakan kepala dan pembaruan visual, memastikan respon yang mulus.

Secara ringkas, VR bekerja dengan memadukan perangkat keras (headset, sensor, kontroler), perangkat lunak (grafis 3D), dan respon sensorik untuk menipu pikiran pengguna agar percaya mereka berada di lingkungan virtual.

4. Efek Samping

VR merupakan terapi tambahan yang aman dan relatif bebas dari efek samping yang berdampak pada tubuh pasien. Tetapi dunia mayalah yang menjadi dampak negatif utamanya, seperti munculnya ketegangan mata dan

sakit leher karena penggunaan jangka panjang yang sulit teratasi karena virtual reality sendiri menggunakan headset dimana semua orang yang menggunakan teknologi ini akan melibatkan layar yang ditempatkan dengan jarak beberapa sentimeter dari depan mata. Dengan adanya ketegangan mata ini tentunya harus ada batas penggunaan yang efektif, penggunaan yang praktis dan efektif adalah setengah jam atau lebih satu jam. Selain ketegangan mata dampak yang lain sulit jika digunakan didalam rumah karena teknologi ini menggunakan proyektor dengan ruangan yang berukuran besar, dan teknik memproyeksikan gambar retina bersifat eksperimental. Adapun efek utama penggunaan virtual reality salah satunya muncul gangguan lain seperti gangguan keterlibatan kognitif atau merelaksasikan. VR melibatkan pasien dalam aktivitas untuk menghilangkan pengalaman atau rasa nyeri yang ditimbulkan secara langsung. Adapun efek atau dampak lain yang ditimbulkan dalam penggunaan VR pada nyeri kronis meliputi sakit kepala, pusing, mual dan timbul rasa gatal yang disebabkan oleh dermatitis atopik dan psoriasis vulgaris.

5. *Evidence Based Practice*

VR merupakan pendekatan analgesic noninvasif, bebas obat dan ramah penggunaan. Secara umum beberapa systematic review menyimpulkan bahwa teknologi VR teknologi ini menunjukkan potensinya untuk mengelola berbagai kondisi yang berhubungan dengan nyeri. Dalam hal aplikasi klinis, beberapa studi menunjukkan bahwa VR efektif sebagai terapi nyeri tambahan atau alternatif dalam berbagai prosedur yang menimbulkan nyeri dan dalam pengelolaan nyeri kronis pada anak-anak maupun orang dewasa.

VR menunjukkan kemanjurannya untuk mengelola berbagai kondisi nyeri termasuk nyeri akut selama prosedur dan nyeri terkait operasi serta berbagai kondisi nyeri kronis, seperti fibromyalgia, sindrom anggota tubuh fantom, nyeri punggung bawah dan leher kronis, dan kondisi nyeri terkait kanker. VR juga dapat direkomendasikan untuk mengelola nyeri dan kecemasan pada pasien anak yang menjalani berbagai prosedur yang menyakitkan.

Dalam pengelolaan nyeri akut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa VR telah digunakan untuk manajemen nyeri akut yang meluas ke area seperti perawatan luka dan fisioterapi, prosedur pra dan pasca operasi misalnya mengurangi nyeri di bawah anestesi lokal, perawatan gigi, termoterapi gelombang mikro transuretral, dan venepuncture pada pasien anak serta diterapkan untuk mengelola nyeri persalinan.

Aplikasi VR juga telah dieksplorasi untuk mengelola nyeri kronis, yaitu nyeri persisten yang berlangsung lebih lama dari periode penyembuhan atau lebih dari

3 bulan. Nyeri kronis dapat berasal dari penyebab yang tidak diketahui misalnya fibromyalgia, atau dapat timbul dari cedera (trauma, operasi, stroke), penyakit (misalnya diabetes, multiple sclerosis, dan kanker) dan obat-obatan (misalnya obat antikanker). Sebuah systematic review mengungkapkan berbagai variabel hasil yang dipengaruhi oleh intervensi teknologi VR, dengan pengurangan nyeri yang signifikan secara statistik dan peningkatan fungsi. Hal ini menunjukkan bahwa VR tidak hanya memiliki aplikasi dalam manajemen nyeri akut tetapi juga dalam pengaturan nyeri kronis, sehingga VR mungkin dapat menjadi intervensi lini pertama yang menjanjikan sebagai terapi komplementer untuk pasien dengan nyeri kronis.

VR dapat beroperasi pada berbagai tingkatan, untuk memediasi pengalihan perhatian sederhana, pergeseran fokus, atau pengaturan diri terhadap rasa sakit. Mekanisme VR dapat menurunkan nyeri melalui simulasi yang dihasilkan komputer dari objek atau lingkungan tiga dimensi dengan interaksi pengguna yang tampak nyata, langsung, atau fisik. VR saat ini menggunakan komputer dan perangkat yang dapat digunakan untuk memberikan ilusi kepada pengguna seolah-olah tenggelam atau hadir di dunia virtual sehingga memberikan efek distraksi. Ketika VR yang disesuaikan dengan tingkat fungsi pasien berkembang dalam intensitas yang baik, hal ini membuat pasien larut dalam aplikasi yang membuat dampak positif bagi manajemen diri.

VR menawarkan pengalaman imersif yang dapat mensimulasikan berbagai lingkungan. Mekanisme yang disarankan dari VR dalam manajemen nyeri terutama mencakup peningkatan pengalihan perhatian dengan menarik perhatian pasien dan mengaktifkan banyak indera. Lingkungan virtual menggunakan sistem pelacakan kepala, umpan balik taktil, dan sensasi visual dan auditori yang sangat merangsang. Dengan cara ini, individu menjadi tengimmersed dalam dunia virtual, mengalihkan perhatian dari persepsi nyeri. Sehingga diduga bahwa program VR sebagai pengalih perhatian, mengurangi sensasi nyeri sadar melalui jalur sinyal yang mengarah ke nyeri. Oleh karena itu, realitas virtual dapat mengubah perilaku sistem modulasi nyeri dengan menurunkan konsentrasi pada nyeri sehingga stimulus tidak dirasakan sebagai nyeri. Dengan mengaktifkan korteks visual dan mengintegrasikan indera tambahan, realitas virtual mengubah penanganan rangsangan nosiseptif. Pencitraan resonansi magnetik fungsional otak (fMRI) telah mengkonfirmasi bahwa VR memengaruhi korteks insula dan sensorik serupa dengan opiate

Dalam lingkungan virtual imersif, seseorang merasakan kehadiran, yaitu merasa seolah-olah benar-benar berada di sana. Tingkat kehadiran bergantung pada fitur VR yang diberikan kepada pengguna. Misalnya, melihat bagian tubuh

seseorang seperti tangan yang terwujud di dunia virtual dan memblokir suara dari dunia fisik, dapat menyebabkan pengalaman psikologis yang kuat bahwa seseorang berada di dunia virtual daripada dunia fisik tempat prosedur yang menyakitkan dilakukan. Perasaan kehadiran ini bisa sangat kuat dan mengurangi kemampuan seseorang untuk merespons rangsangan berbahaya dan memperhatikan sinyal saraf nosiseptif, yang mengakibatkan persepsi nyeri yang lebih rendah. Mekanisme ini digambarkan sebagai pengalihan perhatian, yang digunakan untuk memodulasi nyeri dalam VR.

VR adalah metode non-farmakologis yang efektif dan praktis dalam manajemen nyeri. Dibandingkan dengan metode pengelolaan nyeri tradisional, terapi VR memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan, non-invasif, dan minim efek samping sehingga mengurangi ketergantungan dari analgetik maupun opioid. Meski demikian, pendekatan kombinasi yang menggabungkan VR dengan metode farmakologis atau terapi lain sering kali memberikan hasil terbaik. Karena mahal, sistem VR memiliki penggunaan yang terbatas, tetapi dengan meningkatnya penggunaan ponsel beresolusi tinggi, VR telah menjadi alat yang lebih mudah beradaptasi dan diakses untuk meredakan nyeri. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, VR memiliki potensi besar untuk menjadi bagian integral dari protokol perawatan rumah sakit.

C. Perawatan Luka

Inovasi perawatan luka modern berfokus pada teknik *moist wound healing*, teknologi canggih, dan bahan alami untuk mempercepat penyembuhan kronis. Pendekatan ini berfokus pada holistic wound care, termasuk manajemen nutrisi dan komorbiditas untuk hasil optimal. Saat ini, perawatan luka berada pada era teknologi tinggi dengan pendekatan biologis antara lain terapi berbasis tekanan negatif yang dikenal dengan *Negative Pressure Wound Therapy* (NPWT)

1. Defenisi

NPWT dikenal sebagai teknik non-invasif yang merupakan sistem balutan luka menggunakan perangkat yang menghasilkan tekanan subatmosfer di seluruh area luka berkisar antara 50 hingga 150 mmHg. Teknologi ini menggunakan tekanan negatif untuk menghisap eksudat, meningkatkan perfusi jaringan, dan merangsang pembentukan jaringan granulasinya. Tekanan dapat dihasilkan secara terus menerus atau terputus-putus, sehingga menyebabkan drainase sekresi luka, peningkatan perfusi jaringan, yang pada akhirnya membantu penyembuhan kerusakan jaringan melalui kontraksi luka dan stimulasi proliferasi jaringan granulasi.

2. Mekanisme Kerja

NPWT melibatkan penggunaan spons atau kasa khusus yang ditempatkan di dalam luka, kemudian ditutup rapat dengan film transparan kedap udara. Selanjutnya, perangkat vakum terhubung dengan sistem tersebut untuk menciptakan tekanan negatif secara kontinu atau intermiten. Tekanan ini membantu menarik cairan luka, eksudat, serta bakteri dari area luka ke dalam wadah penampung, sehingga mengurangi edema, meningkatkan aliran darah lokal, dan merangsang pembentukan jaringan granulasi.

3. Manfaat NPWT

Beberapa manfaat utama dari NPWT antara lain:

- a. Mempercepat penyembuhan luka.
Dengan mengurangi kelembapan berlebih dan menjaga luka dalam kondisi optimal, terapi ini mempercepat regenerasi jaringan.
- b. Mengurangi risiko infeksi.
Penarikan eksudat dan bakteri dari luka membantu mencegah infeksi sekunder.
- c. Menstimulasi pertumbuhan jaringan granulas.
Tekanan negatif merangsang sel fibroblas dan angiogenesis, penting dalam pembentukan jaringan baru.
- d. Mengurangi ukuran luka.
Secara mekanik, tekanan negatif menarik tepi luka mendekat, membantu menutup luka lebih cepat.
- e. Meningkatkan kenyamanan pasien.
Dibandingkan dengan pembalutan tradisional yang harus sering diganti, NPWT dapat dipertahankan selama beberapa hari, mengurangi nyeri dan gangguan pada luka.

4. Kontraindikasi

Terapi ini juga memiliki kontraindikasi, antara lain luka dengan jaringan nekrotik yang luas tanpa debridemen, luka dengan perdarahan aktif, luka dengan fistula yang tidak jelas asalnya, serta luka yang dekat dengan struktur vital seperti pembuluh darah besar atau organ dalam.

a. Keganasan

Tekanan subatmosfer yang dihasilkan oleh perangkat VAC diduga merangsang tumorigenesis melalui mekanisme yang sama dengan mekanisme yang mendorong penyembuhan luka (mikrodeformasi yang mendorong proliferasi sel dan angiogenesis). Neoplasma juga lebih rentan terhadap

perdarahan karena sifatnya yang rapuh. Eksisi lengkap jaringan ganas harus dilakukan sebelum mempertimbangkan terapi VAC.

b. Struktur Vital yang Terpapar

Penerapan NPWT langsung pada organ vital, pembuluh darah, dan cangkok vaskular dapat menyebabkan fistulasi, erosi, dan perdarahan. Komplikasi tersebut dapat dicegah dengan memastikan penutupan struktur vital dengan jaringan granulasi, cangkok, atau flap.

c. Jaringan Iskemik

Revaskularisasi harus diselesaikan sebelum menggunakan terapi VAC. Hal ini dikarenakan tekanan subatmosfer yang diterapkan pada luka secara sementara mengurangi perfusi luka, sehingga memperburuk tingkat iskemia.

d. Kulit Rapuh

Usia lanjut, penggunaan kortikosteroid, gangguan kolagen, dan alergi perekat dapat menyebabkan melemahnya kulit. Kulit tipis lebih rentan terhadap gesekan saat mengangkat penutup perekat selama penggantian perban.

e. Jaringan Terinfeksi atau Mati

Debridemen yang memadai pada jaringan yang mati harus dilakukan sebelum memulai terapi VAC. Idealnya, pengobatan infeksi harus dilakukan sebelum menggunakan NPWT. Namun, kolonisasi luka ringan dapat diobati dengan sukses menggunakan terapi VAC yang dikombinasikan dengan terapi instilasi.

5. Komplikasi

NPWT dianggap sebagai pendekatan yang aman dan jarang menyebabkan komplikasi. Namun, beberapa komplikasi dengan berbagai tingkat keparahan dapat disebabkan oleh teknik yang buruk atau pemilihan pasien yang tidak tepat. Dengan kata lain, sebagian besar kejadian buruk yang terkait dengan terapi VAC dapat dicegah

a. Komplikasi berat

1) Sindrom Syok Toksik

Beberapa studi kasus melaporkan adanya Sindrom syok toksik yang disebabkan oleh penggunaan terapi VAC. Cara paling efektif untuk mencegah komplikasi serius ini adalah dengan memastikan luka bersih dan sehat sebelum memasang alat VAC, dan alat tersebut diganti secara berkala.

2) Fistula Enterik

Sebuah penelitian melaporkan bahwa terdapat beberapa pasien mengalami fistula usus sekunder akibat terapi VAC yang digunakan untuk

luka laparotomi mereka. Insiden fistula enterik meningkat secara signifikan ketika balutan busa VAC diaplikasikan langsung di atas organ yang terpapar. Oleh karena itu, jaring biologis atau sintetis yang dapat diserap harus ditempatkan di antara busa dan organ sebagai perantara untuk mencegah fistulasi.

3) Ketidakstabilan Hemodinamik

Ketidakstabilan hemodinamik kadang terjadi, tergantung pada ukuran dan lokasi luka. Hal ini terjadi ketika sejumlah besar cairan disedot selama beberapa hari pertama terapi VAC.

b. Komplikasi Ringan

Komplikasi ini terjadi pada 25% pasien pengguna NPWT. Komplikasi tersebut antara lain perdarahan, nyeri, luka berbau, infeksi dan kerusakan pada jaringan sekitar pemasangan,

6. *Evidence Based Practice*

Terapi NPWT telah terbukti efektivitasnya di kalangan tenaga kesehatan, dan pada akhirnya mendorong pengembangan berbagai terapi canggih baru seperti NPWT dengan Instilasi (NPWTi-d), *Cleanse Choise* dalam sistem VAC, dan NPWT insisi/ sayatan tertutup.

Manajemen luka terus berkembang sejak pengembangan NPWT. Banyak publikasi telah menunjukkan penggunaan NPWT untuk meningkatkan penyembuhan luka di berbagai bidang klinis, seperti untuk ulkus kaki diabetik, luka tekan, luka kronis, dan cangkuk kulit.

Terapi ini efektif melalui empat mekanisme kerja dominan:

a. Makrodeformasi

Tekanan subatmosfer yang diterapkan pada spons memiliki efek mengurangi ukurannya hingga sekitar 80%. Mengingat spons tersebut melekat erat pada tepi luka, hal ini mengakibatkan pengurangan luas permukaan luka. Penyusutan tiga dimensi ini bergantung pada kemampuan deformasi jaringan di sekitarnya, yang menjelaskan mengapa luka yang dikelilingi oleh kulit berlebih yang kendur akan menyusut lebih cepat dibandingkan dengan luka yang terletak pada permukaan dengan tegangan tinggi, seperti kulit kepala.

b. Drainase cairan

Hisapan yang diberikan oleh sistem *Vacuum-assisted closure* (VAC) membantu menghilangkan cairan ekstraseluler yang mengurangi edema. Edema menyebabkan pembengkakan yang mengakibatkan kompresi sel dan pada akhirnya mengurangi respons proliferasi sel yang diperlukan untuk penyembuhan luka. Penghilangan eksudat juga melepaskan tekanan yang

disebabkan oleh akumulasi cairan di sekitar pembuluh darah, yang bermanfaat untuk perfusi luka. Selain itu, aliran cairan yang dihasilkan oleh hisapan menyebabkan gaya geser pada sel dan pergerakan ion yang membentuk medan listrik. Kedua proses ini mendorong respons proliferasi sel. Sehingga, hisapan eksudat juga membantu menghilangkan bahan beracun, seperti TNF- α dan *matrix metalloprotease* (MMPs)

c. Stabilisasi lingkungan luka

Penggunaan terapi VAC menjamin stabilitas lingkungan di sekitar luka. Hal terjadi karena adanya penggantian perban yang lebih jarang (setiap 2–3 hari) dibandingkan dengan perban kasa biasa yang diganti setiap hari. Selain itu, spons VAC ditutupi oleh kain poliuretan yang kedap terhadap protein dan mikroorganisme, yang membantu mencegah kolonisasi bakteri pada luka. Membran semioklusif juga memiliki permeabilitas terbatas terhadap gas dan uap air. Selain itu juga membantu membatasi perpindahan panas akibat penguapan air, menjaga luka tetap lembap dan hangat. Karakteristik NPWT ini bermanfaat karena terapi luka normotermik dapat mendorong penyembuhan luka kronis

d. Mikrodeformasi

Hisapan yang dihasilkan oleh NPWT menyebabkan pergerakan cairan melalui matriks seluler, yang menghasilkan gaya geser dan deformasi pada sel. Mikrodeformasi merupakan elemen kunci dari terapi VAC, karena mendorong proliferasi sel, angiogenesis, dan pembentukan jaringan granulasi. Salah satu studi menunjukkan bahwa pembentukan jaringan granulasi meningkat lebih dari 60% ketika luka diobati dengan NPWT dibandingkan dengan perban kasa, yang menyebabkan penutupan luka lebih cepat. Mekanotransduksi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana gaya mekanik dapat memodifikasi fungsi sel. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa proses ini terutama terjadi di sitoskeleton. Tekanan negatif mengganggu jembatan integrin yang melepaskan pembawa pesan intraseluler dan mengubah transkripsi gen, yang pada akhirnya menyebabkan proliferasi sel. Selain itu, telah ditunjukkan bahwa perban kasa standar menghasilkan lebih banyak kematian sel dan lebih sedikit proliferasi fibroblas dibandingkan dengan terapi VAC. Sebuah literatur saat ini menyatakan bahwa gaya mekanik menghasilkan penghambatan apoptosis, peningkatan molekul pensinyalan sel, perubahan ekspresi gen, dan stimulasi proliferasi.

Mekanisme lain yang terjadi dalam proses NPWT yaitu Perubahan Biokimia, Perubahan Perfusi dan Penurunan Beban Bakteri.

Penggunaan NPWT dengan merangsang penyempitan luka dan pembentukan jaringan granulasi, sehingga dapat menjadi pilihan dalam penanganan luka akut atau kronis dari berbagai etiologi, baik terinfeksi maupun tidak, sehingga mengurangi jumlah operasi dan kompleksitasnya, lama rawat inap, dan yang terpenting dapat mengurangi penderitaan pasien. NPWT juga menunjukkan manfaat yang lebih besar untuk penutupan luka pada pasien dengan luka yang sembuh dengan penyembuhan sekunder sehingga dapat mempersingkat Lama rawat inap. Terapi NPWT lebih sederhana dan lebih efektif daripada balutan konvensional untuk manajemen luka yang sulit dalam hal pengurangan volume luka, kedalaman, durasi perawatan, dan biaya.

Meskipun NPWT sangat efektif, penggunaannya memerlukan pelatihan dan pengawasan tenaga medis yang kompeten. Biaya perangkat dan perlengkapan yang relatif mahal menjadi salah satu hambatan dalam penerapannya secara luas, terutama di fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas. Selain itu, pemantauan rutin dibutuhkan untuk memastikan terapi berjalan efektif dan tidak terjadi komplikasi seperti infeksi atau kerusakan jaringan akibat tekanan berlebihan.

D. Simpulan

Virtual Reality (VR) dan *Negative Pressure Wound Therapy* (NPWT) merupakan inovasi teknologi yang memberikan kontribusi signifikan dalam praktik klinis modern, khususnya dalam manajemen nyeri dan perawatan luka. Virtual Reality berkembang sebagai metode non-farmakologis yang efektif dalam manajemen nyeri dengan memanfaatkan prinsip distraksi kognitif dan imersi multisensorik. Penggunaan VR terbukti mampu menurunkan persepsi nyeri, kecemasan, dan ketidaknyamanan pasien selama prosedur medis maupun perawatan luka, sehingga meningkatkan kenyamanan, kepuasan, dan keterlibatan pasien dalam proses perawatan.

Sementara itu, NPWT merupakan inovasi terapeutik yang berfokus pada optimalisasi penyembuhan luka melalui penerapan tekanan negatif terkontrol. Terapi ini berperan dalam memperbaiki perfusi jaringan, mengurangi edema dan eksudat, menurunkan risiko infeksi, serta mempercepat pembentukan jaringan granulasi. NPWT telah menjadi bagian penting dalam perawatan luka akut, kronis, maupun kompleks karena efektivitasnya dalam meningkatkan hasil klinis dan efisiensi perawatan.

Secara keseluruhan, penerapan VR dalam manajemen nyeri dan NPWT dalam perawatan luka mencerminkan pergeseran paradigma pelayanan kesehatan menuju

pendekatan yang lebih inovatif, holistik, dan berpusat pada pasien. Integrasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas asuhan klinis, tetapi juga mendukung praktik berbasis bukti serta efisiensi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman dan pemanfaatan yang optimal terhadap kedua inovasi ini menjadi penting bagi tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan hasil kesehatan pasien.

E. Referensi

- Agarwal, P., Kukrele, R., & Sharma, D. B. (2019). Vacuum assisted closure (VAC)/negative pressure wound therapy (NPWT) for difficult wounds: A review. *Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma*, 1-15.
- Ahmad, & Upoyo, A. S. (2025). Realitas Virtual: Solusi Inovatif Untuk Manajemen Nyeri Pada Pasien Pasca Laparatomi. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 3346-3356 .
- Ahmadpour, N., Randall, H., Choksi, H., A. G., Vaughan, C., & Poronnik, P. (2019). Virtual Reality interventions for acute and chronic pain management. *The international journal of biochemistry & cell biology*, 114-122.
- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2021). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice*, 11th . United Kingdom: Pearson Education.
- BINUS Higher Education. (2019, March 03). Kategori Dalam Virtual Reality. From Binus Digital: <https://binus.ac.id/binus-digital/2019/03/03/kategori-dalam-virtual-reality/>
- BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022, October 05). Virtual Reality Sensasi Sudut Pandang yang Berbeda. From BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Informatika RI: [https://bpptik.komdigi.go.id/Publikasi/detail/virtual-reality-sensasi-sudut-pandang-yang-berbeda#:~:text=Virtual%20Reality%20\(VR\)%20adalah%20teknologi,yang%20di%20simulasikan%20oleh%20komputer.](https://bpptik.komdigi.go.id/Publikasi/detail/virtual-reality-sensasi-sudut-pandang-yang-berbeda#:~:text=Virtual%20Reality%20(VR)%20adalah%20teknologi,yang%20di%20simulasikan%20oleh%20komputer.)
- Breed, H. J., Jones, E., & Cubitt, J. (2023). Use of immersive virtual reality to reduce anxiety during complex paediatric dressing changes. *BMJ Case Report*, 1-3.
- Dewi, I. S. (2024). Manajemen nyeri dengan virtual reality (VR) pada pasien luka bakar : literature review. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Fakultas Teknik Universitas Medan Area. (2023, July 06). Cara Kerja Teknologi Terbaru Virtual Reality (VR). From Fakultas Teknik Universitas Medan Area: <https://teknik.uma.ac.id/2023/07/06/cara-kerja-teknologi-terbaru-virtual-reality-vr/>

- Garrett, B. M., Tao, G., Taverner, T., Cordingley, E., & Sun, C. (2020). Patients perceptions of virtual reality therapy in the management of chronic cancer pain. *Heliyon*, 2405-8440.
- Goudman, L., Jansen, J., Billot, M., Vetse, N., Smedt, A. D., Roulaud, M., . . . Moens, M. (2022). Virtual Reality Applications in Chronic Pain Management: Systematic Review and Meta-analysis. *JMIR Serious Games* , 1-21.
- Groninger, H., Stewart, D., Fisher, J. M., & Tefera, E. (2021). Virtual reality for pain management in advanced heart failure: A randomized controlled study. *Palliative Medicine*, 2008-2016.
- Normandin, S., Safran, T., Winocour, S., Chu, C. K., Vorstenbosch, J., Murphy, A. M., & Davison, P. G. (2021). Negative Pressure Wound Therapy: Mechanism of Action and Clinical Applications. *Seminar In Plastic Surgery*, 164-170.
- Pertea, M., Velenciuc, N., Porocho, V., Ciobanu, P., Grosu, O. M., & Lunca, S. (2018). Efficacy of negative pressure therapy (NPWT) in the management of wounds of different etiologies. *Rev Chim (Bucharest)*, 1980-1986.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals o Nursing* Tenth Edition. Missouri: Elsevier.
- Prastiwi, F. (2022). Tinjauan Literatur Manajemen Nyeri Dengan Virtual Reality. *Majalah Kesehatan*, 50-60.
- Specht, B. J., Buse, C. R., Phelps, J. R., Phillips, M. R., Chiavacci, S. D., Harrell, L. E., . . . Lupa, M. C. (2021). Virtual Reality after Surgery—A Method to Decrease Pain After Surgery in Pediatric Patients. *The American Surgeon*, 596-602.
- Suprpto. (2025). *Perawatan Luka Modern: Dengan Pendekatan Komprehensif*. Makassar: Edukasi Ilmiah Indonesia.
- SyncVR Medical. (2026, January 23). Virtual Reality vs Pain: How VR is revolutionising pain management. From SyncVR Medical: <https://www.syncvrmedical.com/virtual-reality-revolutionising-pain-management/>
- Viderman, D., Tapinova, K., Dossov, M., Seitenov, S., & Abdildin, Y. G. (2023). Virtual reality for pain management: an umbrella review. *Frontier in Medicine*, 1-9.
- Zens, Y., Barth, M., Bucher, H. C., Dreck, K., Felsch, M., Groß, W., . . . Gregor, S. (2020). Negative pressure wound therapy in patients with wounds healing by secondary intention: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Systematic Reviews*, 1-26.

F. Glosarium

3D	= 3 Dimensi
fMRI	= <i>Functional Magnetic Resonance Imaging</i>
HMD	= <i>Head-Mounted Display</i>
MMP	= <i>Matrix Metalloproteinases</i>
NPWT	= <i>Negative Pressure Wound Therapy.</i>
NPWTd-i	= <i>Negative Pressure Wound Therapy with Instillation and Dwell Time</i>
VAC	= <i>Vacuum Assisted Closure</i>
VR	= <i>Virtual Reality</i>

CHAPTER 2

KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN KRITIS: PPGD, TRIAGE, DAN KOLABORASI TIM RESUSITASI

Fransiska Tatto Dua Lembang, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan

Pelayanan keperawatan gawat darurat dan kritis merupakan bagian penting dalam sistem kesehatan modern karena berkaitan langsung dengan usaha menyelamatkan nyawa, mencegah terjadinya kecacatan, serta mengurangi angka kematian. Kondisi darurat yang serius dan kritis dapat muncul secara mendadak karena faktor-faktor seperti cedera, kecelakaan kendaraan, penyakit yang menyerang secara mendadak, kegagalan fungsi organ, komplikasi dari penyakit jangka panjang, atau bencana alam. Di Indonesia, tingginya jumlah kecelakaan di jalan, kejadian bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, serta bertambahnya kasus penyakit tidak menular dengan komplikasi serius memerlukan layanan darurat dan kritis yang cepat, akurat, dan terstandarisasi (World Health Organization, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Perawat sebagai profesional kesehatan yang berada di posisi terdepan memiliki peranan yang sangat penting dalam layanan darurat dan kondisi kritis. Perawat diharapkan dapat melakukan penilaian secara cepat dan tepat, mengambil keputusan klinis yang akurat, serta melaksanakan intervensi keperawatan yang efisien dalam waktu yang sangat terbatas. Selain keahlian teknis, perawat juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang bersifat terapeutik, dan keterampilan untuk bekerja sama dalam tim multidisiplin, terutama dalam situasi resusitasi (Emergency Nurses Association, 2019; Potter et al., 2021).

Seiring dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, praktik keperawatan klinik saat ini mengalami perubahan cara pandang dari pendekatan yang fokus pada tugas (task oriented) menuju pendekatan yang mengutamakan pasien (patient centered care). Pendekatan ini menekankan signifikansi pelayanan keperawatan yang menyeluruh, yang mencakup tidak hanya aspek biologis, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual pasien beserta keluarganya. Dalam situasi darurat dan kritis, pendekatan menyeluruh tetap perlu diterapkan meskipun pelayanan dilakukan dalam keadaan yang sangat cepat dan penuh semangat (Potter et al., 2021; Smeltzer et al., 2018) Selaras dengan

pendekatan menyeluruh, praktik keperawatan dalam situasi gawat darurat dan kritis juga perlu berlandaskan pada bukti ilmiah yang paling baik, yang dikenal dengan istilah Evidence-Based Practice (EBP). Praktik Berbasis Bukti adalah perpaduan antara hasil penelitian yang paling akurat, keterampilan klinis perawat, serta nilai-nilai dan preferensi pasien. Pelaksanaan EBP dalam perawatan gawat darurat dan kritis bertujuan untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan, keselamatan pasien, serta efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019; Polit & Beck, 2021).

Penanganan pasien dalam keadaan darurat (PPGD) adalah salah satu kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang perawat. Prinsip PPGD, terutama metode ABCDE (Saluran Nafas, Pernafasan, Sirkulasi, Disabilitas, Paparan), merupakan fondasi dalam penanganan awal pasien dalam keadaan darurat untuk menjaga fungsi vital dan mencegah memburuknya kondisi. Selain itu, sistem triage merupakan elemen krusial dalam pelayanan darurat untuk menetapkan prioritas penanganan berdasarkan tingkat keparahan pasien, terutama pada situasi di mana jumlah pasien melebihi kemampuan pelayanan (American College of Surgeons, 2018; Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Dalam keadaan darurat, keberhasilan proses resusitasi tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada seberapa baik tim resusitasi bekerja sama. Kerjasama antara perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan resusitasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Perawat memainkan peran penting dalam tim resusitasi sebagai pelaksana tindakan keperawatan, koordinator, dan penghubung komunikasi di antara anggota tim. (American Heart Association, 2020; WHO, 2020).

B. Konsep keperawatan gawat darurat dan kritis

Keperawatan darurat dan kritis adalah bagian penting dari layanan kesehatan yang berfokus pada penanganan pasien dalam situasi yang mengancam jiwa, yang memerlukan tindakan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi (Smeltzer et al., 2019; Morton et al., 2018).

Perawat memainkan peran utama dalam proses pengkajian awal, penetapan prioritas, pelaksanaan intervensi keperawatan, kolaborasi dengan berbagai profesional, serta evaluasi yang berkesinambungan terhadap respons pasien. Pelayanan ini memerlukan tingkat kompetensi klinis yang tinggi, kemampuan untuk berpikir secara kritis, keterampilan teknis, serta ketahanan dalam menghadapi tekanan emosional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor kesehatan mengharuskan perawat di ruang gawat darurat dan kritis untuk senantiasa memperbarui pengetahuan serta keterampilan mereka. Hal ini disebabkan oleh

meningkatnya kompleksitas kasus yang terjadi, baik yang disebabkan oleh cedera, penyakit mendadak, keadaan medis yang mendesak, maupun kondisi kritis yang memerlukan perawatan intensif. (Ignatavicius & Workman, 2020).

1. Keperawatan Gawat Darurat

Keperawatan gawat darurat merupakan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan keadaan kritis, tiba-tiba, dan dapat membahayakan nyawa, yang memerlukan tindakan segera untuk mencegah kecacatan atau kematian (Hidayat, 2019; Bledsoe et al., 2021). Pelayanan ini biasanya dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan mencakup langkah-langkah triase, stabilisasi, serta rujukan berikutnya.

Ciri-ciri utama dari keperawatan gawat darurat terdiri dari: Respons yang cepat, perhatian pada penyelamatan nyawa, pengambilan keputusan klinis yang cepat dan akurat, serta pelayanan yang didasarkan pada prioritas.

2. Keperawatan Kritis

Keperawatan kritis merupakan layanan keperawatan yang diberikan untuk pasien yang mengalami gangguan fungsi organ yang dapat mengancam jiwa, baik yang sudah terjadi maupun yang mungkin terjadi. Layanan ini membutuhkan pemantauan yang intensif, dukungan kehidupan, serta intervensi yang kompleks secara berkesinambungan (AACN, 2022; Morton et al., 2018). Layanan ini umumnya dilaksanakan di Unit Perawatan Intensif (ICU), Unit Perawatan Tinggi (HCU), atau ruangan perawatan intensif yang lain. Pasien dengan kondisi kritis biasanya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: ketidakstabilan dalam hemodinamik, gangguan pada fungsi pernapasan, kardiovaskular, neurologis, atau beberapa organ sekaligus, ketergantungan pada perangkat ventilasi, serta memiliki risiko tinggi untuk mengalami komplikasi.

3. Tujuan Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis

Tujuan utama keperawatan gawat darurat dan kritis antara lain (Smeltzer et al., 2019; PPNI, 2020):

- a. Mempertahankan dan menyelamatkan kehidupan pasien
- b. Mencegah perburukan kondisi dan komplikasi
- c. Mengembalikan fungsi fisiologis secara optimal
- d. Memberikan kenyamanan dan dukungan psikologis
- e. Melibatkan keluarga dalam proses perawatan secara terapeutik

4. Prinsip-Prinsip Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis

Prinsip dasar yang menjadi landasan praktik keperawatan gawat darurat dan kritis meliputi (Ignatavicius & Workman, 2020; PPNI, 2020):

- a. **Prioritas ABCDE** (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure)
- b. **Keselamatan pasien** sebagai fokus utama
- c. **Pendekatan holistik** meliputi aspek bio-psiko-sosial-spiritual
- d. **Kolaborasi interprofesional** dengan tim Kesehatan
- e. **Berbasis bukti (evidence-based practice)**

5. Proses Keperawatan dalam Pelayanan Gawat Darurat dan Kritis

a. Pengkajian

Pengkajian dilakukan secara cepat, sistematis, dan berkesinambungan (Morton et al., 2018; Smeltzer et al., 2019). Pada fase awal digunakan pengkajian primer (ABCDE), kemudian dilanjutkan dengan pengkajian sekunder yang lebih komprehensif meliputi riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik lanjutan, serta data penunjang.

b. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan ditentukan berdasarkan reaksi pasien terhadap keadaan darurat atau kritis, contohnya masalah dalam pertukaran gas, penurunan curah jantung, potensi terjadinya syok, gangguan perfusi jaringan, atau penurunan tingkat kesadaran. (NANDA-I, 2021; Smeltzer et al., 2019).

c. Perencanaan

Perencanaan difokuskan pada sasaran jangka pendek dan prioritas utama dalam menyelamatkan nyawa. Intervensi direncanakan dengan cara yang adaptif dan dapat diubah sesuai dengan keadaan pasien yang berkembang.

d. Implementasi

Implementasi meliputi tindakan mandiri keperawatan, tindakan kolaboratif, serta tindakan darurat sesuai protokol dan standar operasional prosedur (SOP).

e. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara kontinu untuk menilai efektivitas intervensi dan respons pasien, serta sebagai dasar penyesuaian rencana asuhan.

6. Peran dan Kompetensi Perawat Gawat Darurat dan Kritis

Perawat gawat darurat dan kritis harus memiliki kompetensi (AACN, 2022; PPNI, 2020):

- a. Kemampuan pengkajian cepat dan akurat
- b. Keterampilan teknis (resusitasi, pemasangan alat, monitoring)

- c. Pengambilan keputusan klinis
- d. Komunikasi efektif dan terapeutik
- e. Manajemen stres dan etika profesional

7. Etika dan Aspek Legal

Pelayanan keperawatan di unit gawat darurat dan kritis melibatkan berbagai aspek etika dan hukum, seperti persetujuan yang diinformasikan pada situasi darurat, menjaga kerahasiaan pasien, serta prinsip manfaat dan tidak merugikan. Selain itu, juga terdapat perlindungan hukum untuk perawat yang sesuai dengan kewenangan dan kompetensi mereka (UU No. 38 Tahun 2014; PPNI, 2020).

8. Tantangan dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis

Tantangan yang biasa dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya, jumlah pekerjaan yang sangat banyak, situasi pasien yang rumit, tekanan emosional yang tinggi, serta kebutuhan untuk membuat keputusan cepat dalam keadaan yang kritis. (Morton et al., 2018; AACN, 2022).

C. Pendekatan Holistik dan Evidence-Based Practice

1. Pengertian Holistik dan Evidence-Based Practice

Pendekatan holistik dalam keperawatan adalah suatu cara yang melihat pasien sebagai satu kesatuan yang lengkap, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam bidang keperawatan gawat darurat dan kritis, pendekatan menyeluruh tetap merupakan prinsip yang sangat penting, meskipun pelayanan lebih diarahkan pada upaya penyelamatan jiwa dan penstabilan keadaan fisiologis pasien (Smeltzer et al., 2019).

Pasien dalam kondisi darurat dan kritis sering kali menghadapi situasi yang tidak hanya mengancam kesehatan fisik, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kondisi psikologis dan emosional, baik bagi pasien maupun anggota keluarganya. Dengan demikian, perawat diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang baik, tetapi juga mampu memberikan perawatan yang bersifat manusiawi, penuh empati, dan berarti.

a. Aspek Biologis

Aspek biologis menjadi perhatian utama dalam tahap awal pelayanan darurat dan kritis. Perawat memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan fungsi vital dengan cara melakukan pengkajian ABCDE, memantau hemodinamik, mengelola jalan napas, memberikan dukungan pernapasan, dan mencegah terjadinya komplikasi lanjut. Intervensi biologis dilakukan dengan

cepat dan mengikuti protokol klinis guna menjaga kelangsungan hidup pasien. (Morton et al., 2018).

b. Aspek Psikologis

Situasi yang mendesak dan serius seringkali menyebabkan perasaan cemas, rasa takut, kebingungan, dan bahkan delirium pada pasien. Perawat memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan psikologis. Hal ini dilakukan melalui komunikasi terapeutik, penyampaian informasi yang jelas dan jujur, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien. Metode ini telah terbukti dapat mengurangi tingkat stres serta meningkatkan kolaborasi pasien dalam proses perawatan. (Ignatavicius & Workman, 2020).

c. Aspek Sosial

Aspek sosial berhubungan dengan interaksi pasien dengan anggota keluarga serta lingkungan di sekitarnya. Dalam keadaan darurat dan kritis, anggota keluarga biasanya menghadapi krisis emosional. Perawat berfungsi sebagai penghubung antara tim medis dan keluarga, memberikan informasi, melibatkan keluarga dengan cara yang terbatas tetapi berarti, serta menghargai nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh pasien dan keluarganya. (PPNI, 2020).

d. Aspek Spiritual

Aspek spiritual sering kali menjadi sumber daya dan cara bagi pasien serta keluarga dalam menghadapi situasi yang sulit. Perawat diharapkan dapat mengenali kebutuhan spiritual pasien, mendukung pelaksanaan ibadah sesuai kepercayaan, dan berkolaborasi dengan pemimpin agama atau rohaniawan jika diperlukan. Memenuhi kebutuhan spiritual terbukti dapat meningkatkan ketenangan jiwa serta kualitas hidup pasien. (Potter et al., 2021).

2. Konsep Evidence-Based Practice (EBP) dalam Keperawatan

Evidence-Based Practice (EBP) merupakan cara dalam membuat keputusan klinis yang menggabungkan bukti ilmiah terbaik, keterampilan profesional perawat, serta nilai dan preferensi pasien. Penerapan bukti berbasis praktik (EBP) sangat krusial dalam bidang keperawatan darurat dan kritis, mengingat tingkat risiko yang tinggi, kompleksitas kasus yang ada, serta kebutuhan akan intervensi yang cepat dan tepat (Melnik & Fineout-Overholt, 2019).

3. Komponen Evidence-Based Practice

EBP terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Bukti ilmiah terbaik yang berasal dari hasil penelitian terkini

2. Keahlian klinis perawat yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman
3. Nilai, kebutuhan, dan preferensi pasien serta keluarga

Ketiga komponen ini harus dipadukan secara seimbang agar asuhan keperawatan yang diberikan efektif, aman, dan berpusat pada pasien.

4. Tahapan Evidence-Based Practice

Penerapan EBP dalam keperawatan gawat darurat dan kritis dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, meliputi:

1. Merumuskan pertanyaan klinis berdasarkan masalah pasien
2. Mencari bukti ilmiah yang relevan dan terpercaya
3. Melakukan penilaian kritis terhadap kualitas bukti
4. Menerapkan bukti dalam praktik klinik
5. Mengevaluasi hasil penerapan dan melakukan perbaikan berkelanjutan

D. Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD)

Penanganan pasien dalam keadaan darurat adalah serangkaian langkah yang cepat, akurat, dan terencana untuk menyelamatkan hidup serta menghindari terjadinya kecacatan lebih lanjut. Prinsip dasar PPGD menekankan penggunaan pendekatan ABCDE (Saluran Napas, Pernapasan, Sirkulasi, Disabilitas, Eksposur) sebagai norma internasional dalam mengevaluasi dan menangani keadaan darurat pasien. (ATLS Subcommittee, 2018).

Pada tahap Airway, perawat memastikan jalan napas paten dengan mempertimbangkan stabilisasi tulang servikal, terutama pada pasien trauma. Tindakan seperti head-tilt chin-lift, jaw thrust, hingga pemasangan airway adjunct dilakukan sesuai indikasi klinis (Smeltzer et al., 2020).

Tahap Breathing meliputi penilaian frekuensi napas, kedalaman, pola pernapasan, dan saturasi oksigen. Intervensi dapat berupa pemberian oksigen, ventilasi bantuan, atau kolaborasi untuk intubasi endotrakeal pada kondisi gagal napas (WHO, 2019).

Pada Circulation, fokus utama adalah menjaga perfusi jaringan melalui kontrol perdarahan, pemasangan akses intravena, pemberian cairan, dan pemantauan tanda vital. Syok hipovolemik merupakan kondisi yang paling sering ditemukan di instalasi gawat darurat (IGD) dan memerlukan penanganan segera (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Tahap Disability menilai status neurologis pasien menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS), ukuran pupil, dan respon motorik. Penilaian ini penting untuk mendeteksi cedera otak atau penurunan kesadaran secara dini (Teasdale & Jennett, 1974).

Tahap terakhir Exposure menekankan pemeriksaan menyeluruh tubuh pasien untuk menemukan cedera tersembunyi, dengan tetap menjaga privasi dan mencegah hipotermia (ATLS Subcommittee, 2018).

E. Triage dalam Pelayanan Gawat Darurat

Triage merupakan proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan dan prioritas penanganan. Tujuan utama triage adalah memastikan pasien dengan kondisi paling mengancam nyawa mendapatkan penanganan terlebih dahulu (Gilboy et al., 2020).

Sistem triage yang umum digunakan di IGD meliputi Emergency Severity Index (ESI) dan sistem triage berbasis warna (merah, kuning, hijau, hitam). Kategori merah menunjukkan kondisi gawat darurat yang memerlukan tindakan segera, sedangkan kategori hijau menunjukkan kondisi non-urgensi (Kemenkes RI, 2020).

Perawat memainkan peran penting dalam proses triage karena diharapkan memiliki keterampilan untuk membuat keputusan klinis dengan cepat dan tepat. Kesalahan dalam proses triase dapat menyebabkan peningkatan tingkat sakit dan kematian pasien. (Hidayat & Uliyah, 2019).

F. Kolaborasi Tim Resusitasi

Kerja sama tim resusitasi adalah kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu yang melibatkan dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, serta petugas pendukung dalam perawatan pasien yang dalam kondisi kritis. Kerja sama yang baik terbukti meningkatkan sukses dalam resusitasi dan keamanan pasien (American Heart Association, 2020).

Dalam tim resusitasi, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, seperti leader tim, airway manager, medication nurse, dan dokumentator. Komunikasi yang efektif menggunakan pendekatan closed-loop communication sangat dianjurkan untuk meminimalkan kesalahan tindakan (AHA, 2020).

Perawat berperan penting dalam pelaksanaan tindakan resusitasi, pemantauan respon pasien, serta dokumentasi tindakan dan hasil resusitasi. Kompetensi dan kesiapan perawat sangat memengaruhi outcome pasien (Potter et al., 2021).

G. Keselamatan Pasien dan Etika Keperawatan Gawat Darurat

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan gawat darurat yang memiliki risiko tinggi terhadap kesalahan medis. Prinsip keselamatan

pasien mencakup identifikasi pasien yang benar, komunikasi efektif, keamanan obat, dan pencegahan infeksi (WHO, 2017).

Dalam situasi gawat darurat, perawat sering menghadapi dilema etik, seperti pengambilan keputusan cepat tanpa persetujuan tertulis pasien. Prinsip etika keperawatan meliputi beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice tetap harus dijunjung tinggi (ANA, 2015).

Penerapan etika keperawatan di IGD juga mencakup penghormatan terhadap martabat pasien, menjaga kerahasiaan informasi, serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi (PPNI, 2021).

H. Simpulan

Keperawatan gawat darurat dan kritis merupakan komponen penting dari praktik keperawatan klinik modern yang memerlukan kecepatan, akurasi, serta daya tahan dalam membuat keputusan klinis di dalam kondisi yang rumit dan berisiko tinggi. Keberhasilan dalam pelayanan keperawatan pada kondisi darurat dan kritis sangat bergantung pada kemampuan perawat untuk menggabungkan pendekatan holistik, praktik berdasarkan bukti (Evidence-Based Practice), penerapan prinsip Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD), sistem triase yang tepat, serta kerja sama tim resusitasi yang efisien.

Pendekatan menyeluruh dalam keperawatan gawat darurat dan kritis tetap memegang peranan yang signifikan meskipun layanan dilaksanakan dalam situasi yang mendesak. Perawat tidak hanya menitikberatkan pada stabilisasi fisik pasien, tetapi juga memperhatikan faktor psikologis, sosial, budaya, dan spiritual pasien serta anggota keluarganya. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan mutu perawatan keperawatan, memperkuat hubungan terapeutik, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan.

Pelaksanaan Praktik Berbasis Bukti adalah dasar yang utama dalam praktik keperawatan saat ini, termasuk dalam layanan gawat darurat dan perawatan kritis. Penggabungan bukti ilmiah terbaru, keterampilan profesional perawat, serta nilai dan pilihan pasien memungkinkan keputusan klinis yang lebih aman, efektif, dan logis. Praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti juga berperan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mengurangi jumlah kesalahan tindakan, serta meningkatkan hasil klinis pasien yang berada dalam keadaan darurat dan kritis.

Penanganan pasien dalam keadaan darurat (PPGD) dengan pendekatan yang terstruktur, terutama melalui prinsip ABCDE, adalah keterampilan fundamental yang harus dikuasai oleh para perawat. Pelaksanaan PPGD yang benar dan terus-menerus memungkinkan deteksi cepat terhadap masalah yang dapat mengancam jiwa,

mencegah semakin parahnya keadaan pasien, serta menjadi dasar utama dalam penanganan selanjutnya dan resusitasi.

Sistem triase memiliki fungsi penting dalam layanan darurat, terutama saat terjadi kekurangan sumber daya dan peningkatan jumlah pasien. Triage yang tepat dan mengikuti standar dapat memastikan prioritas dalam pelayanan yang adil, efektif, serta fokus pada keselamatan pasien. Perawat yang bertugas sebagai pelaksana triage diwajibkan untuk memiliki keterampilan klinis, kemampuan berpikir secara kritis, serta pengetahuan mengenai etika dan hukum dalam proses pengambilan keputusan.

Kerja sama dalam tim resusitasi sangat penting untuk keberhasilan dalam mengelola pasien yang berada dalam kondisi kritis. Keberhasilan resusitasi tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada komunikasi yang baik, kepemimpinan yang tegas, pembagian tugas yang teratur, serta kerja sama antar profesi yang harmonis. Perawat memainkan peranan penting dalam tim resusitasi sebagai pelaksana tindakan keperawatan, pengatur alur pelayanan, dan penghubung komunikasi di antara anggota tim.

Secara umum, keperawatan darurat dan kritis dalam konteks keperawatan klinis modern memerlukan perawat yang memiliki kompetensi klinis, dapat beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menyediakan layanan yang menyeluruh dan berdasarkan bukti. Penggabungan PPGD, triage, dan kerjasama tim resusitasi yang efisien merupakan dasar penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di Indonesia.

I. Referensi

- American Association of Critical-Care Nurses. (2022). *AACN Essentials of Critical Care Nursing*. New York: McGraw-Hill.
- American College of Surgeons. (2018). *Advanced Trauma Life Support (ATLS) Student Course Manual*. Chicago: ACS.
- American Heart Association. (2020). *Advanced Cardiovascular Life Support Provider Manual*. Dallas: AHA.
- American Heart Association. (2020). *Advanced Cardiovascular Life Support Provider Manual*. AHA.
- American Nurses Association. (2015). *Code of Ethics for Nurses*. ANA.
- ATLS Subcommittee. (2018). *Advanced Trauma Life Support Student Course Manual*. American College of Surgeons.

- Bledsoe, B. E., Porter, R. S., & Cherry, R. A. (2021). *Paramedic Care: Principles & Practice*. Boston: Pearson
- Emergency Nurses Association. (2019). *Emergency Nursing Core Curriculum*. Elsevier.
- Gilboy, N., Tanabe, P., Travers, D., & Rosenau, A. (2020). *Emergency Severity Index (ESI): A Triage Tool*. AHRQ.
- Hidayat, A. A. A. (2019). *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hidayat, A. A. A., & Uliyah, M. (2019). *Pengantar Keperawatan Gawat Darurat*. Salemba Medika.
- Ignatavicius, D. D., & Workman, M. L. (2020). *Medical-Surgical Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care*. St. Louis: Elsevier.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Gawat Darurat*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar Pelayanan Keperawatan di IGD*. Kemenkes RI.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). *Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare*. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Morton, P. G., Fontaine, D., Hudak, C. M., & Gallo, B. M. (2018). *Critical Care Nursing: A Holistic Approach*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. Wolters Kluwer.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of Nursing*. Elsevier.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2019). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing*. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2020). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing*. Wolters Kluwer.
- Smeltzer, S. C., Hinkle, J. L., Cheever, K. H., & Bare, B. G. (2018). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Teasdale, G., & Jennett, B. (1974). Assessment of coma and impaired consciousness. *The Lancet*, 304(7872), 81–84.
- Tim Pokja Keperawatan Gawat Darurat PPNI. (2020). *Standar Praktik Keperawatan Gawat Darurat*. Jakarta: PPNI.
- World Health Organization. (2017). *Patient Safety: Making Health Care Safer*. WHO.

World Health Organization. (2019). *Emergency Care Systems Framework*. WHO.

World Health Organization. (2020). *Emergency Care Systems for Universal Health Coverage*. Geneva: WHO.

J. Glosarium

<i>Airway</i>	= Jalan napas yang memungkinkan udara masuk dan keluar dari paru-paru
<i>Breathing</i>	= Proses pernapasan yang mencakup ventilasi dan pertukaran gas
<i>Circulation</i>	= Sistem peredaran darah yang berfungsi mempertahankan perfusi dan oksigenasi jaringan
<i>Disability</i>	= Penilaian fungsi neurologis pasien, termasuk tingkat kesadaran dan respon motorik
<i>Exposure</i>	= Pemeriksaan menyeluruh tubuh pasien untuk mendeteksi cedera tersembunyi dengan tetap menjaga suhu tubuh dan privasi
PPGD (Penanganan Penderita Gawat Darurat)	= Serangkaian tindakan awal yang cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan
<i>Triage</i>	= Proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan dan prioritas penanganan
Gawat Darurat	= Kondisi klinis yang mengancam nyawa atau fungsi vital dan memerlukan tindakan segera
<i>Resusitasi</i>	= Tindakan medis dan keperawatan untuk mempertahankan atau mengembalikan fungsi vital pasien
Kolaborasi Tim	= Kerja sama multidisiplin antar tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien

- Keselamatan Pasien = Upaya sistematis untuk mencegah terjadinya cedera atau kesalahan dalam pelayanan kesehatan
- Etika Keperawatan = Prinsip moral dan profesional yang menjadi pedoman perawat dalam memberikan asuhan keperawatan

CHAPTER 3

KEPERAWATAN MATERNITAS: PELAYANAN HOLISTIK PADA IBU HAMIL, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR

Ety Nurhayati, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat.

A. Urgensi Pelayanan Holistik dalam Keperawatan Maternitas di Indonesia

Kesehatan ibu dan bayi merupakan indikator utama kualitas sistem kesehatan nasional. Di Indonesia, angka kematian ibu dan neonatal masih menjadi tantangan signifikan. Data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mencatat ribuan kasus kematian ibu dan bayi setiap tahun, yang sebagian besar terkait dengan perdarahan, hipertensi, infeksi, prematuritas, dan berat lahir rendah. Selain itu, cakupan kunjungan antenatal lengkap (≥ 4 kali) belum optimal, menunjukkan masih adanya kendala pemantauan prenatal (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Permasalahan pelayanan maternal dan neonatal di Indonesia bersifat kompleks, mencakup kesenjangan akses antara daerah urban dan rural, kompetensi tenaga kesehatan yang beragam, rendahnya literasi ibu, serta determinan sosial ekonomi yang memengaruhi perilaku perawatan. Penilaian kompetensi dan praktik berbasis bukti menunjukkan perlunya penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pemantauan indikator penting seperti inisiasi menyusui dini (*early breastfeeding initiation*) dan deteksi komplikasi dini (Irfana et al., 2024; Elfiani & Yulita, 2024).

Metodologi yang digunakan dalam memahami konteks ini meliputi analisis deskriptif data sekunder dari survei nasional, sistem pencatatan kematian ibu dan bayi (*Maternal Perinatal Death Notification*), serta survei lintas fasilitas untuk menilai kompetensi dan kepatuhan standar pelayanan (Nguyen et al., 2022).

Pelayanan keperawatan maternitas yang holistik dan berbasis bukti sangat penting untuk menurunkan risiko komplikasi maternal dan neonatal, memperbaiki hasil kesehatan ibu-bayi, serta mendukung tercapainya target *Indonesia Sehat 2045*.

B. Integrasi Pendekatan Holistik pada Masa Kehamilan, Nifas, dan Neonatal

1. Asuhan Holistik pada Ibu Hamil

Asuhan antenatal holistik merupakan pendekatan yang mengintegrasikan perawatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual ibu hamil secara simultan.

Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan model pelayanan antenatal konvensional yang cenderung berfokus pada aspek medis semata. Berbagai temuan ilmiah menunjukkan bahwa pelayanan antenatal holistik memberikan dampak positif yang signifikan terhadap berbagai luaran kesehatan ibu, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta berimplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari ibu hamil dan keluarganya.

Asuhan holistik merupakan pendekatan perawatan yang melihat ibu hamil sebagai individu utuh—bukan hanya sekadar memantau aspek fisik (seperti tekanan darah, pertumbuhan janin, atau hasil laboratorium), tetapi juga memperhatikan **kesejahteraan psikologis, sosial, emosional, dan spiritual**. Pendekatan ini menekankan bahwa kesehatan ibu selama kehamilan dipengaruhi oleh berbagai dimensi kehidupan, dan bukan hanya oleh variabel medis semata. Dengan demikian, asuhan holistik membentuk rencana perawatan yang komprehensif, personal, dan berkelanjutan sepanjang masa kehamilan hingga persalinan. Dalam praktiknya asuhan holistik mencakup **edukasi kesehatan, dukungan psikososial, nutrisi yang adekuat, teknik relaksasi, serta perhatian terhadap kebutuhan spiritual**, yang semuanya saling berinteraksi untuk mendukung kesejahteraan total ibu hamil.

Penelitian dan laporan ilmiah menunjukkan bahwa **asuhan antenatal holistik terbukti efektif** dalam beberapa hasil kesehatan berikut:

a. Pengurangan Kecemasan dan Peningkatan Ketahanan Psikologis

Studi kuantitatif menunjukkan bahwa pemberian perawatan antenatal holistik dapat *mengurangi tingkat kecemasan ibu*, meningkatkan kontrol emosi, dan memperbaiki pengalaman persalinan secara keseluruhan ketika dibandingkan dengan pendekatan standar medis saja.

Kecemasan selama kehamilan merupakan kondisi yang umum terjadi dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu maupun janin. Asuhan antenatal holistik terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan ibu hamil melalui pendekatan yang menekankan komunikasi terapeutik, dukungan emosional, serta pemberdayaan ibu dalam memahami perubahan yang terjadi selama kehamilan. Studi kuantitatif menunjukkan bahwa ibu yang menerima perawatan holistik memiliki kemampuan regulasi emosi yang lebih baik dan menunjukkan tingkat ketenangan yang lebih tinggi dibandingkan ibu yang hanya menerima pelayanan medis standar.

Pendekatan holistik memungkinkan ibu untuk merasa didengar, dipahami, dan dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait kehamilannya. Hal ini berkontribusi pada peningkatan ketahanan psikologis

(*psychological resilience*), yaitu kemampuan ibu dalam menghadapi stres dan ketidakpastian selama kehamilan dan persalinan.

Implikasi dalam kehidupan sehari-hari, ibu hamil yang lebih tenang dan stabil secara emosional cenderung mampu menjalani aktivitas harian dengan lebih percaya diri, memiliki kualitas tidur yang lebih baik, serta menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan pasangan dan keluarga. Kondisi psikologis yang lebih sehat juga membantu ibu mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi proses persalinan dan peran baru sebagai orang tua.

b. Penanggulangan Keluhan Fisiologis Melalui Praktik Komplementer

Selama kehamilan, ibu sering mengalami berbagai keluhan fisiologis seperti gangguan tidur, nyeri punggung, kelelahan, dan ketegangan otot. Asuhan antenatal holistik mengintegrasikan praktik komplementer yang aman dan berbasis bukti, seperti prenatal yoga, latihan pernapasan, dan relaksasi. Intervensi ini terbukti membantu mengurangi stres fisik dan psikologis, sekaligus meningkatkan adaptasi tubuh terhadap perubahan fisiologis kehamilan.

Asuhan komprehensif seperti prenatal yoga membantu mengatasi gangguan tidur dan stres yang biasa dialami ibu hamil, serta berkontribusi positif terhadap adaptasi fisiologis tubuh selama kehamilan. Prenatal yoga tidak hanya membantu meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot, tetapi juga berperan dalam memperbaiki pola tidur dan menurunkan ketegangan mental. Pendekatan ini mendukung keseimbangan antara tubuh dan pikiran, sehingga ibu hamil lebih mampu mengenali dan merespons kebutuhan tubuhnya secara positif.

Dalam kehidupan sehari-hari, ibu hamil yang rutin melakukan praktik komplementer cenderung lebih aktif, lebih nyaman dalam beraktivitas, dan memiliki tingkat kelelahan yang lebih rendah. Kemampuan mengelola keluhan fisik secara mandiri juga mengurangi ketergantungan pada intervensi farmakologis, sehingga mendukung kehamilan yang lebih aman dan alami.

c. Kebutuhan Spiritual sebagai Bagian dari Kesejahteraan Ibu Hamil

Dimensi spiritual merupakan aspek penting yang sering terabaikan dalam pelayanan antenatal konvensional, padahal memiliki peran signifikan dalam kesejahteraan ibu hamil. Asuhan antenatal holistik mengakui kebutuhan spiritual sebagai bagian integral dari kesehatan, dengan

memberikan ruang bagi ibu untuk mengekspresikan nilai, keyakinan, dan makna kehamilan dalam kehidupannya.

Peningkatan literasi spiritual melalui edukasi dan pendampingan terbukti membantu ibu hamil merasa lebih tenang dan memiliki makna positif terhadap pengalaman kehamilan dan persalinan. Pendekatan ini juga membantu ibu dalam mengelola stres dan ketakutan, terutama pada kehamilan pertama atau kehamilan dengan risiko tertentu.

Implikasi praktisnya, ibu hamil yang memiliki keseimbangan spiritual yang baik cenderung lebih sabar, lebih menerima perubahan, dan memiliki sikap optimis dalam menjalani kehamilan. Ketenangan batin ini berdampak pada suasana rumah tangga yang lebih kondusif dan meningkatkan kesiapan emosional ibu dalam menghadapi persalinan serta perawatan bayi.

d. Edukasi Kesehatan Gizi dan Gaya Hidup Sehat

Edukasi kesehatan merupakan komponen utama dalam asuhan antenatal holistik. Program edukasi yang mencakup pemahaman tentang gizi seimbang, aktivitas fisik yang aman, teknik relaksasi, serta stimulasi janin terbukti meningkatkan motivasi dan kesadaran ibu hamil dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Edukasi yang diberikan secara personal dan kontekstual membantu ibu memahami alasan di balik setiap anjuran kesehatan, sehingga meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan perilaku sehat.

Pendekatan holistik tidak hanya berfokus pada transfer informasi, tetapi juga pada pemberdayaan ibu untuk membuat keputusan yang tepat terkait pola makan, aktivitas fisik, dan perawatan diri. Hal ini berdampak positif terhadap status gizi ibu, pertumbuhan janin, dan pencegahan komplikasi kehamilan.

Program edukasi kesehatan ibu hamil yang mencakup pemahaman gizi, teknik relaksasi, dan stimulasi janin menunjukkan peningkatan motivasi ibu dalam mempraktikkan perilaku sehat, seperti pola makan seimbang dan rutin melakukan aktivitas fisik aman.

Pendekatan holistik membawa **dampak positif luas** dalam kehidupan harian ibu hamil, termasuk: **Kesejahteraan Fisik yang Lebih Baik seperti** perhatian terhadap nutrisi yang cukup, istirahat teratur, dan aktivitas fisik yang sesuai membantu tubuh ibu menyesuaikan diri dengan perubahan kehamilan dan menurunkan kejadian mual, nyeri punggung, atau gangguan tidur. **Perubahan Pola Hidup Sehat,** Ibu menjadi lebih sadar pentingnya pola makan seimbang, minum cukup air, tidur terpola, serta pemantauan tanda bahaya sejak

dini sebagai bagian dari tindakan pencegahan komplikasi. **Kesehatan Emosional dan Keluarga yang Lebih Stabil**, dukungan keluarga—dalam bentuk pengertian, keterlibatan dalam edukasi, dan dukungan emosional—meningkatkan kualitas hubungan interpersonal dan memperkuat jaringan sosial ibu hamil. **Manajemen Stres dan Kecemasan** diantaranya praktik relaksasi seperti yoga, mindfulness, hypnopregnancy, atau teknik pernapasan membantu ibu mengelola stres dan kecemasan yang sering muncul menjelang persalinan.

Antisipasi Masalah Umum pada Ibu Hamil. sebagai bagian dari asuhan holistik, tenaga kesehatan perlu mengantisipasi beberapa masalah umum seperti **kecemasan yang meningkat** terhadap proses persalinan atau kekhawatiran terhadap kondisi janin dapat menimbulkan stres yang berdampak negatif. Oleh karena itu, kelas persiapan persalinan yang holistik termasuk edukasi, simulasi, dan dukungan emosional sangat penting untuk mencegah kecemasan berat. **Komplikasi Fisiologis, muncul keluhan** seperti nyeri punggung, gangguan tidur, atau sering buang air kecil dapat menjadi tanda risiko tertentu bila tidak dikelola dengan baik. Pijat prenatal, terapi yoga, dan penilaian komprehensif rutin membantu mengatasi dan memantau masalah ini. **Perubahan mood atau depresi, terjadi karena** perubahan hormonal atau stres dapat memicu gejala depresi. Konseling psikososial, keterlibatan keluarga, dan monitoring berkala merupakan strategi pencegahan penting.

Dalam kehidupan sehari-hari, ibu hamil yang mendapatkan edukasi holistik cenderung lebih konsisten dalam mengatur pola makan, memilih aktivitas fisik yang sesuai, serta menghindari perilaku berisiko. Perubahan gaya hidup ini tidak hanya berdampak selama kehamilan, tetapi juga berlanjut setelah persalinan, sehingga mendukung kesehatan ibu dan anak dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, asuhan antenatal holistik terbukti memberikan manfaat multidimensional yang saling berkaitan, mulai dari penguatan kesehatan mental, penanganan keluhan fisik, pemenuhan kebutuhan spiritual, hingga perubahan perilaku hidup sehat. Implikasi dari pendekatan ini nyata dalam kehidupan sehari-hari ibu hamil, keluarga, dan lingkungan sekitarnya, serta berkontribusi pada pengalaman kehamilan yang lebih positif dan bermakna. Oleh karena itu, penerapan asuhan antenatal holistik perlu terus diperkuat sebagai bagian integral dari pelayanan keperawatan maternitas modern.

Penatalaksanaan holistik pada ibu hamil menekankan perawatan yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, serta edukasi kesehatan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas

pengalaman kehamilan, mengurangi risiko komplikasi, dan memperkuat kesiapan ibu menghadapi persalinan. Perawat, bidan, dan tim kesehatan lainnya berperan secara kolaboratif, menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan individu ibu.

a. Pengkajian Komprehensif Awal

Langkah awal dalam asuhan holistik adalah melakukan pengkajian menyeluruh, yang mencakup pemeriksaan fisik lengkap serta wawancara mendalam untuk memahami kondisi psikososial, kebutuhan spiritual, dukungan keluarga, dan riwayat kesehatan. Pengumpulan informasi ini memungkinkan tim kesehatan merancang rencana perawatan yang personal dan berbasis bukti.

Peran kolaboratif sangat penting dalam tahap ini. Perawat dan bidan melakukan pengkajian fisik dan observasi rutin, sedangkan dokter atau ahli kesehatan lain dapat memberikan pendampingan terkait risiko medis. Selain itu, konselor atau ahli psikologi dapat dilibatkan jika ditemukan indikasi stres atau gangguan mental pada ibu hamil.

Dengan pengkajian yang komprehensif, ibu akan mendapatkan rencana asuhan yang sesuai dengan kondisi uniknya, sehingga setiap intervensi dapat lebih efektif dan relevan.

b. Rencana Edukasi Berkesinambungan

Memberikan informasi tentang gizi, tanda bahaya kehamilan, teknik relaksasi, serta persiapan persalinan. Edukasi dapat diberikan melalui sesi tatap muka, materi cetak, media digital, maupun telenursing, sehingga ibu tetap mendapatkan informasi walaupun tidak selalu hadir di fasilitas kesehatan. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan ibu, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya sendiri.

Peran tim: perawat fokus pada edukasi sehari-hari dan praktik rutin, bidan menekankan persiapan persalinan, dan ahli gizi memberikan panduan nutrisi yang sesuai.

c. Dukungan Psikososial dan Spiritual

Asuhan holistik juga menekankan pemenuhan kebutuhan psikososial dan spiritual ibu hamil. Layanan ini dapat mencakup konseling individu atau kelompok untuk mengurangi kecemasan. Fasilitasi kelompok pendukung ibu

hamil agar berbagi pengalaman dan strategi coping. Pendampingan spiritual, seperti meditasi, doa, atau refleksi diri sesuai keyakinan ibu.

Pendekatan ini membantu ibu mengelola stres, memperkuat ketahanan emosional, dan meningkatkan kesiapan mental menghadapi persalinan. Dukungan psikososial dan spiritual yang terstruktur juga memperkuat hubungan terapeutik antara ibu dan tenaga kesehatan, meningkatkan kepuasan pelayanan, serta mendorong keterlibatan keluarga dalam perawatan.

d. Intervensi Komplementer

Selain perawatan medis, asuhan holistik melibatkan praktik komplementer berbasis bukti yang terbukti aman bagi ibu hamil, antara lain prenatal yoga untuk memperkuat otot, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi ketegangan. Teknik relaksasi dan meditasi untuk menurunkan tingkat stress dan terapi pijat ringan yang membantu meredakan nyeri punggung dan meningkatkan kualitas tidur.

Peran bidan dan perawat di sini adalah memastikan intervensi dilakukan secara aman, sesuai dengan kondisi ibu, dan dipandu dengan teknik yang benar. Praktik komplementer ini memungkinkan ibu hamil lebih memahami dan merespons kebutuhan tubuhnya, sehingga kesejahteraan fisik dan mental dapat seimbang.

e. Monitoring Berkala dan Evaluasi

Tahap terakhir adalah pemantauan rutin dan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan ibu dan janin dengan melakukan kunjungan rutin termasuk pemeriksaan tanda vital, pertumbuhan janin, dan diskusi masalah harian ibu untuk menilai kemajuan serta menyesuaikan rencana perawatan bila diperlukan. Dengan evaluasi yang kontinu, pelayanan keperawatan dapat tetap relevan, aman, dan efektif.

Asuhan holistik pada ibu hamil merupakan pendekatan komprehensif yang menggabungkan perawatan medis dengan dukungan psikososial, edukasi gizi, relaksasi, dan perhatian spiritual. Bukti ilmiah menunjukkan pendekatan ini mampu mengurangi kecemasan, meningkatkan keterampilan *self-care*, memperbaiki kesejahteraan emosional, serta memperkaya pengalaman kehamilan dan persalinan. Implikasi dalam kehidupan sehari-hari mencakup perubahan pola hidup sehat, dukungan keluarga, serta tindakan preventif yang meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi. Implementasi yang tepat melalui pengkajian menyeluruh, edukasi

berkelanjutan, dan kolaborasi tim kesehatan serta keluarga menjadi kunci keberhasilan pelayanan holistik.

2. Pelayanan Holistik pada Masa Nifas

Nifas merupakan periode adaptasi fisiologis dan psikologis pasca persalinan. Risiko utama meliputi perdarahan postpartum, infeksi, gangguan laktasi, dan depresi postpartum. Strategi holistik mencakup pemantauan involusi uterus dan kondisi luka persalinan, dukungan menyusui dan teknik pemberian ASI yang benar, edukasi kesehatan psikososial dan skrining depresi postpartum, keterlibatan keluarga dalam perawatan sehari-hari, pendekatan ini meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, menurunkan depresi postpartum, dan mempercepat pemulihan ibu (Elfiani & Yulita, 2024; Irfana et al., 2024).

Pada masa nifas, strategi pelayanan holistik bertujuan mempercepat pemulihan ibu dan mencegah komplikasi. Strategi yang direkomendasikan pada masa nifas, meliputi : pemantauan fisiologis dan psikososial, pendampingan menyusui dan bonding ibu-bayi, keterlibatan keluarga.

Masa nifas, yang mencakup periode 6 minggu setelah persalinan, adalah fase kritis bagi pemulihan fisik, mental, dan sosial ibu. Pada periode ini, tubuh ibu mengalami penyesuaian fisiologis pasca persalinan, perubahan hormonal, serta adaptasi psikologis dalam peran sebagai ibu baru. Pelayanan holistik pada masa nifas bertujuan untuk mendukung pemulihan menyeluruh, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi melalui pendekatan interprofesional yang terintegrasi.

Langkah awal pelayanan holistik pada masa nifas adalah pengkajian menyeluruh. Perawat dan bidan melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kondisi uterus, perdarahan, luka episiotomi atau caesar, tanda vital, serta status laktasi. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan untuk memahami kondisi psikososial ibu, termasuk gejala depresi postpartum, kecemasan, dukungan keluarga, dan kemampuan mengurus bayi. Pengkajian holistik ini memungkinkan tim kesehatan untuk merancang intervensi individual yang mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual ibu. Selain itu, dokter, konselor, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lain dapat dilibatkan jika ditemukan risiko komplikasi atau kebutuhan khusus. Implikasi praktis: ibu yang menjalani pengkajian komprehensif lebih cepat mendapatkan intervensi tepat waktu, sehingga pemulihan fisik lebih optimal dan risiko komplikasi seperti infeksi atau perdarahan berlebih dapat diminimalkan.

Edukasi selama masa nifas menjadi komponen penting dalam pelayanan holistik. Informasi yang diberikan meliputi perawatan luka pasca persalinan dan

kebersihan diri, pengenalan tanda bahaya nifas seperti perdarahan berlebih atau demam, teknik menyusui termasuk inisiasi menyusui dini, posisi menyusui yang benar, dan stimulasi ASI, serta pola tidur, nutrisi, dan manajemen stres.

Konseling dapat dilakukan secara tatap muka di fasilitas kesehatan atau melalui kunjungan rumah, serta melalui media digital. Penyampaian yang konsisten dan berkesinambungan meningkatkan pengetahuan ibu, memotivasi perubahan perilaku, dan memperkuat kemandirian ibu dalam merawat diri dan bayinya. Peran kolaborasi tim seperti perawat, bidan, dan ahli gizi sangat diperlukan. Perawat memantau tanda vital dan memberikan edukasi kesehatan sehari-hari, bidan fokus pada pemantauan laktasi dan perawatan reproduksi dan ahli gizi memberikan panduan diet pasca persalinan untuk mempercepat pemulihan.

Dukungan psikososial dan spiritual sangat diperlukan, karena pada periode nifas seringkali diwarnai perubahan emosional yang cepat, kelelahan, dan risiko depresi postpartum. Pelayanan holistik menekankan dukungan psikososial dan spiritual untuk membantu ibu menghadapi fase ini. Pendekatan yang bisa dilakukan meliputi konseling individu untuk mengurangi kecemasan dan depresi. Kelompok dukungan ibu baru untuk berbagi pengalaman dan strategi coping. Pendampingan spiritual sesuai nilai dan keyakinan ibu, seperti doa, meditasi, atau refleksi diri. Pendekatan ini membantu ibu menyesuaikan diri secara emosional dan mental dengan peran barunya, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat hubungan dengan bayi dan keluarga. Implikasi praktis yang diberikan pada ibu yang mendapat dukungan psikososial cenderung lebih stabil secara emosional, lebih sabar dalam merawat bayi, dan lebih mampu menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dengan perawatan diri.

Intervensi komplementer selama masa nifas membantu mempercepat pemulihan fisik dan mengurangi stres. Contohnya: Latihan ringan atau senam nifas untuk memperkuat otot panggul dan meningkatkan sirkulasi, teknik relaksasi dan pernapasan untuk mengurangi ketegangan dan kelelahan serta terapi pijat pasca persalinan untuk meredakan nyeri otot dan meningkatkan kualitas tidur. Perawat dan bidan dapat memandu ibu dalam melakukan latihan ini secara aman dan sesuai kondisi kesehatan. Pendekatan komplementer juga membantu ibu memahami perubahan fisiologis tubuh dan menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan kemampuan fisik pasca persalinan. Implikasi praktis yang terjadi, ibu dapat lebih cepat kembali ke aktivitas normal, merasa lebih energik, dan mengurangi risiko stres atau kelelahan kronis.

Monitoring Berkala dan Evaluasi Kesejahteraan Ibu dan Bayi menjadi kunci keberhasilan asuhan holistik selama masa nifas. Perawat dan bidan memantau tanda vital, perdarahan, dan penyembuhan luka dan pertumbuhan bayi, pola menyusui, dan interaksi ibu-anak. Serta kesejahteraan emosional ibu, termasuk gejala depresi atau kecemasan. Hasil monitoring digunakan untuk menyesuaikan rencana perawatan, memberikan intervensi tambahan bila diperlukan, dan melibatkan anggota keluarga dalam mendukung ibu. Pendekatan ini memastikan pelayanan tetap responsif terhadap kebutuhan ibu dan bayi. Implikasi praktis: ibu merasa aman, dukungan keluarga lebih optimal, risiko komplikasi pasca persalinan berkurang, dan bayi mendapatkan perawatan yang optimal.

Pelayanan holistik pada masa nifas merupakan pendekatan komprehensif yang menyatukan aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan edukasi kesehatan. Dengan kolaborasi lintas profesi, pendekatan ini mampu mempercepat pemulihan ibu, meningkatkan kemampuan menyusui, menurunkan risiko depresi postpartum, dan memperkuat keterikatan ibu-bayi. Implementasi strategi ini dalam praktik sehari-hari menghasilkan ibu yang lebih sehat, siap menjalankan peran sebagai orang tua, dan mendukung pertumbuhan optimal bayi.

3. Asuhan Holistik pada Bayi Baru Lahir

Perawatan neonatal fokus pada adaptasi fisiologis, pertumbuhan awal, dan pencegahan komplikasi. Pendekatan meliputi pemantauan tanda vital, suhu, dan fungsi organ utama. Perawatan tali pusat dan praktik higienis, inisiasi menyusui dini dan dukungan pemberian ASI, *Kangaroo Mother Care (KMC)*, terutama untuk bayi berat lahir rendah, dan edukasi orang tua untuk deteksi dini tanda bahaya. Pendekatan ini meningkatkan stabilitas fisiologis bayi, memperkuat ikatan ibu-bayi, dan menurunkan mortalitas neonatal (Albarqi, 2025; Nguyen et al., 2022).

C. Kolaborasi Interprofesional

Pelayanan holistik membutuhkan kerja sama perawat, bidan, dokter, ahli gizi, dan psikolog. Kolaborasi interprofesional meningkatkan kesinambungan layanan, optimisasi sumber daya, dan deteksi dini komplikasi, serta mendukung implementasi standar pelayanan nasional (Adnani et al., 2025; Feriani et al., 2025).

Pelayanan keperawatan maternitas yang holistik menuntut keterlibatan berbagai profesi kesehatan dalam suatu kerja sama yang terencana dan berkesinambungan. Kolaborasi interprofesional menjadi pendekatan strategis

untuk menjawab kompleksitas kebutuhan ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek klinis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual. Melalui kolaborasi ini, pelayanan kesehatan tidak lagi berjalan secara terpisah antarprofesi, melainkan terintegrasi dalam satu tujuan bersama, yaitu peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh.

Dalam praktik keperawatan maternitas, kolaborasi interprofesional menekankan komunikasi yang efektif, pemahaman peran masing-masing profesi, serta pengambilan keputusan bersama berdasarkan kebutuhan individu ibu dan bayi. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan keselamatan pasien, memperkuat kontinuitas asuhan, serta menurunkan risiko terjadinya komplikasi maternal dan neonatal. Dengan demikian, kolaborasi interprofesional merupakan fondasi penting dalam penerapan pelayanan holistik yang berbasis bukti.

1. Kolaborasi Interprofesional pada Pelayanan Ibu Hamil

Pada masa kehamilan, kolaborasi interprofesional difokuskan pada upaya promotif dan preventif untuk mendukung kehamilan yang sehat. Perawat berperan dalam melakukan pengkajian komprehensif, memberikan edukasi kesehatan, serta memantau adaptasi fisik dan psikologis ibu hamil. Bidan dan dokter berkontribusi dalam pemantauan klinis, penegakan diagnosis, serta penatalaksanaan kondisi kehamilan berisiko.

Selain itu, keterlibatan ahli gizi menjadi penting dalam memastikan kecukupan nutrisi ibu dan pertumbuhan janin, sementara dukungan psikolog atau konselor dibutuhkan untuk membantu ibu mengelola kecemasan dan stres selama kehamilan. Kolaborasi lintas profesi ini memungkinkan penyusunan rencana asuhan yang lebih personal, komprehensif, dan responsif terhadap kebutuhan ibu hamil.

2. Kolaborasi Interprofesional pada Pelayanan Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode adaptasi yang rentan terhadap gangguan fisik dan psikologis, sehingga membutuhkan pelayanan yang terkoordinasi dengan baik. Dalam fase ini, perawat dan bidan berperan aktif dalam memantau pemulihan fisiologis ibu, mendukung proses menyusui, serta memberikan edukasi perawatan diri. Dokter berperan dalam penanganan komplikasi nifas, seperti perdarahan atau infeksi, sedangkan konselor laktasi mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

Aspek kesehatan mental juga menjadi perhatian utama pada masa nifas. Oleh karena itu, kolaborasi dengan psikolog atau psikiater diperlukan untuk melakukan skrining depresi postpartum dan memberikan intervensi yang tepat.

Melalui kolaborasi interprofesional yang efektif, pelayanan masa nifas dapat mendukung pemulihan ibu secara optimal, baik secara fisik maupun emosional.

3. Kolaborasi Interprofesional pada Pelayanan Bayi Baru Lahir

Pelayanan bayi baru lahir menuntut pendekatan holistik yang menitikberatkan pada adaptasi fisiologis awal kehidupan dan pencegahan komplikasi neonatal. Perawat neonatal dan bidan berperan dalam pemantauan kondisi bayi, pelaksanaan inisiasi menyusui dini, serta edukasi orang tua mengenai perawatan bayi. Dokter anak atau neonatologis terlibat dalam penatalaksanaan bayi dengan kondisi risiko tinggi atau gangguan adaptasi.

Kolaborasi dengan ahli gizi diperlukan untuk mendukung perencanaan nutrisi bayi, khususnya pada bayi dengan berat lahir rendah atau kebutuhan khusus. Selain itu, tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam memastikan keberlanjutan perawatan bayi di lingkungan keluarga melalui edukasi dan pemantauan pascapulang dari fasilitas kesehatan. Sinergi antarprofesi ini memperkuat kesinambungan asuhan dan meningkatkan kualitas hidup bayi sejak awal kehidupannya.

4. Penguatan Kolaborasi Interprofesional dalam Pelayanan Holistik

Meskipun kolaborasi interprofesional memiliki manfaat yang signifikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan persepsi peran, keterbatasan komunikasi, dan hambatan struktural dalam sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kolaborasi melalui peningkatan kompetensi komunikasi antarprofesi, pendidikan interprofesional sejak masa pendidikan, serta dukungan kebijakan yang mendorong praktik kolaboratif.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi sarana pendukung kolaborasi, terutama dalam hal pencatatan asuhan terintegrasi dan koordinasi rujukan. Dengan penguatan kolaborasi interprofesional, pelayanan holistik dalam keperawatan maternitas dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kolaborasi interprofesional merupakan elemen kunci dalam pelayanan holistik keperawatan maternitas. Sinergi antarprofesi memungkinkan pemenuhan kebutuhan ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, tetapi juga mencerminkan praktik keperawatan modern yang berorientasi pada keselamatan, kualitas, dan kemanusiaan.

D. Strategi Implementasi Pelayanan Holistik Berbasis Bukti

Pelayanan holistik berbasis bukti dalam keperawatan maternitas menekankan integrasi bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis perawat, serta nilai dan kebutuhan ibu, bayi, dan keluarga. Strategi implementasi dilakukan secara berkesinambungan pada setiap fase, mulai dari kehamilan, masa nifas, hingga perawatan bayi baru lahir, dengan tujuan meningkatkan luaran kesehatan maternal dan neonatal secara komprehensif.

1. Strategi Implementasi Pelayanan Holistik Berbasis Bukti pada Ibu Hamil

Pelayanan holistik pada ibu hamil bertujuan mendukung adaptasi fisiologis dan psikologis kehamilan, mencegah komplikasi, serta mempersiapkan ibu menghadapi persalinan.

Strategi implementasi meliputi Pengkajian Komprehensif Berbasis Bukti, Edukasi Kesehatan dan Pemberdayaan Ibu, Dukungan Psikososial dan Manajemen Stres, Kolaborasi Interprofesional.

Perawat melakukan pengkajian menyeluruh yang mencakup status fisik (tekanan darah, status gizi, tanda anemia), psikologis (kecemasan, stres), sosial (dukungan keluarga), dan spiritual. Pendekatan ini terbukti efektif dalam deteksi dini risiko kehamilan dan pencegahan komplikasi (WHO, 2016; Nguyen et al., 2022).

Edukasi berbasis bukti tentang gizi seimbang, suplementasi zat besi dan asam folat, aktivitas fisik aman, serta pengenalan tanda bahaya kehamilan diberikan secara individual dan berkelanjutan. Edukasi yang baik meningkatkan kepatuhan antenatal care dan perilaku perawatan diri ibu hamil.

Dukungan Psikososial dan Manajemen Stres dengan intervensi nonfarmakologis seperti konseling, teknik relaksasi, mindfulness, dan prenatal yoga diintegrasikan dalam pelayanan, karena terbukti menurunkan kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu hamil.

Kolaborasi Interprofesional dengan implementasi pelayanan holistik dilakukan melalui kerja sama antara perawat, bidan, dokter, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan kesinambungan dan kualitas asuhan.

2. Strategi Implementasi Pelayanan Holistik Berbasis Bukti pada Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode transisi yang rentan terhadap komplikasi fisik dan psikologis, sehingga membutuhkan pelayanan holistik yang berkesinambungan. Strategi implementasi meliputi pemantauan fisiologis dan pencegahan komplikasi, dukungan menyusui dan perawatan diri ibu, skrining dan dukungan kesehatan mental, serta pelibatan keluarga dalam asuhan nifas.

Perawat melakukan pemantauan involusi uterus, perdarahan postpartum, tanda infeksi, dan kondisi luka persalinan secara sistematis berdasarkan pedoman berbasis bukti. Pendampingan laktasi, edukasi teknik menyusui yang benar, serta perawatan payudara diberikan untuk mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Intervensi ini terbukti meningkatkan keberhasilan menyusui dan pemulihan ibu. Skrining depresi postpartum menggunakan instrumen valid, seperti *Edinburgh Postnatal Depression Scale*, menjadi bagian penting dari asuhan holistik. Dukungan emosional dan rujukan tepat waktu mencegah dampak jangka panjang gangguan mental ibu. Keluarga dilibatkan secara aktif dalam perawatan ibu, termasuk dukungan emosional dan pemantauan tanda bahaya, untuk memperkuat adaptasi ibu pada masa nifas.

3. Strategi Implementasi Pelayanan Holistik Berbasis Bukti pada Bayi Baru Lahir

Pelayanan holistik pada bayi baru lahir berfokus pada adaptasi fisiologis, pencegahan komplikasi, dan penguatan ikatan ibu-bayi. Strategi implementasi meliputi pemantauan adaptasi fisiologis neonatal, inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif, perawatan tali pusat dan pencegahan infeksi, serta Edukasi Orang Tua dan Keluarga.

Perawat memantau suhu tubuh, pernapasan, denyut jantung, dan warna kulit bayi sesuai standar praktik berbasis bukti untuk mencegah hipotermia dan gangguan adaptasi awal. Inisiasi menyusui dini dan dukungan ASI eksklusif diterapkan sebagai intervensi utama, karena terbukti menurunkan angka kesakitan dan kematian neonatal. Praktik perawatan tali pusat yang bersih dan aman berdasarkan rekomendasi WHO diimplementasikan untuk mencegah infeksi neonatal. Orang tua diberikan edukasi mengenai perawatan bayi, tanda bahaya neonatal, imunisasi, dan stimulasi dini, sehingga keluarga mampu melanjutkan perawatan secara mandiri di rumah.

E. Penutup

1. Sintesis Temuan dan Pemaknaan Asuhan Holistik

Bab ini merangkum secara komprehensif pembahasan mengenai keperawatan maternitas dengan penekanan pada pelayanan holistik bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Uraian pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan maternitas tidak dapat lagi dipahami secara sempit sebagai serangkaian tindakan klinis yang berfokus pada aspek biologis semata. Kehamilan, persalinan, masa nifas, dan periode neonatal merupakan

fase transisi kehidupan yang kompleks, di mana perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual terjadi secara simultan dan saling memengaruhi.

Pendekatan holistik dalam keperawatan maternitas menempatkan ibu dan bayi sebagai pusat asuhan dengan memperhatikan keseutuhan manusia secara biopsikososial-spiritual. Temuan ilmiah yang telah dibahas menguatkan bahwa pelayanan holistik berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ibu, kesiapan menghadapi persalinan, keberhasilan adaptasi masa nifas, serta kesehatan dan tumbuh kembang bayi baru lahir. Selain itu, keterlibatan keluarga dan kolaborasi interprofesional terbukti memperkuat kesinambungan asuhan dan meningkatkan efektivitas pencegahan komplikasi maternal dan neonatal.

Dengan demikian, keperawatan maternitas berbasis holistik tidak hanya berorientasi pada luaran klinis jangka pendek, tetapi juga pada kualitas hidup ibu dan bayi dalam jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma keperawatan modern yang menekankan praktik berbasis bukti, pemberdayaan pasien, dan pelayanan yang berpusat pada manusia (*person-centered care*).

2. Arah Pengembangan Keperawatan Maternitas di Masa Depan

Ke depan, pelayanan holistik dalam keperawatan maternitas memiliki peluang besar untuk terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak. Integrasi teknologi digital, seperti telenursing, aplikasi edukasi kehamilan, dan sistem pencatatan kesehatan terintegrasi, membuka ruang baru bagi penguatan pelayanan holistik yang lebih inklusif dan berkelanjutan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.

Namun demikian, berbagai tantangan masih perlu diantisipasi. Keterbatasan sumber daya manusia keperawatan, beban kerja yang tinggi, kesenjangan kualitas layanan antarwilayah, serta belum optimalnya implementasi kolaborasi interprofesional menjadi hambatan dalam penerapan pelayanan holistik secara konsisten. Di samping itu, perbedaan latar belakang sosial budaya dan tingkat literasi kesehatan masyarakat menuntut pendekatan yang adaptif dan kontekstual.

Oleh karena itu, pengembangan keperawatan maternitas di masa depan memerlukan dukungan sistem kesehatan yang kuat, kebijakan yang berpihak pada pelayanan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas tenaga keperawatan dalam mengintegrasikan pendekatan holistik dan berbasis bukti ke dalam praktik sehari-hari.

3. Implikasi dan Rekomendasi untuk Praktik, Pendidikan, dan Penelitian

Sebagai penutup, beberapa implikasi dan rekomendasi yang dapat dirumuskan dari pembahasan dalam book chapter ini adalah sebagai berikut:

a. Implikasi bagi Praktik Keperawatan Maternitas

Pelayanan keperawatan maternitas perlu secara konsisten mengadopsi pendekatan holistik dalam setiap tahap asuhan, mulai dari kehamilan, persalinan, masa nifas, hingga perawatan bayi baru lahir. Perawat diharapkan mampu melakukan pengkajian komprehensif, memberikan dukungan psikososial, serta memberdayakan ibu dan keluarga sebagai mitra dalam perawatan.

b. Implikasi bagi Pendidikan Keperawatan

Institusi pendidikan keperawatan perlu memperkuat kurikulum keperawatan maternitas dengan pendekatan holistik dan berbasis bukti, termasuk pengembangan keterampilan komunikasi terapeutik, kolaborasi interprofesional, dan sensitivitas budaya. Hal ini penting untuk mempersiapkan perawat yang adaptif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan modern.

c. Implikasi bagi Kebijakan dan Sistem Kesehatan

Dukungan kebijakan yang mendorong pemerataan tenaga keperawatan, peningkatan kompetensi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan holistik dapat diimplementasikan secara optimal dan berkeadilan.

d. Rekomendasi bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian di masa mendatang disarankan untuk mengkaji efektivitas berbagai model pelayanan holistik dalam keperawatan maternitas, khususnya dalam konteks sosial budaya Indonesia, serta mengevaluasi dampaknya terhadap luaran kesehatan ibu dan bayi dalam jangka panjang.

Penguatan kompetensi perawat melalui pelatihan, workshop, dan pedoman berbasis bukti. Peningkatan edukasi dan keterlibatan keluarga dalam setiap fase asuhan. Integrasi layanan interprofesional untuk rencana asuhan yang terkoordinasi. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan, edukasi, dan reminder kunjungan. Dukungan kebijakan pemerintah untuk distribusi tenaga kesehatan, fasilitas standar, dan pemantauan kualitas layanan. Pendekatan holistik berbasis bukti tidak hanya meningkatkan hasil klinis, tetapi juga kualitas hidup ibu, bayi, dan keluarga secara menyeluruh, mendukung tercapainya Indonesia Sehat 2045.

Sebagai penutup book chapter ini, dapat ditegaskan bahwa keperawatan maternitas dengan pelayanan holistik merupakan fondasi penting dalam

pembangunan kesehatan ibu dan anak. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kualitas pelayanan klinis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan keberlanjutan yang menjadi inti dari praktik keperawatan profesional. Dengan komitmen bersama antara praktisi, pendidik, peneliti, dan pembuat kebijakan, pelayanan keperawatan maternitas holistik diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan.

F. Referensi

- Adnani, Q. E. S., Maulina, R., Ramadhan, K., et al. (2025). Trends and determinants of antenatal, intranatal, and postnatal care utilization among Indonesian women (2012–2017). *BMC Nursing*, 24, 912. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-03527-6>
- Albarqi, M. N. (2025). The impact of prenatal care on the prevention of neonatal outcomes: A systematic review and meta-analysis of global health interventions. *Healthcare*, 13(9), 1076. <https://doi.org/10.3390/healthcare13091076>
- Beddoe, A. E., & Lee, K. A. (2018). Mind-body interventions during pregnancy. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 47(2), 217–227. <https://doi.org/10.1016/j.jogn.2017.11.003>
- Dunkel Schetter, C., & Tanner, L. (2019). Anxiety, depression and stress in pregnancy: Implications for mothers, children, research, and practice. *Current Opinion in Psychiatry*, 32(2), 79–85. <https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000475>
- Elfiani, Z., & Yulita, N. (2024). Pendekatan kebidanan holistik untuk mensejahterakan dan relaksasi dengan pijat pada ibu nifas. *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan*, 2(4), 146–153. <https://journal.arikesi.or.id/index.php/Corona/article/view/858>
- Ellyzabeth Sukmawati & Titi Alfiani. (2025). Holistic approaches during pregnancy and their implications for midwifery practice. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*, 5(1), 149–161. <https://doi.org/10.55606/jikki.v5i1.6244>
- Faktor-faktor yang berhubungan dengan inovasi asuhan kebidanan holistik. (2025). *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*. Barr, H., Koppel, I., Reeves, S., Hammick, M., & Freeth, D. (2016). *Effective interprofessional education: Argument, assumption and evidence*. Wiley-Blackwell.
- Fathia Rizki. (2022). *Application of antenatal care with a holistic approach in reducing anxiety. Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*.

- Feriani, P., Meylawati, L. E., Wahyuni, T., & Sipasulta, G. C. (2025). *Keperawatan Maternitas: Asuhan Holistik pada Ibu, Bayi, dan Keluarga*. PT. Bukuloka Literasi Bangsa.
- Field, T. (2017). Prenatal anxiety effects: A review. *Infant Behavior and Development*, 49, 120–128. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2017.08.008>
- Hasnah, H., Gani, N. F., Nurhidayah, & Rahmi, A. N. (2025). Supporting pregnant women through telenursing to improve spiritual literacy during pregnancy. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas*, 5(2), 1–10.
- Irfana, I., Jalifah, J., Nisa, E., Bakri, S. H., & Nurdiana, N. (2024). Continuity of care fisiologi pada ibu dan bayi baru lahir. *Jurnal Ilmiah Kebidanan dan Kesehatan*, 2(1), 1–7. <https://salnesia.id/jibi/article/view/965>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Kementerian Kesehatan RI. <https://ojs3.poltekkes-mks.ac.id/index.php/medkes/article/download/1340/663/10013>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia 2021*. Kementerian Kesehatan RI.
- Nguyen, L. D., Nguyen, L. H., Ninh, L. T., et al. (2022). Holistic self-care behaviors during pregnancy and psychological well-being. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22, 631. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04961-z>
- Nguyen, L. D., Nguyen, L. H., Ninh, L. T., et al. (2022). Women's holistic self-care behaviors during pregnancy and associations with psychological well-being: Implications for maternal care facilities. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22, 631. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04961-z>
- Paket edukasi ibu hamil untuk mewujudkan anak sehat melalui pendekatan asuhan kebidanan holistik. (2024). *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*.
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6, CD000072. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub3>
- Tavazuli Clara Dheanda, Bedjo Santoso & Sri Wahyuni. (2025). *Kelas persiapan persalinan secara holistik terhadap kecemasan dan self efficacy menghadapi persalinan*. *Journal of Telenursing (JOTING)*.
- Tri Endah Suryani & Erli Zainal. (2022). Asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil gangguan tidur dengan melakukan prenatal yoga. *Jurnal Kebidanan Besurek*.
- World Health Organization. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. WHO Press.

- World Health Organization. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. WHO Press.
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. WHO Press.
- World Health Organization. (2010). *Framework for action on interprofessional education and collaborative practice*. WHO Press.
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. WHO Press.

CHAPTER 4

KEPERAWATAN JIWA: MANAJEMEN STRES, ANSIETAS DAN PENDEKATAN TERAPI KEPERAWATAN

Ns. Jumilia, S.Kep., M.Kep., Ph.D.

A. Pendahuluan

Kesehatan Jiwa adalah kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka, belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitas mereka. Kesehatan jiwa memiliki nilai intrinsik dan instrumental, serta merupakan hak asasi manusia mendasar. Kesehatan mental berada pada kontinum yang kompleks, yang dialami secara berbeda oleh setiap orang. Pada waktu tertentu, beragam faktor individu, keluarga, komunitas, dan struktural dapat bergabung untuk melindungi atau merusak kesehatan mental. Meskipun sebagian besar orang tangguh, orang yang terpapar keadaan buruk berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental (WHO, 2025).

Kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan secara menyeluruh yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Individu dengan kesehatan jiwa yang baik mampu mengenali potensi dirinya, mengelola stres kehidupan, bekerja secara produktif, serta berperan aktif di masyarakat. Sebaliknya, apabila kesehatan jiwa terganggu maka dapat terjadi gangguan jiwa yang ditandai dengan perubahan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang menyimpang dari realitas dan norma sosial (Franjić, S. 2022).

Keperawatan jiwa merupakan bagian dari keperawatan profesional yang berfokus pada respons manusia terhadap masalah kesehatan mental, termasuk stres dan ansietas sebagai masalah psikososial yang paling sering dijumpai dalam praktik keperawatan. Stres dan ansietas dapat dialami oleh individu sehat maupun sakit dan berpengaruh terhadap fungsi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. (Stuart, 2016; Keliat et al., 2020).

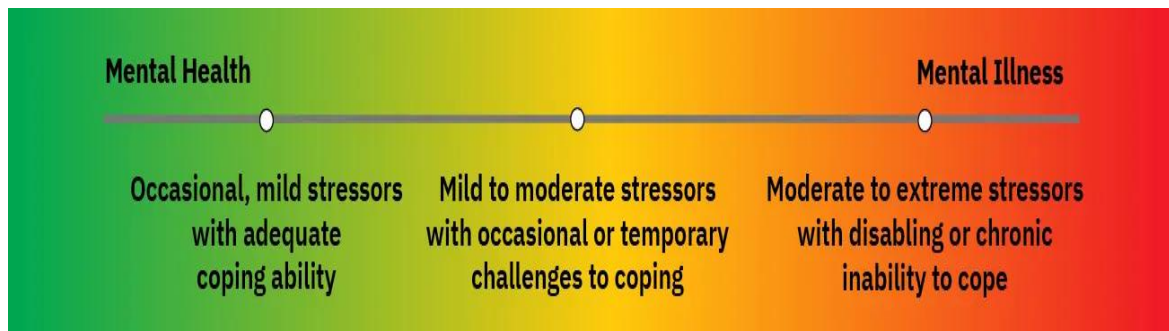
WHO menyebutkan bahwa sebanyak 1 dari 7 remaja usia 10-19 tahun di dunia pernah mengalami gangguan mental (seperti depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Banyak yang mulai merasakan masalah kesehatan mental sejak usia 14-18 tahun. Namun kenyataannya, lebih dari setengah remaja tidak mencari bantuan

karena takut, malu, atau tidak tahu harus ke mana (Dinas Kesehatan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025).

Survei I-NAMHS juga memperoleh temuan bahwa satu dari tiga remaja (34,9%), setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia, memiliki satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Satu dari dua puluh remaja (5,5%), setara dengan 2,45 juta remaja Indonesia, memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Sebanyak 1% remaja mengalami depresi, 3,7% cemas, post traumatic syndrome disorder (SPTSD) 0,9%, dan attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) sebanyak 0,5%. Namun, hanya 2,6% dari mereka yang pernah mengakses layanan konseling atau dukungan profesional dalam 12 bulan terakhir (Dinas Kesehatan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025).

Data SKI 2023 juga menunjukkan bahwa kelompok usia 15-24 tahun memiliki prevalensi depresi tertinggi, yaitu sebesar 2,0%. Namun, kelompok usia ini menjadi yang paling sedikit mencari pengobatan atau bantuan profesional untuk depresi, yaitu hanya sekitar 10,4%. Masalah kesehatan jiwa pada kelompok usia 15-24 tahun juga menempati posisi tertinggi kedua dengan prevalensi 2,8%. Sebanyak 0,39% penduduk usia 15-24 tahun bahkan pernah memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup yang menandakan adanya tekanan mental yang serius pada kelompok ini (Dinas Kesehatan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025).

Kondisi jiwa yang tidak sehat dapat membuat seseorang rentan terhadap konflik dan kesulitan menemukan solusi secara adaptif. Kesehatan jiwa dan fisik saling memengaruhi. Misalnya, kondisi fisik yang lemah dapat memicu masalah kesehatan jiwa, sementara gangguan jiwa dapat menyebabkan keluhan fisik seperti tekanan darah tinggi, sakit kepala, otot tegang, atau sakit perut. Masalah kesehatan mental seperti stres dan ansietas merupakan pengalaman hampir universal yang dialami pasien di berbagai setting klinis serta tenaga kesehatan sendiri, termasuk perawat. Kondisi ini berhubungan dengan respons adaptif tubuh terhadap faktor tekanan internal dan eksternal yang dapat merusak keseimbangan psikologis individu jika tidak dikelola dengan efektif. Konsep ini dijabarkan dalam literatur keperawatan sebagai bagian penting dari keperawatan jiwa yang berorientasi pada pemulihan kesejahteraan pasien (APA, 2022).



Gambar 3.1: Kesehatan mental dan penyakit mental berada pada suatu kontinum.
(Sumber: Hak Cipta Universitas Rice, OpenStax, di bawah lisensi CC BY 4.0)

Grafik berwarna yang menunjukkan kontinum dari Kesehatan Mental (kiri) hingga Penyakit Mental (kanan). Dari kiri ke kanan, teks mencakup "Stresor ringan sesekali dengan kemampuan mengatasi yang memadai," "Stresor ringan hingga sedang dengan tantangan sesekali atau sementara dalam mengatasi," dan "Stresor sedang hingga ekstrem dengan ketidakmampuan atau ketidakmampuan kronis untuk mengatasi" (Beck, A. T., & Emery, G. (1985).

Kesehatan mental berfluktuasi sepanjang rentang hidup seseorang dan dapat berkisar dari kesejahteraan hingga masalah emosional dan/atau penyakit mental, seperti yang ditunjukkan pada kontinum kesehatan mental. Kesejahteraan berada pada rentang "sehat" dalam kontinum kesehatan mental, di mana individu mengalami keadaan kesehatan mental dan emosional yang baik. Mereka mungkin mengalami stres dan ketidaknyamanan akibat masalah sesekali dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka mampu mengatasi stresor tersebut secara efektif dan tidak mengalami gangguan pada fungsi sehari-hari (Beck, A. T., & Emery, G. (1985).

B. Manajemen Stres

1. Teori Stres

a. Teori Stres Lazarus dan Folkman

Teori transaksional stres dan koping yang dikembangkan oleh Lazarus dan Folkman menjelaskan bahwa stres terjadi akibat interaksi antara individu dan lingkungan. Stres muncul ketika individu menilai (appraisal) suatu situasi sebagai ancaman atau beban yang melebihi sumber daya koping yang dimiliki (Lazarus & Folkman, 1984). Penilaian primer (primary appraisal) melibatkan evaluasi individu terhadap tingkat ancaman suatu stresor, sedangkan penilaian sekunder (secondary appraisal) berkaitan dengan evaluasi kemampuan individu dalam mengatasi stresor tersebut. Kedua proses ini menentukan respons emosional dan perilaku individu terhadap stres (Lazarus & Folkman, 1984).

Teori ini sangat relevan dalam keperawatan jiwa karena membantu perawat memahami bahwa intervensi tidak hanya ditujukan pada penghilangan stresor, tetapi juga pada perubahan persepsi dan peningkatan kemampuan coping klien (Stuart, 2021).

b. General Adaptation Syndrome (GAS)

Hans Selye mengemukakan konsep General Adaptation Syndrome (GAS) yang menggambarkan respons fisiologis tubuh terhadap stres dalam tiga tahap, yaitu tahap alarm, resistensi, dan kelelahan. Pada tahap alarm, tubuh mengaktifkan sistem saraf simpatik sebagai respons awal terhadap stres (Selye, 1976). Apabila stres berlanjut, tubuh memasuki tahap resistensi, di mana mekanisme adaptasi berusaha mempertahankan keseimbangan. Namun, stres yang berlangsung lama tanpa coping efektif akan menyebabkan tahap kelelahan, yang meningkatkan risiko gangguan fisik dan mental seperti ansietas, depresi, dan gangguan psikosomatik (Selye, 1976; Halter, 2018).

Pemahaman tentang GAS membantu perawat jiwa mengenali tanda-tanda stres kronis dan dampaknya terhadap kesehatan klien, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut (Varcarolis, 2021).

2. Pengertian Stress

Setiap orang mengalami stres selama hidupnya. Tingkat stres yang tinggi dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala, sakit punggung, dan gejala gangguan pencernaan. Stres kronis dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit kronis, serta penyakit fisik akut, karena penurunan efektivitas sistem kekebalan tubuh dan dampaknya pada sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA). Dampak HPA dibahas lebih rinci di bawah ini. Penting bagi perawat untuk mengenali tanda dan gejala stres pada diri mereka sendiri dan orang lain, serta mendorong strategi manajemen stres yang efektif. Bagian ini dimulai dengan tinjauan umum tentang respons stres dan tanda serta gejalanya, diikuti dengan pembahasan teknik manajemen stres (APA, 2024).

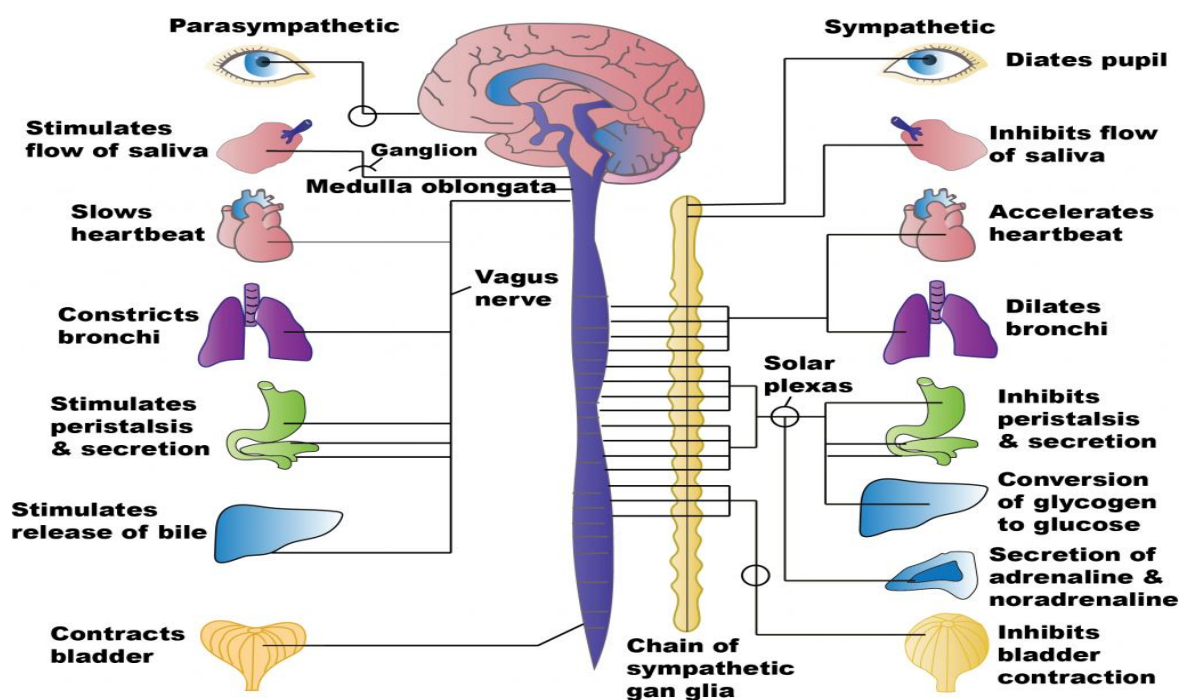
Stresor adalah setiap peristiwa, kekuatan, atau kondisi internal atau eksternal yang mengakibatkan stres fisik atau emosional (APA, 2024). Sistem saraf simpatik (SNS) tubuh merespons stresor aktual atau yang dirasakan dengan respons stres "melawan, melarikan diri, membeku, atau tunduk". Beberapa reaksi terjadi selama respons stres yang membantu individu mencapai tujuan melawan atau melarikan diri. Stres didefinisikan sebagai respons adaptif individu terhadap tuntutan internal maupun eksternal yang dipersepsikan melebihi kemampuan

koping individu. Stres tidak selalu bersifat negatif, namun dapat menjadi motivator bila berada pada tingkat adaptif. (Notoatmodjo, 2018).

Beberapa perubahan fisiologis terjadi: Sistem pernapasan, kardiovaskular, dan muskuloskeletal aktif untuk meningkatkan pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah, memastikan darah yang mengandung oksigen mencapai otot. Hati melepaskan glukosa untuk menyediakan energi untuk tindakan segera. Pupil melebar untuk meningkatkan penglihatan. Berkeringat mencegah panas berlebih akibat peningkatan aktivitas otot. Sistem pencernaan melambat, mengarahkan aliran darah ke otot-otot penting. Respons ini dikoordinasikan oleh sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA), yang melepaskan hormon seperti epinefrin, norepinefrin, dan glukokortikoid (termasuk kortisol, "hormon stres"). Hormon-hormon ini menargetkan reseptor SNS di seluruh tubuh, memastikan reaksi sistemik yang cepat (Betts, J. G., et. al, 2022).

Dalam respons "menjilat", yang sangat umum terjadi pada individu yang mengalami trauma relasional, tubuh mungkin masih mengaktifkan jalur yang berhubungan dengan stres, tetapi fokus perilaku bergeser ke arah menyenangkan atau menenangkan orang lain untuk mencegah bahaya. Meskipun kurang terlihat secara fisik, menjilat masih didorong oleh sistem biologis yang sama yang mencari keselamatan dalam ancaman yang dirasakan. Setelah ancaman mereda, sistem saraf parasimpatik (PNS) melawan SNS, mengembalikan tubuh ke keadaan sebelum stres (Beck, A. T., & Emery, G. (1985)).

Gambar 3.1: untuk perbandingan efek SNS dan PNS.



Respons fisiologis atau psikologis terhadap stresor internal atau eksternal. Stres melibatkan perubahan yang memengaruhi hampir setiap sistem tubuh, memengaruhi perasaan dan perilaku seseorang. Misalnya, stres dapat dimanifestasikan oleh jantung berdebar, keringat berlebih, mulut kering, sesak napas, gelisah, bicara cepat, peningkatan emosi negatif (jika sudah dialami), dan durasi kelelahan akibat stres yang lebih lama (APA, 2024).

Stres didefinisikan sebagai respons adaptif individu terhadap tuntutan internal maupun eksternal yang dipersepsikan melebihi kemampuan coping yang dimiliki. Konsep stres tidak hanya berkaitan dengan kejadian yang dialami individu, tetapi juga bagaimana individu menilai dan merespons kejadian tersebut secara kognitif dan emosional (Lazarus & Folkman, 1984). Dalam keperawatan jiwa, stres dipahami sebagai fenomena biopsikososial yang memengaruhi fungsi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual individu. Stres dapat bersifat adaptif (eustress) yang memotivasi individu untuk berkembang, atau maladaptif (distress) yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik apabila berlangsung kronis (Stuart, 2021).

Perawat jiwa perlu memahami bahwa stres merupakan pengalaman subjektif yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman hidup, sistem nilai, dan dukungan sosial individu. Oleh karena itu, pengkajian stres harus dilakukan secara individual dan holistik untuk menghasilkan intervensi yang tepat sasaran (Varcarolis, 2021).

3. Penyebab, Jenis dan Sumber Stres

Faktor penyebab stres meliputi faktor biologis, psikologis, dan sosial seperti penyakit fisik, konflik peran, tekanan pekerjaan, serta masalah keluarga. Ketidakmampuan individu mengelola stres dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. (Hawari, 2016).

Stres dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi dan sumbernya. Berdasarkan durasi, stres dibagi menjadi stres akut dan stres kronis. Stres akut bersifat sementara dan biasanya berkaitan dengan peristiwa tertentu, sedangkan stres kronis berlangsung dalam jangka panjang dan sering kali berkaitan dengan masalah kehidupan yang kompleks (Stuart, 2021).

Berdasarkan sumbernya, stres dapat berasal dari faktor internal seperti konflik intrapersonal, penyakit kronis, dan masalah psikologis, maupun faktor eksternal seperti tekanan pekerjaan, masalah keluarga, dan kondisi sosial ekonomi. Kombinasi berbagai stresor ini dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap gangguan kesehatan mental (Halter, 2018).

Dalam konteks keperawatan jiwa, stresor psikososial seperti kehilangan, trauma, dan perubahan peran sosial sering menjadi pemicu utama masalah kejiwaan. Oleh karena itu, perawat perlu mengidentifikasi stresor utama klien untuk merancang intervensi keperawatan yang efektif (Townsend & Morgan, 2021).

4. Respons Individu terhadap Stres

Respons individu terhadap stres melibatkan perubahan fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Respons fisiologis meliputi peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan kadar hormon stres seperti kortisol, yang bertujuan mempersiapkan tubuh menghadapi ancaman (McEwen, 2017).

Respons emosional terhadap stres dapat berupa kecemasan, iritabilitas, kemarahan, atau perasaan tidak berdaya. Respons ini sering kali disertai perubahan kognitif seperti kesulitan konsentrasi, pikiran negatif, dan penilaian diri yang rendah (Stuart, 2021).

Perubahan perilaku akibat stres dapat mencakup gangguan tidur, perubahan pola makan, penarikan diri sosial, serta penggunaan mekanisme koping maladaptif seperti penyalahgunaan zat. Perawat jiwa harus mampu mengenali pola respons ini sebagai dasar pengkajian dan intervensi keperawatan (Varcarolis, 2021).

5. Konsep Koping dalam Manajemen Stres

Koping didefinisikan sebagai upaya kognitif dan perilaku individu untuk mengelola tuntutan internal dan eksternal yang dipersepsikan sebagai stres. Koping dapat bersifat adaptif atau maladaptif tergantung pada efektivitasnya dalam mengurangi stres dan mempertahankan kesejahteraan individu (Lazarus & Folkman, 1984).

Koping adaptif mencakup strategi problem-focused coping yang berfokus pada pemecahan masalah, serta emotion-focused coping yang bertujuan mengelola respons emosional terhadap stres. Kedua strategi ini dapat digunakan secara bersamaan tergantung pada situasi yang dihadapi (Stuart, 2021).

Sebaliknya, koping maladaptif seperti penghindaran, penyangkalan, dan penggunaan zat adiktif dapat memperburuk stres dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Perawat jiwa berperan penting dalam membantu klien mengembangkan koping adaptif melalui edukasi dan dukungan terapeutik (Halter, 2018).

6. Manajemen Stres dalam Keperawatan Jiwa

Manajemen stres dalam keperawatan jiwa merupakan serangkaian intervensi terapeutik yang bertujuan membantu klien mengenali stresor, memahami respons stres, dan mengembangkan strategi koping adaptif. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan klien untuk mengelola stres secara mandiri dan berkelanjutan (Varcarolis, 2021).

Intervensi manajemen stres meliputi teknik relaksasi, latihan pernapasan, mindfulness, restrukturisasi kognitif, dan peningkatan dukungan sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi ini efektif dalam menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kualitas hidup klien dengan masalah kesehatan mental (Hofmann et al., 2010).

Teknik manajemen stres meliputi relaksasi napas dalam, distraksi, latihan mindfulness, dan dukungan sosial. Intervensi ini terbukti efektif menurunkan tingkat stres pada klien keperawatan jiwa. (Videbeck, 2017). Dalam praktik keperawatan jiwa, manajemen stres harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan konteks sosial budaya klien. Pendekatan individual dan kolaboratif antara perawat, klien, dan keluarga menjadi kunci keberhasilan intervensi (Townsend & Morgan, 2021).

7. Peran Perawat dalam Manajemen Stres

Perawat jiwa berperan sebagai fasilitator dalam membantu klien mengidentifikasi stresor dan respons stres yang dialami. Melalui komunikasi terapeutik, perawat dapat menciptakan lingkungan yang aman dan suportif sehingga klien merasa nyaman untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya (Peplau, 1997).

Selain itu, perawat berperan sebagai edukator yang memberikan informasi tentang stres, dampaknya, dan strategi pengelolaannya. Edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran klien dan mendorong partisipasi aktif dalam proses perawatan (Stuart, 2021).

Perawat juga perlu berkolaborasi dengan tim kesehatan lain dalam merancang dan mengevaluasi program manajemen stres, terutama pada klien dengan stres kronis atau gangguan mental berat. Kolaborasi interdisipliner terbukti meningkatkan hasil perawatan dan kepuasan klien (WHO, 2022).

C. Ansietas

1. Pengertian Ansietas

Ansietas merupakan respons emosional berupa perasaan takut, khawatir, atau tidak nyaman yang tidak spesifik terhadap suatu objek tertentu dan sering kali disertai dengan ketegangan fisik serta aktivasi sistem saraf otonom. Ansietas dipandang sebagai respons adaptif terhadap ancaman, namun dapat menjadi patologis apabila intensitas dan durasinya mengganggu fungsi individu (American Psychiatric Association [APA], 2022).

Dalam keperawatan jiwa, ansietas dipahami sebagai respons subjektif individu terhadap stresor internal maupun eksternal yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keseimbangan psikologis. Respon ini dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, dan pengalaman hidup individu (Stuart, 2021).

Ansietas merupakan salah satu masalah psikososial yang paling sering ditemukan dalam praktik keperawatan, baik pada klien dengan gangguan jiwa maupun klien dengan penyakit fisik. Tingginya prevalensi ansietas menjadikan kondisi ini sebagai fokus utama intervensi keperawatan jiwa (Varcarolis, 2021).

2. Teori Ansietas

a. Perspektif Psikoanalitik

Menurut teori psikoanalitik, ansietas muncul sebagai sinyal adanya konflik intrapsikis antara id, ego, dan superego. Ansietas berfungsi sebagai peringatan bagi ego untuk mengaktifkan mekanisme pertahanan diri guna mengurangi ketegangan psikologis yang timbul akibat konflik internal (Freud, 1926). Pendekatan ini menjelaskan bahwa pengalaman masa kanak-kanak, konflik yang tidak terselesaikan, dan mekanisme pertahanan yang maladaptif berperan penting dalam perkembangan ansietas. Pemahaman ini membantu perawat jiwa mengenali faktor psikodinamik yang memengaruhi respons klien terhadap stres (Halter, 2018).

b. Perspektif Kognitif-Perilaku

Teori kognitif-perilaku menjelaskan bahwa ansietas muncul akibat distorsi kognitif, seperti penilaian berlebihan terhadap ancaman dan perkiraan negatif terhadap kemampuan diri. Pola pikir maladaptif ini memicu respons emosional dan perilaku yang memperkuat kecemasan (Beck & Emery, 1985). Pendekatan kognitif-perilaku menjadi dasar berbagai intervensi keperawatan jiwa karena menekankan perubahan pola pikir dan perilaku sebagai cara efektif untuk mengurangi ansietas. Intervensi ini terbukti efektif dalam menurunkan gejala ansietas pada berbagai populasi (Hofmann et al., 2012).

c. Perspektif Biologis

Dari perspektif biologis, ansietas dikaitkan dengan disregulasi neurotransmiter seperti serotonin, norepinefrin, dan gamma-aminobutyric acid (GABA). Ketidakseimbangan sistem neurokimia ini memengaruhi regulasi emosi dan respons stres individu (Stahl, 2021).

Penelitian neurobiologis menunjukkan bahwa struktur otak seperti amigdala dan korteks prefrontal berperan penting dalam pengolahan rasa takut dan kecemasan. Aktivasi berlebihan amigdala sering ditemukan pada individu dengan gangguan ansietas (APA, 2022).

3. Faktor Predisposisi dan Presipitasi Ansietas

Faktor predisposisi ansietas meliputi faktor genetik, temperamen, pengalaman traumatis, serta pola asuh yang tidak adaptif. Individu dengan riwayat keluarga gangguan ansietas memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi serupa (Sadock et al., 2021). Faktor presipitasi ansietas mencakup peristiwa stres akut seperti kehilangan, konflik interpersonal, perubahan peran sosial, dan penyakit fisik. Interaksi antara faktor predisposisi dan presipitasi menentukan intensitas serta durasi ansietas yang dialami individu (Varcarolis, 2021). Perawat jiwa perlu mengidentifikasi kedua faktor ini secara komprehensif untuk merancang intervensi keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Pendekatan individual sangat penting dalam penanganan ansietas (Stuart, 2021).

4. Tingkatan Ansietas

a. Ansietas Ringan

Ansietas ringan merupakan tingkat kecemasan yang bersifat adaptif dan dapat meningkatkan kewaspadaan serta motivasi individu. Pada tingkat ini, individu masih mampu berpikir jernih, belajar, dan memecahkan masalah secara efektif (Townsend & Morgan, 2021). Gejala ansietas ringan meliputi ketegangan ringan, peningkatan kewaspadaan, dan sedikit kegelisahan. Perawat dapat memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang untuk memberikan edukasi dan penguatan koping adaptif (Varcarolis, 2021).

b. Ansietas Sedang

Ansietas sedang ditandai dengan penyempitan lapang persepsi dan penurunan kemampuan konsentrasi. Individu mungkin mengalami kesulitan dalam memproses informasi kompleks dan memerlukan arahan dari orang lain (Stuart, 2021). Manifestasi fisik ansietas sedang meliputi peningkatan denyut jantung, ketegangan otot, dan gangguan pencernaan. Intervensi keperawatan

pada tahap ini berfokus pada teknik relaksasi dan dukungan emosional (Halter, 2018).

c. **Ansietas Berat**

Ansietas berat menyebabkan penyempitan lapang persepsi yang signifikan dan gangguan kemampuan berpikir rasional. Individu cenderung fokus pada detail kecil dan mengalami kesulitan mengambil keputusan (Townsend & Morgan, 2021). Respons fisik pada ansietas berat meliputi palpitasi, sesak napas, tremor, dan pusing. Pada tahap ini, perawat perlu memberikan intervensi langsung dan menciptakan lingkungan yang aman untuk klien (Varcarolis, 2021).

d. **Panik**

Panik merupakan tingkat ansietas tertinggi yang ditandai dengan rasa takut yang intens dan kehilangan kontrol diri. Individu mungkin mengalami disorientasi, ketakutan akan kematian, atau perasaan terlepas dari realitas (APA, 2022). Kondisi panik memerlukan penanganan segera karena dapat membahayakan keselamatan klien. Perawat jiwa harus mampu memberikan intervensi krisis untuk menurunkan intensitas ansietas dan menstabilkan kondisi klien (Stuart, 2021).

5. Manifestasi Klinis Ansietas

Manifestasi klinis ansietas mencakup gejala fisiologis seperti takikardia, diaforesis, dan gangguan tidur akibat aktivasi sistem saraf simpatik. Respons ini merupakan bagian dari mekanisme fight-or-flight tubuh terhadap ancaman (McEwen, 2017). Gejala psikologis ansietas meliputi perasaan khawatir berlebihan, ketegangan emosional, iritabilitas, dan rasa tidak berdaya. Gejala ini sering kali memengaruhi fungsi sosial dan kualitas hidup individu (Sadock et al., 2021). Perubahan perilaku akibat ansietas dapat berupa penghindaran, penarikan diri sosial, dan ketergantungan pada orang lain. Perawat jiwa perlu mengidentifikasi pola perilaku ini sebagai dasar penyusunan diagnosis dan intervensi keperawatan (Varcarolis, 2021).

6. Dampak Ansietas terhadap Individu dan Keluarga

Ansietas yang tidak ditangani dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial individu. Kondisi ini dapat memperburuk penyakit kronis, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan risiko gangguan mental lain seperti depresi (WHO, 2022). Dampak ansietas juga dirasakan oleh keluarga, termasuk meningkatnya beban perawatan dan gangguan hubungan interpersonal. Dukungan keluarga yang tidak adekuat dapat memperburuk

kondisi klien, sehingga pendekatan keluarga menjadi penting dalam keperawatan jiwa (Stuart, 2021).

D. Pendekatan Terapi Keperawatan Jiwa

1. Konsep Dasar Pendekatan Terapi Keperawatan Jiwa

Pendekatan terapi keperawatan jiwa merupakan serangkaian intervensi terapeutik yang dilakukan perawat secara profesional untuk membantu klien mengatasi masalah psikologis, emosional, dan perilaku melalui hubungan terapeutik yang terencana. Pendekatan ini berfokus pada respons manusia terhadap gangguan mental, bukan semata-mata pada diagnosis medis (Varcarolis, 2021).

Terapi keperawatan jiwa didasarkan pada paradigma holistik yang memandang individu sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual. Oleh karena itu, intervensi keperawatan tidak hanya bertujuan mengurangi gejala, tetapi juga meningkatkan kemampuan adaptasi dan kualitas hidup klien (Stuart, 2021). Pendekatan terapi keperawatan jiwa bersifat kolaboratif dan komplementer terhadap terapi medis dan psikologis. Perawat bekerja sama dengan tim kesehatan mental dalam memberikan asuhan yang berkesinambungan dan berpusat pada klien (*client-centered care*) (Townsend & Morgan, 2021).

Perawat jiwa memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada keluarga mengenai ansietas dan strategi dukungan yang efektif. Intervensi berbasis keluarga terbukti meningkatkan hasil perawatan dan kualitas hidup klien (Townsend & Morgan, 2021).

2. Hubungan Terapeutik dalam Keperawatan Jiwa

Hubungan terapeutik merupakan dasar utama seluruh pendekatan terapi keperawatan jiwa. Hubungan ini adalah interaksi profesional yang direncanakan antara perawat dan klien dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial klien (Peplau, 1997). Menurut teori hubungan interpersonal Peplau, hubungan terapeutik terdiri dari empat fase, yaitu orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan resolusi. Setiap fase memiliki tujuan dan intervensi spesifik yang harus dilakukan perawat secara sadar dan terarah (Peplau, 1997; Varcarolis, 2021).

Kualitas hubungan terapeutik yang baik ditandai oleh empati, kepercayaan, penerimaan tanpa menghakimi, dan komunikasi terbuka. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan terapeutik yang efektif berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan terapi dan kepatuhan klien terhadap perawatan (Stuart, 2021).

3. Komunikasi Terapeutik sebagai Intervensi Utama

Komunikasi terapeutik merupakan alat utama perawat dalam pendekatan terapi keperawatan jiwa. Komunikasi ini bertujuan membantu klien mengekspresikan perasaan, memahami masalah, dan mengembangkan wawasan terhadap kondisi yang dialami (Townsend & Morgan, 2021). Teknik komunikasi terapeutik meliputi mendengarkan aktif, refleksi perasaan, klarifikasi, validasi emosi, dan penggunaan pertanyaan terbuka. Teknik-teknik ini membantu klien merasa dipahami dan didukung secara emosional (Varcarolis, 2021).

Komunikasi terapeutik yang tidak efektif dapat menghambat proses penyembuhan dan meningkatkan resistensi klien terhadap perawatan. Oleh karena itu, perawat perlu menghindari komunikasi non-terapeutik seperti memberi nasihat berlebihan, menghakimi, atau meminimalkan perasaan klien (Stuart, 2021).

4. Terapi Suportif dalam Keperawatan Jiwa

Terapi suportif merupakan pendekatan terapi keperawatan jiwa yang bertujuan memperkuat mekanisme koping adaptif klien melalui dukungan emosional, penguatan positif, dan peningkatan rasa percaya diri. Terapi ini sangat efektif pada klien dengan stres dan ansietas ringan hingga sedang (Halter, 2018). Intervensi terapi suportif meliputi pemberian reassurance realistis, membantu klien mengidentifikasi kekuatan diri, serta memfasilitasi dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan. Pendekatan ini membantu klien merasa aman dan dihargai (Stuart, 2021).

Terapi suportif dapat diterapkan dalam berbagai setting pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, komunitas, dan layanan kesehatan primer. Fleksibilitas terapi ini menjadikannya salah satu pendekatan utama dalam praktik keperawatan jiwa (Townsend & Morgan, 2021).

5. Terapi Psikoedukasi

Terapi psikoedukasi merupakan pendekatan terapi yang bertujuan meningkatkan pemahaman klien dan keluarga mengenai kondisi psikologis yang dialami, faktor pencetus, serta strategi penanganannya. Psikoedukasi terbukti efektif dalam menurunkan kekambuhan dan meningkatkan kepatuhan terapi (Varcarolis, 2021). Dalam konteks stres dan ansietas, psikoedukasi membantu klien mengenali tanda dan gejala awal kecemasan, memahami mekanisme stres, serta mempelajari teknik manajemen stres yang efektif. Edukasi yang tepat dapat meningkatkan kontrol diri klien terhadap gejalanya (Stuart, 2021).

Psikoedukasi juga melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung utama klien. Keterlibatan keluarga dalam proses terapi terbukti meningkatkan hasil perawatan dan kualitas hidup klien dengan gangguan mental (WHO, 2022).

6. Terapi Relaksasi dan Mindfulness

Terapi relaksasi merupakan pendekatan nonfarmakologis yang bertujuan menurunkan aktivasi sistem saraf simpatik dan meningkatkan respons relaksasi tubuh. Teknik relaksasi yang umum digunakan dalam keperawatan jiwa meliputi relaksasi otot progresif, pernapasan dalam, dan guided imagery (Halter, 2018). Mindfulness merupakan pendekatan terapi yang menekankan kesadaran penuh terhadap pengalaman saat ini tanpa penilaian. Praktik mindfulness terbukti efektif dalam menurunkan stres dan ansietas serta meningkatkan regulasi emosi (Hofmann et al., 2010).

Perawat jiwa memiliki peran penting dalam mengajarkan dan memfasilitasi latihan relaksasi dan mindfulness kepada klien. Pendekatan ini mudah diterapkan, biaya rendah, dan dapat digunakan sebagai strategi koping jangka panjang (Varcarolis, 2021).

7. Pendekatan Kognitif-Perilaku dalam Keperawatan Jiwa

Pendekatan kognitif-perilaku dalam keperawatan jiwa berfokus pada identifikasi dan modifikasi pola pikir dan perilaku maladaptif yang berkontribusi terhadap stres dan ansietas. Perawat dapat menerapkan prinsip dasar terapi kognitif-perilaku dalam praktik keperawatan sehari-hari (Beck & Emery, 1985). Intervensi keperawatan berbasis kognitif-perilaku meliputi membantu klien mengenali pikiran irasional, menantang distorsi kognitif, dan mengembangkan respons perilaku yang lebih adaptif. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan gejala ansietas (Hofmann et al., 2012).

Meskipun terapi kognitif-perilaku formal dilakukan oleh profesional kesehatan mental terlatih, perawat jiwa dapat menerapkan teknik dasarnya sebagai bagian dari asuhan keperawatan komprehensif (Stuart, 2021).

8. Terapi Aktivitas Kelompok (TAK)

Terapi aktivitas kelompok merupakan pendekatan terapi keperawatan jiwa yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk meningkatkan fungsi sosial dan psikologis klien. Terapi ini membantu klien belajar dari pengalaman bersama dan meningkatkan keterampilan interpersonal (Townsend & Morgan, 2021). TAK dapat berbentuk terapi sosialisasi, terapi relaksasi kelompok, terapi ekspresi

emosi, dan terapi pemecahan masalah. Pendekatan ini efektif dalam mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan rasa kebersamaan klien (Varcarolis, 2021).

Perawat berperan sebagai fasilitator dalam terapi kelompok dengan memastikan lingkungan yang aman, mengarahkan diskusi, dan mendorong partisipasi aktif seluruh anggota kelompok (Halter, 2018).

9. Kolaborasi Terapi Keperawatan dan Farmakoterapi

Pendekatan terapi keperawatan jiwa tidak dapat dipisahkan dari farmakoterapi pada klien dengan gangguan mental tertentu. Perawat berperan penting dalam memantau efektivitas obat, efek samping, dan kepatuhan klien terhadap pengobatan (Stahl, 2021). Kolaborasi yang efektif antara perawat, psikiater, dan tenaga kesehatan lain meningkatkan keamanan dan efektivitas perawatan. Edukasi klien mengenai penggunaan obat dan integrasinya dengan terapi nonfarmakologis sangat penting dalam keberhasilan terapi (APA, 2022).

Pendekatan terpadu antara terapi keperawatan dan farmakoterapi memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan penggunaan salah satu pendekatan secara terpisah (WHO, 2022).

10. Peran Etik dan Profesional Perawat dalam Terapi Keperawatan Jiwa

Pelaksanaan terapi keperawatan jiwa harus menjunjung tinggi prinsip etik keperawatan, termasuk otonomi, beneficence, nonmaleficence, dan keadilan. Perawat wajib menghormati hak klien dan menjaga kerahasiaan informasi (ANA, 2021). Kompetensi profesional perawat dalam terapi keperawatan jiwa mencakup pengetahuan, keterampilan komunikasi, dan sikap terapeutik. Pendidikan berkelanjutan dan supervisi klinis sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan keperawatan jiwa (Stuart, 2021).

E. Referensi

-
- American Psychiatric Association. (2022). DSM-5-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. APA Publishing.
- American Psychological Association. (2018). Stressor. APA Dictionary of Psychology. <https://dictionary.apa.org>
- Beck, A. T., & Emery, G. (1985). Anxiety Disorders and Phobias. Basic Books.
- Betts, J. G., Young, K. A., Wise, J. A., Johnson, E., Poe, B., Kruse, D. H., Korol, O., Johnson, J. E., Womble, M., & DeSaix, P. (2022). Anatomy and physiology 2e. OpenStax. <https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/1-introduction>

- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. (2025). Kesehatan jiwa di Kota Yogyakarta menjadi perhatian. Website Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Diakses dari <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/612/kesehatan-jiwa-di-kota-yogyakarta-menjadi-perhatian>
- Ernstmeyer & Christman, (2025). Nursing: Mental Health and Community Concepts – 2e. Wistech open. <https://wtcs.pressbooks.pub/nursingmhcc/>
- Franjić, S. (2022). Mental health is an integral part of the general health. MedPress Publications.
- Halter, M. J. (2018). Varcarolis' Psychiatric Mental Health Nursing. Elsevier.
- Hawari, D. (2016). Manajemen Stres, Cemas dan Depresi. Jakarta: FKUI.
- Hofmann, S. G., et al. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology.
- Keliat, B. A., et al. (2020). Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta: EGC.
- Notoatmodjo, S. (2018). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peplau, H. E. (1997). Interpersonal Relations in Nursing. Springer.
- Puchkors, Rebecca, et.al. (2024). Psychiatric Mental Health Nursing. OpenStax <https://openstax.org/details/books/psychiatric-mental-health?Book%20details>
- Stahl, S. M. (2021). Essential Psychopharmacology. Cambridge University Press.
- Stuart, G. W. (2021). Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Elsevier.
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2021). Psychiatric Mental Health Nursing. F.A. Davis.
- Varcarolis, E. (2021). Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing. Elsevier.
- World Health Organization. (2022). World Mental Health Report.
- World Health Organization. (2025). Mental health. WHO. <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>

F. Glosarium

- APA = American Psychology Assosiation
- HPA = hipotalamus-hipofisis-adrenal
- SNS = sistem saraf simpatik
- PNS = sistem saraf parasimpatik

CHAPTER 5

PARADIGMA BARU INTERVENSI KEPERAWATAN DALAM MANAJEMEN PENYAKIT KRONIS DAN DEGENERATIF

Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan

Pergeseran paradigma epidemiologi global saat ini menunjukkan transisi signifikan dari prevalensi penyakit menular ke arah dominasi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang bersifat kronis-progresif (Article, 2021; Goswami, 2024). Kondisi patologis seperti Diabetes Mellitus dan hipertensi kini tidak lagi diklasifikasikan sekadar sebagai anomali biologis individual, melainkan telah bertransformasi menjadi tantangan sistemik kompleks yang memerlukan manajemen tata kelola kesehatan yang berkelanjutan dan terintegrasi (J E Epping-Jordan, S D Pruitt, R Bengoa, 2004). Dalam merespons kompleksitas beban penyakit degeneratif ini, reposisi peran tenaga keperawatan menjadi krusial; perawat tidak lagi terbatas pada fungsi teknis-instruktif, melainkan mengemban tanggung jawab strategis sebagai koordinator perawatan (*care coordinator*) dan edukator klinis yang menjamin efikasi intervensi terapeutik jangka panjang (Hennrich, Bölter, & Wensing, 2020).

Perubahan paradigma dalam pengelolaan penyakit kronis dan degeneratif menunjukkan pergeseran signifikan dari model medis yang bersifat paternalistik menuju pendekatan kemitraan yang berfokus pada pasien melalui praktik patient-centered care. Orientasi baru ini mendorong layanan keperawatan untuk tidak lagi sekadar merespons episode akut, melainkan mengutamakan intervensi yang bersifat antisipatif, promotif, dan preventif sepanjang lintasan penyakit kronis (Hatam et al., 2025; Watson, Estenson, Eden, Gerstein, & Carney, 2024).

Dalam konteks tersebut, perawat diposisikan sebagai aktor kunci dalam mengoordinasikan penatalaksanaan kompleksitas biopsikososial pasien, termasuk integrasi aspek fisik, psikologis, dan sosial dalam rencana asuhan yang berkelanjutan. Keberhasilan manajemen penyakit kronis tidak lagi dinilai hanya berdasarkan stabilitas indikator klinis, tetapi juga pada kemampuan pasien untuk mengintegrasikan strategi self-management ke dalam aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri, konsisten, dan berdaya, sehingga meningkatkan kualitas hidup

dan mengurangi beban layanan kesehatan jangka Panjang (Beaudin, Chouinard, Hudon, & Hudon, 2024; Qama, Rubinelli, & Diviani, 2022)

Dari perspektif epistemologis, praktik keperawatan kontemporer beranjak dari reduksionisme biomedis menuju pendekatan holistik yang memandang penyakit kronis seperti Diabetes Mellitus dan Hipertensi sebagai fenomena yang terikat erat dengan determinan sosial kesehatan, mencakup status sosioekonomi, lingkungan fisik, dan konteks komunitas. Kerangka ini menegaskan bahwa beban morbiditas dan luaran klinis tidak hanya dipengaruhi oleh proses patologi internal, tetapi juga oleh akses terhadap layanan, literasi kesehatan, dan sumber daya sosial yang membentuk peluang pasien untuk mengelola kondisi kronis secara efektif (Metlock et al., 2025; Shah & Upadhyay, 2025).

Sejalan dengan pergeseran tersebut, praktik keperawatan mulai mengintegrasikan teknologi digital dan analitik canggih dalam bentuk precision nursing, sehingga intervensi dapat dipersonalisasi berdasarkan pemantauan data real-time, parameter fisiologis berkelanjutan, serta profil risiko individual pada pasien dengan penyakit kronis dan degeneratif. Pemanfaatan platform kesehatan digital, pemantauan jarak jauh, dan sistem pendukung keputusan berbasis pembelajaran mesin memungkinkan perawat menyusun rencana asuhan yang adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika klinis maupun perilaku pasien dari waktu ke waktu (Chen, Ho, Zong, Weng, & Yuan, 2025; Dong et al., 2025).

Dengan mengombinasikan empati dan sensitivitas relasional dalam interaksi terapeutik dengan ketepatan informasi yang dihasilkan oleh teknologi, perawat berfungsi sebagai navigator dalam sistem pelayanan kesehatan yang kompleks, membantu pasien menavigasi pilihan terapi, layanan, dan sumber daya yang tersedia. Dalam kapasitas ini, perawat berperan memastikan bahwa setiap keputusan dan intervensi keperawatan selaras dengan nilai pribadi, preferensi, serta kebutuhan spesifik individu yang mengalami penurunan fungsi degeneratif, sehingga kualitas hidup, otonomi, dan partisipasi aktif pasien dalam pengambilan keputusan klinis tetap terjaga (Pawelczyk, Kraus, Voigtlaender, & Siebenlist, 2025; Robles-aguilar, 2025).

Paradigma pelayanan kesehatan kontemporer menempatkan perawat sebagai pemimpin klinis dengan peran strategis dalam pengambilan keputusan, sehingga peran mereka tidak hanya bersifat pelaksana teknis tetapi juga pengarah arah kebijakan klinis di tingkat mikro dan meso organisasi. Dalam kerangka manajemen penyakit kronis, fungsi keperawatan melampaui batas-batas ruang rawat inap dan bergeser ke wilayah komunitas serta jejaring layanan primer,

dengan fokus pada koordinasi asuhan dalam sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi lintas fasilitas dan sektor. (Floriancic & Donelle, 2024).

Reorientasi ini menuntut dukungan tata kelola manajerial yang kokoh, mencakup integrasi dimensi operasional, finansial, dan legal, sehingga perawat pemimpin mampu mengelola sumber daya, menjamin kepatuhan regulasi, dan sekaligus mempertahankan mutu asuhan. Dalam konteks tersebut, intervensi keperawatan berperan sebagai motor penggerak peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan melalui optimalisasi alur layanan, pengurangan fragmentasi, dan penguatan koordinasi antarprofesi. (Ismail et al., 2025; Yata, Ohta, Ryu, Iwashita, & Sano, 2025).

Dengan adanya struktur tata kelola kesehatan yang memberikan otonomi klinis dan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan, perawat berfungsi sebagai penghubung kritis antara kebijakan manajerial di tingkat organisasi dan praktik klinis di garis depan pelayanan. Posisi ini memungkinkan perawat untuk memastikan bahwa strategi organisasi diterjemahkan ke dalam praktik asuhan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis dan kebutuhan kesehatan kompleks, termasuk stabilitas klinis jangka panjang, kemandirian fungsional, serta keberlangsungan hidup yang bermakna. (Grady, Rollins, & Bailey, 2025)

B. Landasan Teoretis: Model Perawatan Kronis (*Chronic Care Model*)

Chronic Care Model (CCM) secara fundamental mengalihkan fokus pelayanan dari tata laksana akut yang bersifat episodik dan reaktif menuju sistem yang proaktif, terintegratif, serta berorientasi pada pasien sebagai pusat pengambilan keputusan klinis. Dalam perspektif ini, manajemen penyakit kronis tidak dipahami sebagai kumpulan intervensi medis yang terpisah, melainkan sebagai suatu ekosistem pelayanan yang menuntut keselarasan berkelanjutan antara kapasitas organisasi kesehatan (struktur, proses, dan informasi) dan dukungan sumber daya komunitas (Peyroteo, 2025).

Secara konseptual, CCM dapat dianalogikan sebagai suatu sistem navigasi cerdas yang tidak hanya menetapkan tujuan klinis berupa stabilitas kondisi atau perbaikan status kesehatan, tetapi juga secara terus-menerus mengkalibrasi rute pelayanan berdasarkan informasi klinis terkini, preferensi pasien, serta ketersediaan sumber daya individual dan sosial yang dapat dimobilisasi selama perjalanan perawatan. Melalui pemantauan longitudinal dan penyesuaian dinamis terhadap “lintasan perawatan”, model ini memfasilitasi alur pelayanan yang tetap terarah, adaptif terhadap perubahan kondisi pasien, dan berkelanjutan sepanjang perjalanan penyakit kronis (Grudniewicz, Steele, Pauline, Jan, & James, 2023).

Secara teoretis, jantung CCM terletak pada terbentuknya “Interaksi Produktif” antara tim kesehatan yang bersifat proaktif dan pasien yang terinformasi serta berperan aktif (informed, activated patient). Model ini menempatkan Self-Management Support sebagai elemen kunci, dengan perawat berfungsi sebagai fasilitator yang mengembangkan kapasitas pasien dalam problem-solving dan pengambilan keputusan klinis, bukan hanya pemberi instruksi satu arah. Analogi yang sering digunakan adalah proses “Katalisis Kimia”, di mana perawat bertindak sebagai katalis yang menurunkan “energi aktivasi” yang diperlukan pasien untuk mengubah perilaku kesehatannya, sehingga transisi menuju gaya hidup sehat berlangsung lebih cepat dan efisien tanpa mengganggu keutuhan jati diri pasien (Izumi et al., 2025).

Chronic Care Model (CCM) secara operasional dijalankan melalui keterpaduan beberapa elemen inti di dalam sistem, terutama desain sistem penyampaian layanan, dukungan keputusan klinis, sistem informasi kesehatan, serta struktur organisasi layanan yang menaunginya. Keempat komponen tersebut membentuk kerangka kerja yang mengatur bagaimana tim interprofesional berkolaborasi, bagaimana informasi klinis dikelola, dan bagaimana keputusan berbasis bukti diimplementasikan secara konsisten dalam praktik (Izumi et al., 2025).

Dalam konfigurasi ini, distribusi peran ditata secara eksplisit: pengelola administrasi bertanggung jawab terhadap kualitas, kelengkapan, dan kontinuitas aliran data pasien dalam sistem informasi klinis, sedangkan pimpinan klinis atau medis berperan memastikan bahwa intervensi yang dijalankan selaras dengan pedoman praktik berbasis bukti dan standar mutu yang berlaku. Penegasan batas peran tersebut memungkinkan pemanfaatan data klinis yang andal untuk menopang pengambilan keputusan, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan klinis yang bersumber dari informasi yang tidak akurat atau tidak mutakhir (Pasricha et al., 2012).

Secara metaforis, konfigurasi CCM dapat dipandang menyerupai sebuah orkestra simfoni, di mana setiap instrumen merepresentasikan unit, disiplin, atau fungsi yang memiliki “partitur” tugasnya masing-masing, tetapi hanya akan menghasilkan luaran klinis yang harmonis apabila seluruh komponen bekerja selaras di bawah kepemimpinan manajerial yang jelas. Apabila koordinasi antarkomponen lemah, integrasi data dan dukungan keputusan terganggu, maka yang muncul bukan perbaikan luaran kesehatan, melainkan “kakofoni” berupa inefisiensi, insiden keselamatan pasien, hingga kegagalan terapi dalam program manajemen penyakit kronis (Alketbi & Nagelkerke, 2025).

C. Peran Strategis Perawat dalam Penyakit Spesifik

Konsep Dasar: Secara konseptual, posisi perawat dalam manajemen Diabetes Mellitus berlandaskan kerangka Therapeutic Patient Education (TPE), yang memandang edukasi bukan sekadar transfer informasi, tetapi sebagai proses pedagogis terstruktur yang berorientasi pada pemberdayaan pasien. Dalam perspektif ini, perawat berfungsi sebagai agen perubahan perilaku yang mendampingi pasien menginternalisasi keterampilan manajemen glikemik seperti pemantauan gula darah, pengaturan pola makan, dan aktivitas fisik ke dalam pola hidup sehari-hari, sehingga mendukung pengendalian diri jangka Panjang (Ayuso-diaz, Colli-garcia, & Hernandez-pat, 2025).

Dalam hierarki intervensi klinis, pendidikan terapeutik dipandang sebagai fondasi yang menopang efektivitas seluruh terapi farmakologis maupun nonfarmakologis, karena keberhasilan regimen pengobatan sangat ditentukan oleh kapasitas pasien menjalankan self-management secara konsisten. Peran perawat dalam konteks ini dapat dianalogikan dengan pelatih navigasi penerbangan, yang membekali pasien dengan kompetensi membaca “instrumen” seperti glucometer mandiri dan melakukan “penyesuaian kemudi” melalui modifikasi diet serta aktivitas fisik, sehingga trajektori glikemik tetap berada dalam rentang aman dan risiko komplikasi akut maupun kronis dapat diminimalkan (Ayuso-diaz et al., 2025).

Mekanisme Teoretis: Secara teoritis, rancangan edukasi keperawatan dalam manajemen glikemik banyak dipengaruhi oleh Social Cognitive Theory Bandura, dengan penekanan utama pada penguatan efikasi diri pasien sebagai penggerak perilaku perawatan mandiri yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, perawat menyusun intervensi yang bertujuan meningkatkan keyakinan pasien terhadap kompetensinya mengelola berbagai aspek self-care, mulai dari teknik penyuntikan insulin yang benar, pemantauan asupan karbohidrat, hingga pengambilan keputusan harian terkait regimen terapi (Smith et al., n.d.).

Dari sudut pandang mekanistik, fungsi edukatif perawat dapat dipahami sebagai suatu “sistem kendali umpan balik” yang secara kontinu memantau respons pasien, memberikan koreksi, dan memperkuat keberhasilan kecil untuk mempertahankan motivasi dalam menjalankan perilaku sehat. Secara analogis, peran ini menyerupai kerja enzim dalam biokimia, di mana proses pendidikan kesehatan menurunkan “ambang energi” psikologis dan sosial yang diperlukan pasien untuk memulai dan mempertahankan perubahan gaya hidup yang menantang, sehingga kepatuhan terhadap terapi dan perilaku perawatan diri menjadi lebih spontan, otomatis, dan konsisten dari waktu ke waktu (Eshtaya, Ayed, Malak, & Shehadeh, 2025).

Strategi Preventif: Dalam ranah pencegahan komplikasi, fungsi perawat bergeser dari sekadar pelaksana instruksi menjadi pengawas klinis yang aktif melakukan deteksi dini dan mitigasi risiko terhadap komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular pada penyandang diabetes. Pendekatan ini diwujudkan melalui penerapan skrining berkala, antara lain pemeriksaan kaki diabetik, evaluasi retinopati, serta pemantauan fungsi ginjal untuk mengidentifikasi neuropati perifer, retinopati, dan nefropati pada tahap awal sebelum berkembang menjadi kerusakan organ yang menetap (Crasto, 2021).

Secara konseptual, peran tersebut dapat disamakan dengan petugas pemelihara infrastruktur kritis yang secara rutin memantau keretakan kecil pada bendungan sebelum berujung pada kegagalan struktural yang katastrofik. Ketika tanda-tanda awal seperti gejala neuropati perifer atau mikroalbuminuria terdeteksi, perawat segera menginisiasi intervensi korektif melalui penguatan manajemen multifaktorial, termasuk pengendalian ketat tekanan darah dan lipid, guna mencegah progresi menuju ulkus kaki, penyakit ginjal stadium akhir, maupun kejadian kardiovaskular mayor (Marshall & Flyvbjerg, 2006).

Implementasi Organisasional: Dalam tataran operasional organisasi, fungsi edukatif perawat hanya dapat berjalan optimal apabila ditopang oleh tata kelola manajerial yang terkoordinasi dengan baik di seluruh unit dalam struktur FGI, sehingga pendidikan kesehatan menjadi bagian integral dari strategi institusi, bukan aktivitas individual semata. Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana edukasi yang memadai melalui alokasi anggaran oleh bagian keuangan, pengesahan dan penjaminan legalitas protokol asuhan oleh unit hukum, serta penguatan jangkauan program promosi kesehatan melalui perancangan kampanye yang sistematis oleh divisi pemasaran (Naranjee, Ngxongo, Sibiya, & Africa, n.d.; Sohl-donguines & Coronado, 2025).

Dalam ekosistem seperti ini, perawat mengambil peran sebagai pusat integrasi operasional yang menjembatani arah kebijakan eksekutif misalnya keputusan strategis CEO dan COO dengan praktik klinis di garis depan pelayanan, sehingga orientasi keselamatan pasien dan pencegahan komplikasi terwujud dalam tindakan nyata di titik kontak layanan. Peran integratif tersebut memungkinkan terbentuknya siklus perawatan yang komprehensif, efisien, dan berfokus pada keselamatan, di mana keputusan manajerial diterjemahkan menjadi proses asuhan yang konsisten, terstandar, dan berorientasi pada mutu luaran klinis (Lunn, Donnell, Maccurtain, & Coffey, 2025).

D. Hipertensi: Manajemen Gaya Hidup dan Farmakoterapi

Secara konseptual, mandat utama perawat dalam tata laksana hipertensi berorientasi pada pemeliharaan homeostasis dan kestabilan hemodinamik melalui kombinasi intervensi perilaku (nonfarmakologis) dan tindakan klinis terstruktur. Hipertensi yang kerap dikarakterisasi sebagai “silent killer” karena berjalan tanpa gejala bermakna menempatkan perawat sebagai sistem pemantau eksternal yang membantu individu mengenali kenaikan tekanan darah yang tidak disadari, sekaligus memfasilitasi respons klinis dan perubahan gaya hidup yang tepat waktu (Sarfika, 2025)

Dalam kerangka asuhan keperawatan, peran tersebut dapat dianalogikan dengan insinyur hidrolik yang bertugas mengawasi dan mengendalikan tekanan pada jaringan “pipa” vaskular yang kompleks, sehingga mencegah terjadinya kebocoran atau kerusakan struktural. Perawat berfungsi sebagai “baroreseptor artifisial” ketika mekanisme regulasi fisiologis tubuh tidak lagi memadai, dengan cara memandu modifikasi gaya hidup (seperti pengaturan diet, aktivitas fisik, dan manajemen stres) serta memastikan kepatuhan terhadap farmakoterapi antihipertensi guna menghindari kerusakan organ target, termasuk jantung, otak, dan ginjal (Bulto et al., 2024).

Secara teoretis, intervensi nonfarmakologis pada hipertensi berfokus pada penataan pola makan dan beban kerja sistem kardiovaskular dengan menjadikan Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) sebagai salah satu pilar utama modifikasi gaya hidup. Dalam kerangka ini, perawat berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku yang mengelola “beban sistem sirkulasi” melalui konseling diet, edukasi pemilihan pangan, dan pemantauan kepatuhan, sehingga intervensi nutrisi tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan tujuan klinis penurunan tekanan darah (Couch, 2022)

Secara analogis, fungsi tersebut menyerupai manajer lalu lintas yang mengatur “volume kendaraan” pada “jalur” pembuluh darah dengan menganjurkan pembatasan asupan natrium untuk mengurangi retensi cairan, sambil meningkatkan “kualitas aspal” melalui promosi konsumsi kalium, serat, dan antioksidan dari sayuran serta buah-buahan yang kaya mikronutrien. Kombinasi pengurangan natrium dan peningkatan kalium ini terbukti menurunkan resistensi vaskular sistemik dan mengurangi beban kerja jantung, dengan penurunan tekanan darah sistolik yang secara klinis mendekati besaran efek beberapa golongan obat antihipertensi pada derajat hipertensi ringan hingga sedang (Approaches & Hypertension, 2015; Huang et al., 2024).

E. Konsep Dasar: Konseling Nutrisi sebagai Intervensi Terapeutik Non-Farmakologis

Secara konseptual, konseling nutrisi yang dilakukan perawat tidak hanya berwujud penyampaian informasi tentang diet, tetapi merupakan intervensi terapeutik yang terstruktur dengan tujuan mengubah kembali masukan biokimia ke dalam tubuh pasien. Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diposisikan sebagai bentuk “farmakoterapi berbasis pangan” yang bekerja melalui sinergi berbagai mikronutrien. Dalam analogi ilmiah, perawat berperan layaknya seorang Insinyur Bioproses yang mengatur komposisi “bahan baku” nutrisi yang masuk ke dalam “reaktor biologis” tubuh, sehingga hasil samping metabolisme tidak memicu peningkatan tekanan osmotik maupun vaskular. Dengan demikian, konseling nutrisi menjadi landasan utama dalam penurunan resistensi perifer melalui pengelolaan keseimbangan elektrolit secara cermat dan presisi .

1. Landasan Teoretis: Mekanisme Natriuresis dan Sinergi Elektrolit

Secara teoretis, efektivitas pola makan DASH dalam praktik konseling keperawatan dipahami melalui setidaknya dua jalur utama, yaitu peningkatan ekskresi natrium (natriuresis) dan terjadinya vasodilatasi sebagai konsekuensi dari tingginya asupan kalium, kalsium, serta magnesium yang terkandung dalam pola diet tersebut. Atas dasar mekanisme ini, perawat menekankan pentingnya keseimbangan rasio natrium kalium dalam pola konsumsi harian ketika memberikan edukasi kepada pasien dengan hipertensi, bukan hanya menyoroti aspek pembatasan garam, tetapi juga penguatan asupan mineral pelindung kardiovaskular (Isnaini, Sari, Dewi, & Madyaningrum, 2025; Rasaei, Adivi, Jafrasteh, Norouzirad, & Bahadoran, 2025)

Mekanisme nutrisi tersebut dapat dijelaskan melalui analogi “sistem osmotik dua arah”, di mana kelebihan natrium bekerja menarik air ke dalam ruang intravaskular sehingga meningkatkan volume dan tekanan, sementara komponen diet DASH yang kaya kalium, kalsium, dan magnesium—berfungsi layaknya “katup pelepas” yang memfasilitasi relaksasi otot polos pembuluh darah dan menurunkan tonus vaskular. Melalui penjelasan ini, perawat menegaskan bahwa diet DASH bukan sekadar strategi pembatasan asupan tertentu, melainkan suatu bentuk pengayaan nutrisi yang secara aktif mengintervensi jalur-jalur patofisiologis hipertensi dan mendukung pengendalian tekanan darah jangka Panjang (Lv, Aihemaiti, & Guo, 2024)

2. Mekanisme Implementatif: Strategi Perubahan Perilaku dan Substitusi Nutrisi

Dalam praktik klinis, konseling keperawatan mengenai diet DASH sering dikombinasikan dengan teknik Motivational Interviewing untuk mentransformasikan pengetahuan teoretis pasien menjadi pola makan sehari-hari yang konsisten dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis dialog ini berorientasi pada eksplorasi motivasi intrinsik dan nilai personal pasien, sehingga modifikasi gaya hidup dipersepsikan sebagai keputusan otonom yang sejalan dengan tujuan kesehatan jangka panjang, bukan sekadar kepatuhan terhadap instruksi tenaga Kesehatan (Rasaei et al., 2025)

Secara operasional, perawat mengimplementasikan prinsip “substitusi bertahap”, yaitu secara sistematis membantu pasien merancang ulang komposisi menu dengan mengganti komponen tinggi lemak jenuh dan gula sederhana dengan pilihan pangan yang lebih kaya serat, mikronutrien, dan lemak sehat tanpa menimbulkan beban psikologis yang berlebihan. Proses ini menyerupai prosedur titrasi dalam kimia, di mana penyesuaian dilakukan melalui perubahan kecil namun terukur hingga tercapai titik keseimbangan baru yang ditandai dengan penurunan tekanan darah yang stabil disertai tingkat kepatuhan jangka panjang yang tetap tinggi (Claudia et al., 2019)

3. Integrasi Manajerial dalam Ekosistem FGI

Pada tingkat organisasi, program konseling diet DASH yang dilakukan perawat perlu diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola FGI sehingga pelaksanaannya konsisten, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Kompetensi klinis perawat dalam memberikan konseling nutrisi diperkuat melalui dukungan unit pemasaran yang mengemas materi edukasi secara komunikatif, administrator yang memantau kepatuhan diet melalui rekam medis elektronik terintegrasi, bagian keuangan yang menjamin ketersediaan alat penilaian status gizi, serta unit hukum yang memastikan rekomendasi nutrisi tetap berada dalam batas kewenangan profesi keperawatan. Kombinasi elemen ini membentuk suatu “sistem pendukung keputusan nutrisi” yang kokoh, menempatkan perawat di garis depan efisiensi pembiayaan penyakit kronis melalui pencegahan komplikasi berbiaya tinggi (Alzahrani et al., 2024; Li et al., 2025)

Dalam aspek farmakoterapi, perawat memegang peran kunci sebagai penyedia informasi terkait manfaat dan risiko obat sekaligus pemantau munculnya efek samping, khususnya pada terapi jangka panjang untuk hipertensi dan diabetes. Berlandaskan kerangka Health Belief Model, perawat membantu pasien menimbang bahwa keuntungan pengendalian tekanan darah

dan glikemia jangka panjang lebih besar dibandingkan ketidaknyamanan efek samping sesaat, sembari bertindak sebagai “bio-monitor” yang memantau kepatuhan, respon klinis, dan potensi reaksi merugikan agar terapi tetap berada dalam rentang terapeutik yang aman. Secara analogis, perawat berperan layaknya governor pada mesin uap yang mengatur “aliran bahan kimia” berupa obat antihipertensi dan antidiabetik dalam dosis serta interval yang tepat, sekaligus mendeteksi dini adanya “kebocoran” berupa efek samping atau interaksi obat yang dapat menurunkan kualitas hidup (Berardinelli et al., 2024)

Pada level kelembagaan, keberhasilan manajemen hipertensi bergantung pada sistem terintegrasi di dalam struktur FGI yang menyinergikan fungsi klinis dan administratif. Peran klinis perawat disejajarkan dengan tugas administrator yang mengelola pemantauan tekanan darah jarak jauh (remote patient monitoring), sementara bagian keuangan menjamin ketersediaan perangkat skrining dan monitoring yang akurat, dan pimpinan puncak (CEO, COO) memberi mandat formal terhadap pelaksanaan konseling intensif yang dilindungi oleh protokol hukum dari unit legal. Kolaborasi multiprofesi ini mewujudkan suatu “sistem keamanan vaskular terpadu” yang mengarahkan seluruh komponen organisasi untuk bekerja menuju pencapaian target tekanan darah, misalnya di bawah 140/90 mmHg, pada populasi berisiko (Li et al., 2025)

Secara konseptual, intervensi manajemen stres yang dilakukan perawat bertumpu pada prinsip psikoneuroimunologi, yang menelaah kaitan antara proses psikologis, sistem saraf, dan respon imun. Stres kronis dipahami bukan hanya sebagai gejala emosional, tetapi sebagai pemicu biologis yang meningkatkan kadar kortisol serta aktivasi sistem saraf simpatis, sehingga berkontribusi terhadap perburukan hipertensi dan kontrol glikemik yang buruk pada diabetes. Dalam kerangka ini, perawat bertindak sebagai “teknisi kalibrasi frekuensi” yang berupaya menggeser respons tubuh dari mode kewaspadaan tinggi (fight-or-flight) menuju keadaan relaksasi yang lebih seimbang, dengan tujuan menurunkan beban psikososial dan mengurangi kerusakan vaskular maupun metabolik yang dimediasi hormon stress (Buric, 2025; El-malahi, Mohajeri, Bäuerle, & Mincu, n.d.)

Dari perspektif teori stres, praktik tersebut selaras dengan konsep General Adaptation Syndrome (GAS) dan teori penilaian kognitif (cognitive appraisal), yang menekankan pentingnya mencegah transisi berkepanjangan dari fase alarm ke fase exhaustion yang berpotensi merusak organ. Mekanisme kunci yang dimanfaatkan antara lain aktivasi saraf vagus dan sistem saraf parasimpatis melalui teknik relaksasi dan pernapasan, sehingga perawat berfungsi layaknya “katup pelepas tekanan” pada ketel uap yang mencegah lonjakan tekanan

hemodinamik akibat akumulasi ketegangan. Melalui latihan relaksasi otot progresif dan pernapasan diafragma dalam, perawat membantu “melepaskan uap” berupa ketegangan psikis yang bila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kardiometabolik (El-malahi et al., n.d.; Reis, Travado, & Antoni, 2025)

Pada level implementasi, perawat mengintegrasikan intervensi psikososial berupa teknik kognitif-perilaku sederhana, imajinasi terbimbing, serta fasilitasi dukungan sosial untuk mengubah pola koping maladaptif menjadi strategi koping yang lebih adaptif. Dalam kerangka ini, perawat berperan sebagai “arsitek peredam kejut” yang membangun struktur psikologis dan emosional yang lebih lentur, sehingga fluktuasi kondisi penyakit, tekanan finansial, atau perubahan regimen terapi tidak langsung mengganggu kestabilan fisiologis, tetapi teredam oleh kapasitas ketahanan mental yang telah dilatih (Hasanah, Lei, Haikal, Sari, & Soares, 2025; McCain et al., 2008)

Pada ranah organisasi FGI, kemampuan perawat dalam mengelola stres pasien perlu difasilitasi melalui kebijakan manajerial yang menjadikannya bagian dari layanan unggulan. Sinergi dengan unit pemasaran diperlukan untuk mempromosikan program wellness dan manajemen stres, dengan bagian keuangan untuk menyediakan sarana seperti ruang tenang, materi relaksasi, atau platform eHealth, serta dengan unit legal untuk memastikan seluruh intervensi psikososial tetap berada dalam batas kewenangan praktik keperawatan dan etika profesi. Di bawah arahan CEO dan COO, perawat bertindak sebagai “unit penjamin kualitas psikofisiologis” yang memastikan pasien dengan penyakit kronis tidak hanya terkontrol dari sisi parameter klinis, tetapi juga memiliki kapasitas ketahanan mental yang memadai untuk menopang keberhasilan terapi jangka Panjang (El-malahi et al., n.d.)

4. Penyakit Degeneratif: Peningkatan Kualitas Hidup (Quality of Life)

Pada penyakit degeneratif seperti osteoarthritis dan Alzheimer, orientasi pelayanan keperawatan bergeser dari tujuan kuratif menuju pendekatan rehabilitatif dan paliatif yang berfokus pada pelestarian kapasitas fungsional selama mungkin. Pergeseran ini menuntut perubahan paradigma dari upaya “menyembuhkan” menuju “merawat”, dengan penekanan pada optimasi fungsi residual dan reduksi penderitaan di tengah proses penurunan biologis yang tidak dapat dibalikkan. Dalam kerangka tersebut, perawat bertindak sebagai penjaga kapasitas (capacity conservator) yang berupaya mempertahankan kualitas hidup meskipun terjadi penurunan fisik maupun kognitif, mirip restorator karya seni yang tidak mengubah material asli tetapi memperkuat

struktur dan mengurangi distorsi gejala agar nilai, martabat, dan makna hidup tetap terjaga (Fang et al., 2025; Gupta & Patel, 2024)

Secara konseptual, intervensi keperawatan pada populasi ini banyak dirujuk pada Comfort Theory Kolcaba, yang menempatkan kenyamanan pasien—dalam dimensi fisik, psikospiritual, sosial, dan lingkungan—sebagai tujuan utama asuhan. Pada pasien dengan Alzheimer, fokus praktis bergeser dari upaya perbaikan fungsi kognitif menuju penyesuaian lingkungan, struktur rutinitas, dan peningkatan kenyamanan emosional untuk menurunkan agitasi dan distress perilaku. Dalam posisi ini, perawat berperan sebagai bio-stabilisator, menyerupai sistem suspensi kendaraan yang tidak memperbaiki “kondisi jalan” berupa proses neurodegeneratif, tetapi meredam “guncangan” berupa nyeri kronik pada osteoarthritis maupun disorientasi pada demensia sehingga lintasan penyakit dapat dilalui dengan rasa aman dan nyaman yang lebih besar (Fang et al., 2025; Na, Bradt, Gliebus, Fritz, & Gitlin, 2025).

Pada tataran pelaksanaan klinis, strategi yang diutamakan adalah integrasi intervensi rehabilitatif—untuk mempertahankan fungsi motorik dan kognitif yang tersisa—dengan komponen paliatif yang memfokuskan pada pengendalian nyeri, kecemasan, dan beban psikologis. Perawat mengimplementasikan berbagai bentuk adaptasi fungsional, seperti latihan penguatan dan rentang gerak sendi pada osteoarthritis, serta stimulasi kognitif terstruktur pada Alzheimer, guna mempertahankan kemampuan melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Dalam peran sebagai “arsitek resiliensi”, perawat merekayasa ulang hubungan pasien dengan lingkungan fisik dan sosialnya, seolah memasang kerangka penopang eksternal baik berupa alat bantu, struktur rutinitas, maupun dukungan keluarga agar aktivitas harian tetap dapat dijalankan dengan bantuan minimal sambil memaksimalkan rasa otonomi dan kontrol diri pasien (Jati, Tinggi, & Kesehatan, 2024; Na et al., 2025)

Dalam konteks organisasi FGI, tata kelola klinis untuk penyakit degeneratif menuntut koordinasi lintas fungsi manajerial agar asuhan holistik dapat berjalan secara konsisten. Head of Finance diperlukan untuk menjamin pengadaan alat bantu rehabilitasi, teknologi pemantauan, dan sarana paliatif yang memadai; Head of Legal memastikan protokol end-of-life care dan pengambilan keputusan etik misalnya terkait advance care planning selaras dengan regulasi dan prinsip etika kesehatan yang berlaku. Administrator berperan menguatkan kesinambungan layanan melalui sistem rujukan dan transisi perawatan (hospital home long-term care) yang efektif, sementara Head of Marketing mengkomunikasikan nilai empati, humanitas, dan mutu layanan FGI kepada keluarga dan masyarakat. Di bawah kebijakan strategis CEO dan COO, perawat

diposisikan sebagai pengintegrasi kesejahteraan holistik, sehingga FGI berfungsi bukan hanya sebagai penyedia layanan medik teknis, tetapi sebagai mitra yang menjaga martabat dan kualitas hidup pasien pada setiap fase perjalanan penyakit degenerative (Lin, Zhou, Chen, Yan, & Gu, 2024; *World Alzheimer Report 2025*, 2025)

F. Integrasi Manajemen dalam Struktur Organisasi Layanan (FGI)

1. Konsep Dasar: Pergeseran Paradigma dari Kuratif ke Restorasi Kualitas Hidup

Pada konteks penyakit degeneratif seperti osteoarthritis dan Alzheimer, fokus penatalaksanaan keperawatan bergeser dari orientasi kuratif menuju pendekatan jangka panjang yang menekankan pemeliharaan fungsi dan pengurangan beban gejala, sejalan dengan karakter proses biologis yang progresif dan tidak reversibel. Pergeseran paradigma ini menempatkan tujuan asuhan pada optimalisasi kapasitas fungsional yang masih tersisa serta perlindungan kualitas hidup, alih-alih mengejar pemulihan struktural yang tidak lagi realistis pada stadium lanjut (Gupta & Patel, 2024; Kangeswari & Hm, 2022)

Dalam kerangka tersebut, perawat dipahami sebagai penjaga kapasitas (capacity conserver), yaitu profesi yang bertanggung jawab mempertahankan keberlangsungan kualitas hidup pasien meskipun terjadi penurunan bertahap pada fungsi fisik maupun kognitif. Peran ini menyerupai kerja restorator benda seni antik: tujuan utamanya bukan mengubah usia atau “memudakan” materi yang telah menua, melainkan memperkuat struktur, mengurangi distorsi yang tampak sebagai nyeri, disabilitas, atau gangguan perilaku, sehingga nilai, martabat, dan fungsi sosial pasien tetap dapat dipertahankan selama mungkin (Gloriene, Pujante, & Sami, 2025; Hossain, Hasan, Rahman, Almarzooqi, & Rahman, 2025)

2. Landasan Teoretis: Teori Kenyamanan dan Manajemen Gejala

Secara konseptual, praktik keperawatan pada penyakit degeneratif banyak dirumuskan dalam kerangka Comfort Theory yang dikembangkan oleh Katharine Kolcaba, yang memandang kenyamanan sebagai tujuan utama asuhan dan mencakup empat ranah utama: fisik, psikospiritual, lingkungan, dan sosial. Pada individu dengan Alzheimer, orientasi intervensi keperawatan cenderung bergeser dari upaya memperbaiki fungsi kognitif—yang secara biologis terus menurun—menuju modifikasi lingkungan, penataan rutinitas, dan penguatan kenyamanan emosional sebagai strategi untuk menurunkan agitasi dan distress perilaku (Asadizaker, 2024; Lin et al., 2024)

Dalam kerangka tersebut, perawat dapat dipahami sebagai bio-stabilisator yang menjaga agar pengalaman subjektif pasien tetap berada pada tingkat kenyamanan yang dapat ditoleransi, meskipun proses neurodegeneratif dan nyeri muskuloskeletal terus berlangsung. Peran ini serupa dengan sistem suspensi pada kendaraan yang melintasi jalan rusak: fokusnya bukan memperbaiki "jalan" yang merepresentasikan perubahan degeneratif yang tidak reversibel, melainkan meredam "guncangan" berupa nyeri kronis pada osteoarthritis atau disorientasi pada Alzheimer, sehingga pasien sebagai "penumpang" tetap merasakan stabilitas dan kenyamanan relatif sepanjang perjalanan penyakit (Jati et al., 2024; Lin, Zhou, & Chen, 2023)

3. Mekanisme Implementatif: Integrasi Paliatif dan Rehabilitatif Terpadu

Pada tataran praktik klinis, pengelolaan penyakit degeneratif umumnya diwujudkan melalui kombinasi intervensi rehabilitatif untuk mempertahankan kemampuan motorik dan kognitif yang tersisa, serta pendekatan paliatif yang berfokus pada pengendalian nyeri, ketidaknyamanan, dan beban psikologis pasien maupun keluarga. Dalam kerangka ini, perawat mengimplementasikan strategi adaptasi fungsional, misalnya dengan memberikan latihan penguatan dan rentang gerak sendi pada individu dengan osteoarthritis serta menerapkan terapi stimulasi kognitif terstruktur bagi pasien dengan demensia atau Alzheimer, sehingga kapasitas fungsional dan kemandirian dasar tetap dapat dipertahankan selama mungkin (Jati et al., 2024; Na et al., 2025)

Peran tersebut menempatkan perawat sebagai "arsitek resiliensi" yang secara aktif menata ulang hubungan pasien dengan lingkungan fisik dan sosialnya agar lebih menyangga keterbatasan yang ada daripada menuntut kemampuan yang sudah menurun. Secara analogis, intervensi keperawatan ini dapat disamakan dengan pemasangan exoskeleton fisik dan mental: perawat membangun sistem penopang eksternal melalui alat bantu, modifikasi rumah, pelatihan ADL, serta pelibatan caregiver yang mengompensasi kemunduran kapasitas seluler, sehingga aktivitas sehari-hari tetap dapat dilakukan dengan bantuan minimal namun dengan tingkat otonomi dan kontrol diri yang setinggi mungkin (Fang et al., 2025; Jin-ho Kim & Lee, 2025)

4. Integrasi Strategis dalam Struktur Organisasi FGI

Pada tingkat operasional, pengelolaan penyakit degeneratif di FGI perlu diorganisasikan dalam suatu sistem kolaboratif yang menyatukan seluruh lini manajerial agar alur asuhan berjalan konsisten dan berkesinambungan. Unit keuangan memegang peran strategis dalam menjamin pengadaan alat bantu

rehabilitasi dan sarana pendukung lainnya, sedangkan unit hukum bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh prosedur perawatan fase akhir hayat selaras dengan ketentuan etik dan regulasi kesehatan yang berlaku (Kongkar et al., 2025; Randall, Afenigus, & Sinshaw, 2025)

Di sisi lain, administrator berfokus pada penguatan kesinambungan layanan melalui pengelolaan rujukan dan transisi perawatan yang efektif, sementara divisi pemasaran mengomunikasikan citra FGI sebagai institusi yang mengedepankan empati dan mutu layanan kepada keluarga serta pemangku kepentingan. Dalam kerangka visi dan arahan strategis CEO dan COO, perawat diposisikan sebagai integrator kesejahteraan holistik yang menjembatani kebijakan manajerial dengan praktik klinis, sehingga FGI tidak hanya berfungsi sebagai penyedia intervensi medis, tetapi juga sebagai mitra yang menjaga martabat dan kualitas hidup pasien sepanjang perjalanan penyakit degenerative (Randall et al., 2025)

G. Teknologi dan Inovasi dalam Asuhan Keperawatan

1. Konsep Dasar: Digitalisasi Klinis dan Keperawatan Berbasis Data

Pemanfaatan teknologi dalam praktik keperawatan merefleksikan pergeseran paradigma dari pola kerja manual yang sangat bergantung pada intuisi menuju model asuhan presisi yang ditopang infrastruktur digital, sistem informasi, dan analitik data. Dalam kerangka ini, teknologi diposisikan bukan sebagai pengganti profesi keperawatan, tetapi sebagai perluasan kapasitas kognitif dan motorik perawat untuk memperkuat akurasi penilaian klinis, kecepatan respons, serta konsistensi pengambilan keputusan (Al-qudah, Oweidat, & Omar, 2025; Chen et al., 2025)

Secara metaforis, perawat dapat dianalogikan dengan pilot yang mengoperasikan pesawat dilengkapi sistem avionik modern: panel digital, radar, dan autopilot diibaratkan sebagai perangkat pemantauan jarak jauh, sensor biometrik, serta clinical decision support system yang menyajikan data real-time dan rekomendasi berbasis algoritma, sementara kendali strategis, penilaian etik, dan dimensi empatik tetap sepenuhnya berada pada perawat. Integrasi teknologi ini memungkinkan pergeseran dari pemantauan pasien yang episodik di fasilitas layanan menjadi monitoring kontinu dan proaktif—misalnya melalui telenursing dan remote patient monitoring—dengan tingkat ketepatan deteksi perubahan kondisi klinis yang secara signifikan lebih tinggi. (Azadi, Jos, & Canalejas, 2025; Emaliyawati & Ibrahim, 2025)

2. Landasan Teoretis: Teori Adaptasi Teknologi dan Model Penerimaan

Secara konseptual, pengadopsian inovasi teknologi dalam praktik keperawatan di institusi seperti FGI dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (TAM) dan kerangka Sociotechnical Systems Theory, yang sama-sama menekankan bahwa penerimaan dan pemanfaatan teknologi dipengaruhi oleh persepsi pengguna terkait kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kebermanfaatannya dalam memecahkan masalah klinis. Kedua perspektif tersebut menggarisbawahi bahwa kualitas desain sistem dan dukungan organisasi harus mampu menurunkan hambatan pengguna, sehingga teknologi dianggap relevan, tidak membebani, dan kompatibel dengan praktik keperawatan sehari-hari (Jae-hak Kim, Kim, & Youn, n.d.; Shan, Shang, Yan, & Ye, 2023)

Secara teoretis, keberhasilan integrasi sistem digital ke dalam alur kerja keperawatan menuntut adanya kesesuaian antara “subsistem sosial”—yang mencakup budaya kerja, pola komunikasi, dan kebiasaan dokumentasi perawat—dengan “subsistem teknis” berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur informasi kesehatan. Dalam analogi fisika, perawat dapat dipandang sebagai “semikonduktor informasi” yang menuntut agar rancangan teknologi memiliki resistansi serendah mungkin terhadap aliran kerja klinis; artinya, sistem harus memfasilitasi transformasi data kesehatan menjadi keputusan dan tindakan keperawatan secara efisien tanpa meningkatkan beban kerja kognitif secara berlebihan (Ariza, Kalra, & Potts, 2015; Na et al., 2025)

3. Mekanisme Implementatif: Telehealth dan Remote Patient Monitoring (RPM)

Secara teoritik, integrasi teknologi dalam praktik keperawatan di institusi seperti FGI dapat dijelaskan melalui kerangka Technology Acceptance Model (TAM) dan Sociotechnical Systems Theory, yang sama-sama menyoroti bahwa penerapan teknologi hanya akan efektif jika pengguna memandangnya mudah digunakan dan bermanfaat langsung bagi penyelesaian masalah klinis. Kedua model ini menegaskan bahwa persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan kegunaan (*perceived usefulness*), yang dipengaruhi oleh desain sistem, pelatihan, serta dukungan organisasi, merupakan determinan utama kesiapan tenaga keperawatan untuk mengintegrasikan aplikasi digital ke dalam praktik sehari-hari (Jae-hak Kim et al., n.d.)

Secara mekanistik, keberhasilan implementasi teknologi bergantung pada derajat kesesuaian antara “subsistem sosial” mencakup budaya kerja, pola kolaborasi, dan kebiasaan dokumentasi perawat dengan “subsistem teknis”

berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur informasi kesehatan yang digunakan. Dalam analogi sistem elektronik, perawat berperan sebagai "semikonduktor informasi" yang menuntut agar rancangan teknologi memiliki resistansi minimal terhadap alur kerja klinis: sistem digital harus memungkinkan aliran data klinis dikonversi secara efisien menjadi keputusan dan tindakan asuhan tanpa menambah beban kerja kognitif, kelelahan digital, atau gangguan alur kerja yang tidak perlu (Jeffries et al., 2023; Wesley et al., 2019)

4. Inovasi Cerdas: Kecerdasan Buatan (AI) dan Pendukung Keputusan Klinis

Dalam hierarki pemanfaatan teknologi di praktik keperawatan mutakhir, Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning menempati lapisan lanjutan sebagai komponen kunci Clinical Decision Support Systems (CDSS) yang dirancang untuk mengolah data klinis skala besar menjadi informasi risiko yang terstruktur. Melalui model prediktif, algoritma mampu mengenali pola halus dalam himpunan Big Data dan menghasilkan estimasi probabilitas terjadinya komplikasi klinis bahkan sebelum tanda dan gejala muncul secara kasat mata, sehingga membuka peluang intervensi dini yang lebih terarah (Mikkonen et al., 2025)

Dalam konfigurasi tersebut, perawat tidak digantikan oleh sistem, tetapi berperan sebagai verifikator algoritmik yang menelaah, mengkritisi, dan menginterpretasikan keluaran CDSS sebelum menerjemahkannya ke dalam keputusan asuhan, selaras dengan prinsip "augmented intelligence" yang menempatkan teknologi sebagai pendukung, bukan pengganti, penilaian klinis manusia. Peran ini dapat dianalogikan dengan penggunaan mikroskop elektronik, di mana AI memperbesar dan memperjelas "mikro-tren" dalam parameter vital, hasil laboratorium, atau pola dokumentasi sehingga lebih mudah terdeteksi, sedangkan perawat tetap memegang otoritas profesional dalam menentukan signifikansi klinis dan langkah intervensi. Dukungan analitik tersebut memungkinkan pergeseran dari pola asuhan yang reaktif dan episodik menuju pemantauan yang lebih kontinu, proaktif, dan preventif, karena perubahan kecil dalam status kesehatan pasien dapat diidentifikasi lebih dini dan direspons dengan intervensi keperawatan yang tepat waktu (Garry Brydges, PhD, DNP, MBA, MHA, APRN, CRNA, ACNP-BC, FAANA, 2025)

5. Keamanan dan Etika Digital: Proteksi dalam Ekosistem Teknologi

Integrasi teknologi digital dalam praktik keperawatan menuntut penerapan tata kelola keamanan informasi dan etika digital yang sangat ketat agar kerahasiaan data kesehatan pasien tetap terlindungi. Di FGI, fungsi

pengawasan normatif dijalankan oleh Head of Legal yang memastikan seluruh inovasi mulai dari rekam medis elektronik hingga sistem berbasis AI mematuhi kerangka regulasi perlindungan data (misalnya prinsip kerahasiaan, integritas, dan akses terbatas) serta standar etik keperawatan. Dalam konteks ini, perawat diposisikan sebagai “penjaga gerbang” data yang wajib menerapkan praktik cybersecurity, termasuk autentikasi aman, kontrol akses, dan pelaporan insiden, sehingga sistem digital berfungsi layaknya membran sel selektif yang hanya mengizinkan aliran “nutrisi” berupa data klinis yang relevan dan menahan masuknya “patogen” berupa upaya peretasan, kebocoran, atau penyalahgunaan informasi. Kepatuhan terhadap regulasi privasi dan keamanan data medis menjadi prasyarat agar pemanfaatan teknologi tetap sejalan dengan prinsip non-maleficence dan menjaga kepercayaan pasien terhadap profesi keperawatan (Abuhammad, 2025)

Pada lapisan manajerial puncak di FGI, setiap inisiatif digitalisasi perlu disusun sebagai bagian integral dari strategi organisasi, bukan sekadar proyek teknis yang terpisah. CEO dan COO bertanggung jawab menetapkan visi, prioritas, dan arah transformasi digital misalnya fokus pada pengurangan readmisi, peningkatan keselamatan pasien, atau efisiensi operasional sementara Head of Finance menilai kelayakan investasi melalui indikator seperti penurunan angka rawat inap berulang, penghematan biaya pemeriksaan berulang, dan perbaikan kinerja berbasis value-based care. Di sisi lain, Head of Marketing mengartikulasikan kapabilitas teknologi FGI sebagai nilai tambah layanan kepada masyarakat, dengan menekankan manfaat klinis dan keamanan, bukan sekadar kecanggihan perangkat. Dalam ekosistem ini, perawat bertindak sebagai “titik konvergensi teknologi”, yaitu aktor klinis yang menghubungkan investasi infrastruktur digital dengan luaran nyata di tingkat pasien, sehingga keberhasilan inovasi diukur dari sejauh mana teknologi mempermudah perawat dalam meningkatkan keselamatan, kualitas hidup, dan pengalaman pasien, bukan semata-mata dari parameter teknis atau finansial (Cassel, Kerr, Kalman, Thomas, & Valley, 2015; Pattar et al., 2025)

H. Kesimpulan

1. Sintesis Konseptual: Keperawatan sebagai Integrator Ekosistem Kesehatan

Secara konseptual, pengelolaan penyakit kronis dan degeneratif tidak lagi dipahami sebagai rangkaian intervensi klinis yang berdiri sendiri, tetapi sebagai suatu “simfoni” pelayanan yang menempatkan perawat pada posisi dirigen utama yang mengoordinasikan seluruh elemen asuhan. Inti pokoknya adalah bahwa keberhasilan asuhan sangat ditentukan oleh pergeseran dari model

kuratif-episodik menuju pendekatan yang bersifat preventif, berkesinambungan, dan berorientasi pada pemberdayaan pasien.

Analogi ilmiah yang relevan menggambarkan perawat sebagai “Enzim Ligase” dalam biologi molekuler, yang merekatkan berbagai fragmen layanan mulai dari edukasi Diabetes, manajemen Hipertensi, hingga perawatan paliatif menjadi satu rangkaian asuhan yang terpadu dan fungsional. Tanpa fungsi integratif ini, sistem pelayanan berisiko terfragmentasi, yang pada akhirnya dapat berujung pada kegagalan terapi dan penurunan tajam kualitas hidup pasien.

2. Mekanisme Teoretis: Sinergi Bio-Manajerial dalam Struktur FGI

- a. Secara teoretis, keberhasilan manajemen penyakit kronis di institusi seperti FGI sangat ditentukan oleh kekuatan struktur internal yang menopang pelaksanaan praktik klinis sehari-hari. Premis ini menegaskan bahwa peran perawat tidak dapat dijalankan secara terisolasi tanpa dukungan sistemik dari CEO, COO, dan seluruh jajaran manajerial lain yang membentuk kerangka organisasi.
- b. Secara analogis, FGI dapat dipahami sebagai sebuah “Organisme Multiseluler”, di mana fungsi klinis perawat bertindak sebagai sel-sel yang melakukan kerja vital, sementara kelangsungan fungsinya bergantung pada sistem pendukung seperti regulasi yang diatur Head of Legal, suplai “nutrisi” berupa dana oleh Head of Finance, serta komunikasi dengan lingkungan eksternal melalui Head of Marketing. Integrasi ini membentuk suatu Homeostasis Organisasional, sehingga setiap gangguan pada kondisi pasien dapat direspons cepat melalui kebijakan operasional yang tepat sasaran dan berbasis bukti.
- c. Pada tataran aplikasi ke depan, manajemen keperawatan kronis diproyeksikan bertumpu pada sinergi antara presisi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Remote Patient Monitoring (RPM) dengan kedalaman empati manusia. Teknologi berperan memperluas “indera” perawat melalui penyediaan data yang kaya dan real-time, sementara perawat tetap memegang peran sentral sebagai penjaga martabat pasien, terutama pada kasus degeneratif yang memerlukan pendekatan paliatif. Secara konseptual, perawat dapat dianalogikan sebagai “penerjemah kode digital menjadi makna klinis”; sistem mungkin menghasilkan ribuan data mentah, namun perawat yang mengonversinya menjadi tindakan penuh kepedulian dan intervensi yang menyelamatkan nyawa. Dengan demikian, FGI diposisikan bukan semata sebagai penyelenggara layanan kesehatan berbasis teknologi

tinggi, tetapi sebagai institusi yang tetap memuliakan kemanusiaan pada setiap fase perjalanan penyakit pasien.

I. Referensi

- Abuhammad, S. (2025). *Strengthening Ethical Practices of Patient Data Confidentiality and Sharing Among Nurses in the Artificial Intelligence-Driven Healthcare Era*. <https://doi.org/10.1177/23779608251398113>
- Al-qudah, M. M., Oweidat, I. A., & Omar, S. Al. (2025). *The relationship between nursing informatics competencies and clinical decision-making among registered nurses working at tertiary hospitals*. 11, 1–11. <https://doi.org/10.1177/20552076251346015>
- Alketbi, L. B., & Nagelkerke, N. (2025). *Sustainability of evidence-based primary care programs in Abu Dhabi: impact of COVID-19*. (August). <https://doi.org/10.3389/frhs.2025.1591667>
- Alzahrani, M. S., Bakr, R. H., Khider, N. M., Ali, S., Alharbi, M., Ibrahim, K., ... Saleh, F. (2024). *Effectiveness of Nurse-Led Nutritional Counseling in Chronic Disease Management*. 7.
- Approaches, D., & Hypertension, S. (2015). *DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diet to prevent and control hypertension*. (October).
- Ariza, F., Kalra, D., & Potts, H. W. W. (2015). *How do clinical information systems affect the cognitive demands of general practitioners? Usability study with a focus on cognitive workload*. 22(4).
- Article, R. (2021). *Epidemiological transition and the dual burden of communicable and noncommunicable diseases in Zimbabwe*. 2–7. <https://doi.org/10.4103/jncd.jncd>
- Asadizaker, M. B. (2024). *Application of Kolcaba's Comfort Theory in Palliative Care: A Review Study*. 1(December 2023), 370–381.
- Ayuso-diaz, V. M., Colli-garcia, J. J., & Hernandez-pat, M. A. (2025). *Nurse-Led Educational Intervention Improves Self-Care Knowledge in Type 2 Diabetes: A Pre- Post Study Using the Diabetes Knowledge Questionnaire*. 17(7), 1–8. <https://doi.org/10.7759/cureus.87477>
- Azadi, A., Jos, F., & Canalejas, P. De. (2025). *Optimizing Clinical Decision Support System Functionality by Leveraging Specific Human-Computer Interaction Elements: Insights From a Systematic Review* Corresponding Author: 12. <https://doi.org/10.2196/69333>
- Beaudin, J., Chouinard, M., Hudon, É., & Hudon, C. (2024). *Integrated self-management support provided by primary care nurses to persons with chronic diseases and common mental disorders : a qualitative study*. 1–13.
- Berardinelli, D., Conti, A., Hasnaoui, A., Casabona, E., Martin, B., Campagna, S., &

- Dimonte, V. (2024). *Nurse-Led Interventions for Improving Medication Adherence in Chronic Diseases : A Systematic Review*. 1–26.
- Bulto, L. N., Roseleur, J., Noonan, S., Alejandra, M., Plaza, P. De, Champion, S., ... Hendriks, J. M. (2024). Effectiveness of nurse-led interventions versus usual care to manage hypertension and lifestyle behaviour : a systematic review and meta-analysis. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 23(1), 21–32. <https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvad040>
- Buric, I. (2025). Brain , Behavior , & Immunity - Health Psychoneuroimmunology of Mindfulness : What works , how it works , and for whom ? *Brain, Behavior, & Immunity - Health*, 46(November 2023), 101022. <https://doi.org/10.1016/j.bbih.2025.101022>
- Cassel, J. B., Kerr, K. M., Kalman, N. S., Thomas, J., & Valley, M. (2015). *The Business Case for Palliative Care: Translating Research Into Program Development in the U.S.* 50(6), 741–749. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.06.013>
- Chen, Y., Ho, K. Y., Zong, X., Weng, Y., & Yuan, C. (2025). *The digital intelligent precise nursing framework: theory development in health recommender system*.
- Claudia, L., Silveira, J., Aliti, G. B., Meyer, E., Silva, D., Pimentel, R. P., ... Rabelo-silva, E. R. (2019). *Effect of motivational interviewing in hypertensive patients (MIdNIgHT): study protocol for a randomized controlled trial*. 1–8.
- Couch, S. C. (2022). *Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) dietary intervention improves blood pressure and vascular health in youth with elevated blood pressure*. 77(1), 241–251. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16156>
- Crasto, W. (2021). *P r e v e n t i o n o f M i c r o v a s c u l a r Complications of Diabetes*. 50, 431–455. <https://doi.org/10.1016/j.ecl.2021.05.005>
- Dong, C., Ji, Y., Fu, Z., Qi, Y., Yi, T., Yang, Y., ... Sun, H. (2025). *iScience Perspective Precision management in chronic disease : An AI empowered perspective on medicine-engineering crossover*. 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112044>
- El-malahi, O., Mohajeri, D., Bäuerle, A., & Mincu, R. I. (n.d.). *The Influence of eHealth Stress Management Interventions on Psychological Health Parameters in Patients With Cardiovascular Disease : Systematic Review and Meta- Analysis*. 27. <https://doi.org/10.2196/67118>
- Emaliyawati, E., & Ibrahim, K. (2025). *A Systematic Review of Internet-Based Remote Patient Monitoring Systems for Chronic Disease Management in Asian*. (August).
- Eshtaya, R., Ayed, A., Malak, M. Z., & Shehadeh, A. (2025). *The association between*

diabetes management self-efficacy and quality of life among Palestinian patients with type 2 diabetes. 1–9.

- Fang, H., Cui, F., Zhao, Y., Qian, Q., Yong, A., Lan, P., & Huang, C. (2025). *Transforming Alzheimer ' s disease nursing: integrating holistic care , innovative interventions , and evidence-based practices for enhanced patient outcomes.* 2050(September), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1624310>
- Floriancic, N., & Donelle, L. (2024). *Chronic Disease Management in a Nurse Practitioner-Led Clinic: An Interpretive Description Study.* <https://doi.org/10.1177/23779608241299292>
- Garry Brydges, PhD, DNP, MBA, MHA, APRN, CRNA, ACNP-BC, FAANA, F. (2025). *Artificial Intelligence in Nursing Practice: Decisional Support, Clinical Integration, and Future Directions.* (2), 1–16.
- Gloriene, V., Pujante, B., & Sami, W. (2025). *Nursing Interventions in Palliative Care for Advanced Dementia : A Systematic Review of Symptom , Relief , Comfort , and Caregiver Support.* (September).
- Goswami, N. (2024). *A Dual Burden Dilemma: Navigating the Global Impact of Communicable and Non-Communicable Diseases and the Way Forward.* 12(03). <https://doi.org/10.55489/ijmr.11202412>
- Grady, T. P., Rollins, S., & Bailey, K. D. (2025). Nursing Professional Governance: The Structure to Enable Professional Practice. *Nurse Leader*, 23(6), 102512. <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2025.102512>
- Grudniewicz, A., Steele, C., Pauline, G., Jan, B., & James, D. M. (2023). Operationalizing the Chronic Care Model with Goal - Oriented Care. *The Patient - Patient-Centered Outcomes Research*, 16(6), 569–578. <https://doi.org/10.1007/s40271-023-00645-8>
- Gupta, E., & Patel, P. (2024). *Palliative care in dementia.* 13(I), 791–807. <https://doi.org/10.21037/apm-23-503>
- Hasanah, I., Lei, C. P., Haikal, Z., Sari, A. S., & Soares, D. (2025). *Music Therapy and Psychoneuroimmunological Markers in Children With Chronic Disease: A Systematic Review.* 18(1), 124–137.
- Hatam, N., Askarian, M., Taherifard, E., Ahmadkhani, A., Golabi, F., & Bordbar, S. (2025). *Exploring patient-centered care delivery in outpatient settings for older adults : a scoping review and recommendations for implementation in countries with low and middle income.*
- Hennrich, P., Bölter, R., & Wensing, M. (2020). *Influences on Physicians ' Participation in Coordinated Ambulatory Cardiology Care : A Mixed-Methods Study.* 20(4), 1–19.
- Hossain, A., Hasan, M., Rahman, T., Almarzooqi, A., & Rahman, S. A. (2025).

Palliative care needs and quality of life among adults with advanced chronic illnesses in low - income communities of Bangladesh. *BMC Palliative Care*. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01643-9>

- Huang, L., Li, Q., Wu, J. H. Y., Tian, M., Yin, X., Yu, J., ... Neal, B. (2024). *The contribution of sodium reduction and potassium increase to the blood pressure lowering observed in the Salt Substitute and Stroke Study*. (January). <https://doi.org/10.1038/s41371-024-00896-4>
- Ismail, H. A., Kotp, M. H., Ahmed, H., Basyouny, A., Ezz, A., Abd, E., ... Aly, A. (2025). *Empowering nurse leaders: leveraging financial management practices to foster sustainable healthcare – a mixed-methods study*.
- Isnaini, N., Sari, F., Dewi, T., & Madyaningrum, E. (2025). *Blood pressure impact of dietary practices using the DASH method: a systematic review and meta-analysis*. 1–11.
- Izumi, S., Mood, L., Velk, L., Szper, C., Fifield, A., Ayala, D., & Dawson, W. D. (2025). *Key components of chronic care management programs: qualitative descriptions of care managers ' practice*. 1–9.
- J E Epping-Jordan, S D Pruitt, R Bengoa, E. H. W. (2004). *Improving the quality of health care for chronic conditions*. 299–305. <https://doi.org/10.1136/qshc.2004.010744>
- Jati, R. P., Tinggi, S., & Kesehatan, I. (2024). *Nursing care for management of hold relax to reduce pain in elderly with osteoarthritis at ikedaen hospital japan*. 5(1), 311–314.
- Jeffries, M., Salema, E., Laing, L., Shamsuddin, A., Sheikh, A., Avery, T., ... Keers, R. N. (2023). *Using sociotechnical theory to understand medication safety work in primary care and prescribers ' use of clinical decision support: a qualitative study*. 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-068798>
- Kangeswari, P., & Hm, M. B. A. (2022). *Effectiveness of Nurse-led Intervention on Quality of Life of Patients with Knee Osteoarthritis*. 9, 1–12. <https://doi.org/10.1177/23743735221098254>
- Kim, Jae-hak, Kim, J., & Youn, B. (n.d.). *Using a Technology Acceptance Model to Explore the Intention to Use Digital Health Technologies Among People With Disabilities: Cross-Sectional Survey Study*. 27. <https://doi.org/10.2196/79595>
- Kim, Jin-ho, & Lee, S. B. (2025). *Evaluation of Activities of Daily Living: Current Insights and Future Horizons*. 29(2), 143–158.
- Kongkar, R., Ruksakulpiwat, S., Phianhasin, L., Benjasirisan, C., Niyomyart, A., Ahmed, B. H., ... Adams, J. (2025). *The Impact of Interdisciplinary Team-Based Care on the Care and Outcomes of Chronically Ill Patients: A Systematic Review*. (January), 445–457.
- Li, S., Craig, S., Mitchell, G., Thompson, G., Stark, P., Fitzsimons, D., & Creighton, L.

- (2025). *Nurse-Led Strategies for Lifestyle Modification to Control Hypertension in Older Adults: A Scoping Review*. (Jnc 7).
- Lin, Y., Zhou, Y., & Chen, C. (2023). Interventions and practices using Comfort Theory of Kolcaba to promote adults ' comfort : an evidence and gap map protocol of international effectiveness studies. *Systematic Reviews*, 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13643-023-02202-8>
- Lin, Y., Zhou, Y., Chen, C., Yan, C., & Gu, J. (2024). *Application of Kolcaba 's Comfort Theory in healthcare promoting adults ' comfort: a scoping review*. 1–10. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-077810>
- Lunn, C., Donnell, C. O., Maccurtain, S., & Coffey, A. (2025). International Journal of Nursing Studies Advances Realigning identity : Nurse executives ' experiences within a new socio-professional group – A classic grounded theory study. *International Journal of Nursing Studies Advances*, 9, 100367. <https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2025.100367>
- Lv, Y., Aihemaiti, G., & Guo, H. (2024). *Effect of Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) on Patients with Metabolic Syndrome and Its Potential Mechanisms*. (August), 3103–3110.
- Marshall, S. M., & Flyvbjerg, A. (2006). *Clinical review Prevention and early detection of vascular complications of diabetes*. 333(September), 475–480.
- Mccain, N. L., Munjas, B. A., Munro, C. L., Jr, R. K. E., Jo, L., Robins, W., ... Cochran, K. L. (2008). *Effects of Stress Management on PNI-Based Outcomes in Persons With HIV Disease*. 26(2), 102–117.
- Metlock, F. E., Hinneh, T., Benjasirisan, C., Alharthi, A., Ogungbe, O., Himmelfarb, C. R., & Commodore-mensah, Y. (2025). *Impact of Social Determinants of Health on Hypertension Outcomes: A Systematic Review*. 81(8), 1675–1700. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.22571>.Impact
- Mikkonen, K., Tuunainen, S., Oikarinen, A., Jansson, M., Woo, B., Zhou, W., ... Juntunen, J. (2025). *Artificial Intelligence Technologies Supporting Nurses ' Clinical Decision- - Making: A Systematic Review*. 1–16. <https://doi.org/10.1111/jocn.70156>
- Na, A., Bradt, J., Gliebus, G. P., Fritz, J. A., & Gitlin, L. (2025). *Exercise-Based Pain Interventions for People with Dementia Using a Biopsychosocial-Environmental (BPSE) Model*. 1–12.
- Naranjee, N., Ngxongo, T. S. P., Sibiyi, M. N., & Africa, S. (n.d.). *Financial management roles of nurse managers in selected public hospitals in KwaZulu-Natal province , South Africa*. 1–8.
- Pasricha, A., Deinstadt, R. T. M., Moher, D., Killoran, A., Rourke, S. B., & Kendall, C. E. (2012). *Chronic Care Model Decision Support and Clinical Information Systems Interventions for People Living with HIV: A Systematic Review*. (c),

- 127–135. <https://doi.org/10.1007/s11606-012-2145-y>
- Pattar, B. S. B., Ackroyd, A., Sevinc, E., Hecker, T., Miranda, K. T., McClurg, C., & Weekes, K. (2025). *Electronic Health Record Interventions to Reduce Risk of Hospital Readmissions A Systematic Review and Meta-Analysis*. 8(7), 1–20. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.21785>
- Pawelczyk, J., Kraus, M., Voigtlaender, S., & Siebenlist, S. (2025). *Advancing Musculoskeletal Care Using AI and Digital Health Applications: A Review of Commercial Solutions*. <https://doi.org/10.1177/15563316251341321>
- Peyroteo, M. (2025). *Technological Forecasting & Social Change Strategic scenarios for the digitalisation of chronic disease care management: A 10-year foresight case study in Lisbon ' s primary healthcare setting*. 220(July). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2025.124290>
- Qama, E., Rubinelli, S., & Diviani, N. (2022). *Factors influencing the integration of management in daily life routines in chronic conditions: a scoping review of qualitative evidence*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-066647>
- Randall, S., Afenigus, A. D., & Sinshaw, M. A. (2025). *Developing nursing approaches across the chronic illness trajectory: a grounded theory study of care from diagnosis to end-of-life in Western Amhara , Ethiopia*. (June). <https://doi.org/10.3389/frhs.2025.1502763>
- Rasaei, N., Adivi, A. G., Jafrasteh, S., Norouzirad, R., & Bahadoran, Z. (2025). *Effect of Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet on blood pressure indices and urinary metabolites in children with overweight and obesity: an 8-week triple-blind randomized controlled trial*. 1–12.
- Reis, J. C., Travado, L., & Antoni, M. H. (2025). *International Journal of Clinical and Health Psychology Advancing health psychology research in oncology: Biobehavioral models , stress pathways , and stress-management interventions for cancer patients*. 25(June).
- Robles-aguilar, P. (2025). *Digital Health Experiences of Primary Care Nurses: A Qualitative Meta-synthesis*. 1–11. <https://doi.org/10.1111/inr.70069>
- Sarfika, R. (2025). *Self-care behavior among adult patients with hypertension in Padang , West Sumatra , Indonesia : A cross-sectional study*. 9(6), 595–602.
- Shah, R., & Upadhyay, A. (2025). *The Impact of Socioeconomic Status on Hypertension and Diabetes Management*. 1(1), 10–14.
- Shan, Y., Shang, J., Yan, Y., & Ye, X. (2023). Workflow interruption and nurses ' mental workload in electronic health record tasks: An observational study. *BMC Nursing*, 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01209-9>
- Smith, Y., Garcia-torres, R., Coughlin, S. S., Ling, J., Marin, T., & Smith, Y. (n.d.). *Effectiveness of Social Cognitive Theory – Based Interventions for Glycemic Control in Adults With Type 2 Diabetes Mellitus: Protocol for a Systematic*

Review and Meta-Analysis Corresponding Author: 9, 1–11.
<https://doi.org/10.2196/17148>

Sohl-donguines, Z., & Coronado, R. S. (2025). *Patient Safety Culture and Attitudes and The Interprofessional Collaboration Among Healthcare Workers in A Government Hospital. XII*(2454), 1823–1858. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>

Watson, B. N., Estenson, L., Eden, A. R., Gerstein, M. T., & Carney, M. T. (2024). *Person-Centered Care Planning for People Living With or at Risk for Multiple Chronic Conditions. 7*(10), 1–15.
<https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.39851>

Wesley, D. B., Schubel, L., Hsiao, C., Burn, S., Howe, J., Kellogg, K., ... Ratwani, R. (2019). A socio-technical systems approach to the use of health IT for patient reported outcomes : Patient and healthcare provider perspectives ☆. *Journal of Biomedical Informatics, 100*(October 2018), 100048.
<https://doi.org/10.1016/j.yjbinox.2019.100048>

World Alzheimer Report 2025. (2025).

Yata, A., Ohta, R., Ryu, Y., Iwashita, Y., & Sano, C. (2025). *Community Nursing Interventions and Their Impact on Health Outcomes: A Systematic Review of International Evidence. 17*(1), 1–13. <https://doi.org/10.7759/cureus.89575>

PROFIL PENULIS



Najihah, S. Kep., Ns., M. Kep. Lahir di Ujung Pandang, 06 Januari 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muslim Indonesia tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 sebagai Dosen Tetap Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muslim Indonesia, di tahun yang sama penulis juga bekerja sebagai Perawat di RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. Saat ini penulis bekerja sebagai

Dosen di Universitas Borneo Tarakan, mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar, dan Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai peneliti, penulis buku dan aktif mengikuti kegiatan ilmiah. Penulis juga aktif dalam organisasi profesi dan merupakan pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DPK Pendidikan Tarakan dan Himpunan Perawat Medikal Bedah (HIPMEBI) Provinsi Kalimantan Utara. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: najihah@borneo.ac.id

Motto: "Tidak ada yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya"



Fransiska Tatto Dua Lembang, S.Kep., Ns., M.Kes. Lahir di Kendari, 18 Agustus 1985. Penulis menempuh Pendidikan pada Jenjang Vokasi dikampus Akademik Keperawatan Nusantara Jaya Makassar pada tahun 2004-2006, dan melanjutkan Pendidikan pada jenjang Sarjana dan Profesi Ners Di Universitas Respati Yogyakarta Tahun 2008-2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea Makassar pada tahun 2012 dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun

2011-2020 mulai bekerja sebagai pendidik dikampus Universitas Mandala Waluya Sulawesi Tenggara. Pada Tahun 2020 – sekarang penulis bekerja di Stikes Wira Husada Yogyakarta dan mengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat, keperawatan bencana, manajemen keperawatan dan keperawatan medical bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal ilmiah, publikasi penelitian, seminar, workshop dan memiliki HAKI dari karya yang dihasilkan serta pernah mendapat hibah pengabdian dikti. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hafransiska@gmail.com

Motto: "Hidup dalam Iman, Melayani dengan Kasih."

PROFIL PENULIS



Ns. Jumilia, S.Kep, M.Kep, Ph.D Lahir di Dumai, 27 November 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada Program Studi Keperawatan Poltekkes Kemenkes Padang Tahun 2005, Program Studi Ilmu Keperawatan S1 Universitas Andalas Padang Tahun 2011, Program Studi Profesi Ners Universitas Andalas Padang Tahun 2012, Fakultas Magister Keperawatan Universitas Andalas tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 Keperawatan pada Lincoln University Malaysia pada 2021 dan lulus tahun pada tahun 2025. Riwayat pekerjaan bahwa penulis juga pernah bekerja di R.S Awal Bros Pekanbaru Tahun 2009 dan menjadi Dosen bidang Keperawatan Jiwa di Perguruan Tinggi sejak 2013 hingga sekarang (lebih kurang 12 Tahun sampai Sekarang). Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), sebagai Narasumber Ujian Kompetensi Keperawatan, Narasumber KomInfo, Pengawas Lokal UKNI, Penulis buku seperti buku guided imagery, buku NAPZa, buku ujian kompetensi (Ukom), buku OSCE keperawatan, publikasi jurnal scopus, non scopus dan sinta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: liajumilia1987@gmail.com

Motto: "Hal yang membedakan orang biasa-biasa saja dengan orang sukses itu bukanlah pengetahuan mereka, melainkan KEGIGIHAN mereka dalam melakukan dan mendapatkan sesuatu "

PROFIL PENULIS



Dr. Muh. Anwar. Hafid, S. Kep., Ns., M.Kes dilahirkan di Makassar, 15 Mei 1962, menyelesaikan pendidikan Diploma III Keperawatan tahun 1995 dan menyelesaikan Pendidikan studi sarjana keperawatan dan Pendidikan Profesi di FK-Unhas tahun 2004 dan melanjutkan pendidikan Megister BioMedik di FK-Unhas pada tahun 2007 dan menyelesaikan Pendidikan Doktoral Ilmu Kedokteran di FK-Unhas tahun 2015.

Mengampu mata kuliah ilmu Biomedik Dasar dan Ilmu Dasar Keperawatan serta Keperawatan Medikal Bedah Selama ini terlibat aktif sebagai dosen pembimbing mahasiswa pada program Profesi Ners pada Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pernah menjadi perawat pelaksana di Rumah Sakit Haji Makassar di ruangan UGD, Recovery Room dan di ruang penyakit Dalam dan pada tahun 2006 menjadi Kepala Seksi Keperawatan di RS Haji Makassar.

E-mail: muhammadanwarhafid1562@gmail.com

Sinopsis

Bunga rampai *Keperawatan Klinik Modern: Pendekatan Holistik dan Berbasis Bukti dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia* menyajikan rangkaian pemikiran dan praktik keperawatan yang selaras dengan kebutuhan layanan kesehatan masa kini. Buku ini menempatkan pasien sebagai pusat asuhan dengan pendekatan holistik—memandang aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan budaya—serta menekankan pentingnya evidence-based practice dalam setiap pengambilan keputusan klinik. Dengan bahasa yang aplikatif dan relevan bagi konteks Indonesia, buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa, perawat klinis, dan pendidik memperkuat kompetensi, penalaran klinik, serta mutu pelayanan keperawatan di berbagai tatanan layanan.

Bab-bab awal mengangkat area klinik yang paling sering dihadapi dalam praktik. Chapter 1 membahas **keperawatan medikal bedah** melalui inovasi **manajemen nyeri** serta **perawatan luka**, mulai dari prinsip dasar hingga penerapan yang mendukung pemulihan pasien. Chapter 2 mengupas **keperawatan gawat darurat dan kritis**, mencakup konsep, penerapan pendekatan holistik dan berbasis bukti, **PPGD**, **triage**, serta pentingnya **kolaborasi tim resusitasi**, disertai penekanan pada keselamatan pasien dan etika dalam situasi emergensi. Chapter 3 berfokus pada **keperawatan maternitas** yang menyoroti urgensi pelayanan holistik pada masa kehamilan, nifas, dan neonatal, termasuk integrasi asuhan, kolaborasi interprofesional, serta strategi implementasi berbasis bukti yang dapat diterapkan di layanan.

Selanjutnya, Chapter 4 memperkuat dimensi kesehatan mental melalui kajian **keperawatan jiwa**, mencakup **manajemen stres**, **ansietas**, dan berbagai pendekatan terapi keperawatan yang mendukung pemulihan dan kualitas hidup pasien. Chapter 5 menawarkan perspektif mutakhir mengenai intervensi keperawatan dalam **manajemen penyakit kronis dan degeneratif**, berlandaskan **Chronic Care Model**, peran strategis perawat pada kondisi spesifik seperti **hipertensi**, integrasi konseling nutrisi sebagai intervensi non-farmakologis, penguatan manajemen layanan, hingga pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam asuhan. Dengan struktur yang dilengkapi referensi dan glosarium pada bab tertentu, bunga rampai ini diharapkan menjadi rujukan komprehensif untuk mendorong praktik keperawatan yang lebih adaptif, aman, dan berdampak nyata bagi pasien serta sistem kesehatan di Indonesia.

Bunga rampai Keperawatan Klinik Modern: Pendekatan Holistik dan Berbasis Bukti dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia menyajikan rangkaian pemikiran dan praktik keperawatan yang selaras dengan kebutuhan layanan kesehatan masa kini. Buku ini menempatkan pasien sebagai pusat asuhan dengan pendekatan holistik—memandang aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan budaya—serta menekankan pentingnya evidence-based practice dalam setiap pengambilan keputusan klinik. Dengan bahasa yang aplikatif dan relevan bagi konteks Indonesia, buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa, perawat klinis, dan pendidik memperkuat kompetensi, penalaran klinik, serta mutu pelayanan keperawatan di berbagai tatanan layanan.

Bab-bab awal mengangkat area klinik yang paling sering dihadapi dalam praktik. Chapter 1 membahas keperawatan medikal bedah melalui inovasi manajemen nyeri serta perawatan luka, mulai dari prinsip dasar hingga penerapan yang mendukung pemulihan pasien. Chapter 2 mengupas keperawatan gawat darurat dan kritis, mencakup konsep, penerapan pendekatan holistik dan berbasis bukti, PPGD, triage, serta pentingnya kolaborasi tim resusitasi, disertai penekanan pada keselamatan pasien dan etika dalam situasi emergensi. Chapter 3 berfokus pada keperawatan maternitas yang menyoroti urgensi pelayanan holistik pada masa kehamilan, nifas, dan neonatal, termasuk integrasi asuhan, kolaborasi interprofesional, serta strategi implementasi berbasis bukti yang dapat diterapkan di layanan.

Selanjutnya, Chapter 4 memperkuat dimensi kesehatan mental melalui kajian keperawatan jiwa, mencakup manajemen stres, ansietas, dan berbagai pendekatan terapi keperawatan yang mendukung pemulihan dan kualitas hidup pasien. Chapter 5 menawarkan perspektif mutakhir mengenai intervensi keperawatan dalam manajemen penyakit kronis dan degeneratif, berlandaskan Chronic Care Model, peran strategis perawat pada kondisi spesifik seperti hipertensi, integrasi konseling nutrisi sebagai intervensi non-farmakologis, penguatan manajemen layanan, hingga pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam asuhan. Dengan struktur yang dilengkapi referensi dan glosarium pada bab tertentu, bunga rampai ini diharapkan menjadi rujukan komprehensif untuk mendorong praktik keperawatan yang lebih adaptif, aman, dan berdampak nyata bagi pasien serta sistem kesehatan di Indonesia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7556-51-6



9

786347

556516